
Anatomia Dental

Componentes e Faces

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Componentes e Faces 3

01

COMPONENTES E FACES

Componentes e Faces

Estrutura do Dente

PONTOS-CHAVE

Coroa: visível na cavidade bucal

Colo: junção coroa/raiz

Raiz: inserida no alvéolo, sustenta o dente

Componentes histológicos

Esmalte (coroa)

Dentina (estrutura interna)

Polpa (tecido mole, feixe vâsculo-nervoso)

Cemento (reveste a raiz)

Ligamento periodontal

Osso alveolar

Gengiva

FACES Dentárias

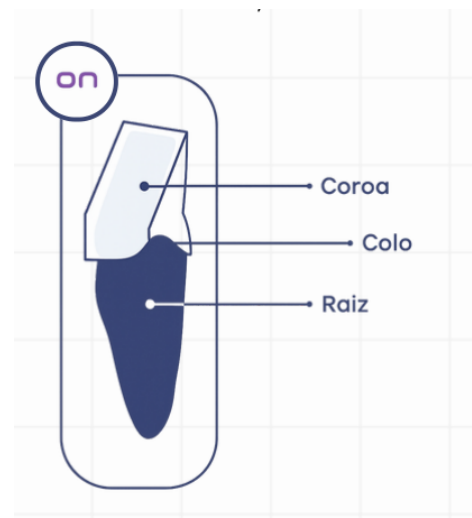
Vestibular (ou labial/bucal): voltada para fora (lábios ou bochechas)

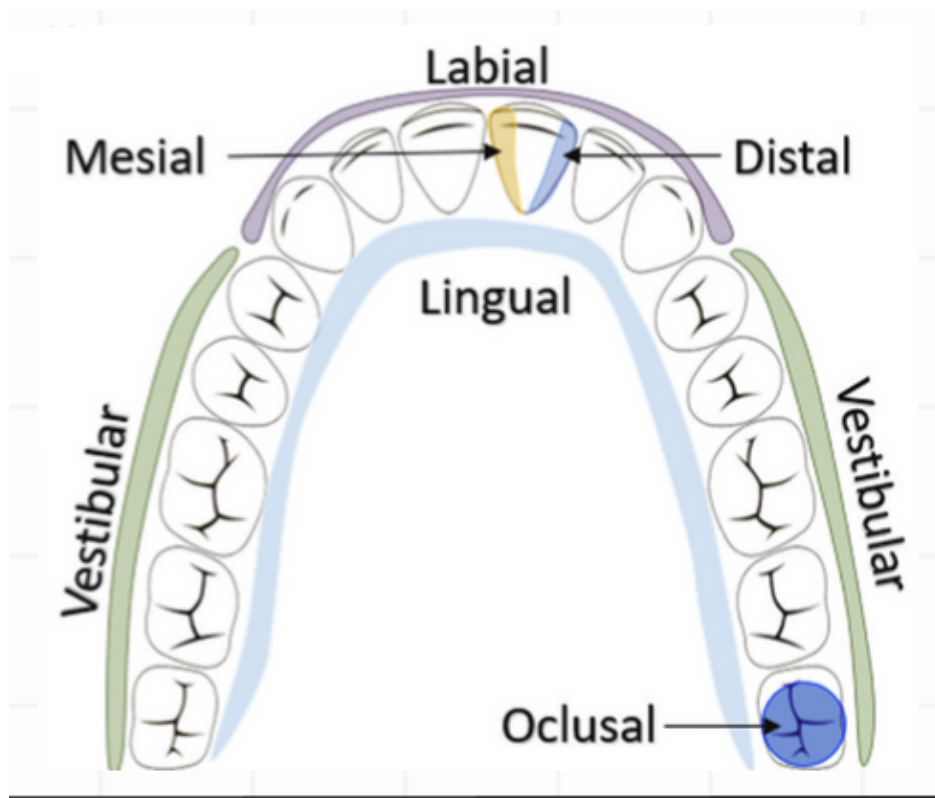
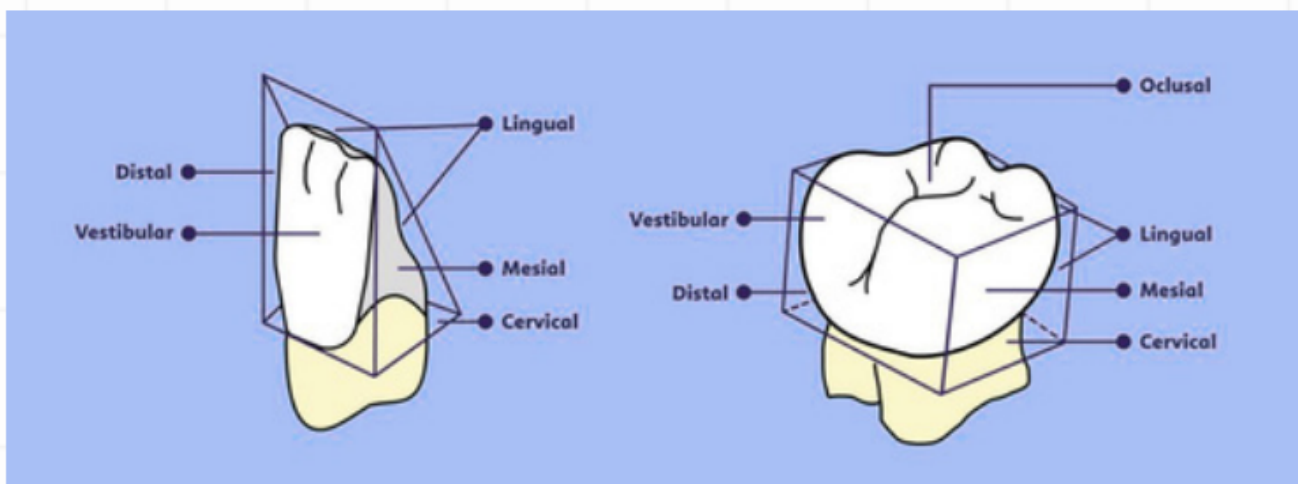
Lingual/palatina: voltada para a língua ou palato

Mesial: mais próxima da linha média

Distal: mais distante da linha média

Oclusal/Incisal: superfície mastigatória





ANOTAÇÕES

Anatomia Dental

Dentições e Nomenclaturas

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Dentição Decídua	5
03 Dentição Permanente	7
04 Arcadas Dentárias	8
05 Classificação dos Dentes	9
06 Nomenclatura Dental	10
07 Sistema FDI	11
08 Sistema Palmer	12
09 Sistema Universal	13
10 Cronologia da Erupção	14
11 Anatomia Externa dos Dentes	16
12 Anatomia Interna dos Dentes	17
13 Faces do Dente	18

01

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Introdução

A dentição humana corresponde ao conjunto de dentes presentes na cavidade oral e representa uma das estruturas mais importantes do sistema estomatognático. Os dentes desempenham funções essenciais relacionadas à **mastigação, fala, estética facial e deglutição**. A mastigação adequada é indispensável para o início do processo digestivo, pois os dentes realizam a fragmentação mecânica dos alimentos, aumentando sua superfície de contato para ação das enzimas digestivas. Além disso, os dentes auxiliam diretamente na pronúncia correta de diversos fonemas e contribuem para sustentação dos músculos faciais, influenciando significativamente a aparência estética e a autoestima do indivíduo.

O **desenvolvimento dos dentes** inicia-se ainda na vida intrauterina através de um processo denominado odontogênese. Esse processo ocorre por meio da interação entre células ectodérmicas e mesenquimais e é dividido em fases específicas: lâmina dentária, broto, capuz, campânula e mineralização. Durante essas etapas ocorre a diferenciação celular responsável pela formação das estruturas dentárias. Qualquer alteração genética, nutricional ou sistêmica nesse período pode provocar anomalias como agenesias, alterações de forma, dentes supranumerários ou defeitos de mineralização.

Os dentes são compostos por tecidos especializados altamente resistentes. O esmalte dentário é o tecido mais mineralizado do corpo humano e possui função protetora contra desgaste mecânico e ação química. A dentina constitui a maior parte da estrutura do dente e apresenta sensibilidade devido à presença de túbulos dentinários. Internamente localiza-se a polpa dentária, tecido conjuntivo vascularizado e inervado responsável pela nutrição e vitalidade dental. Já o cimento recobre a raiz e participa da fixação do elemento dental ao osso alveolar por meio do ligamento periodontal. A integridade dessas estruturas garante funcionalidade, resistência e longevidade aos dentes.

Funções principais da dentição: Mastigação Fonação Estética facial Deglutição Sustentação muscular facial





ANOTAÇÕES

02

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Dentição Decídua

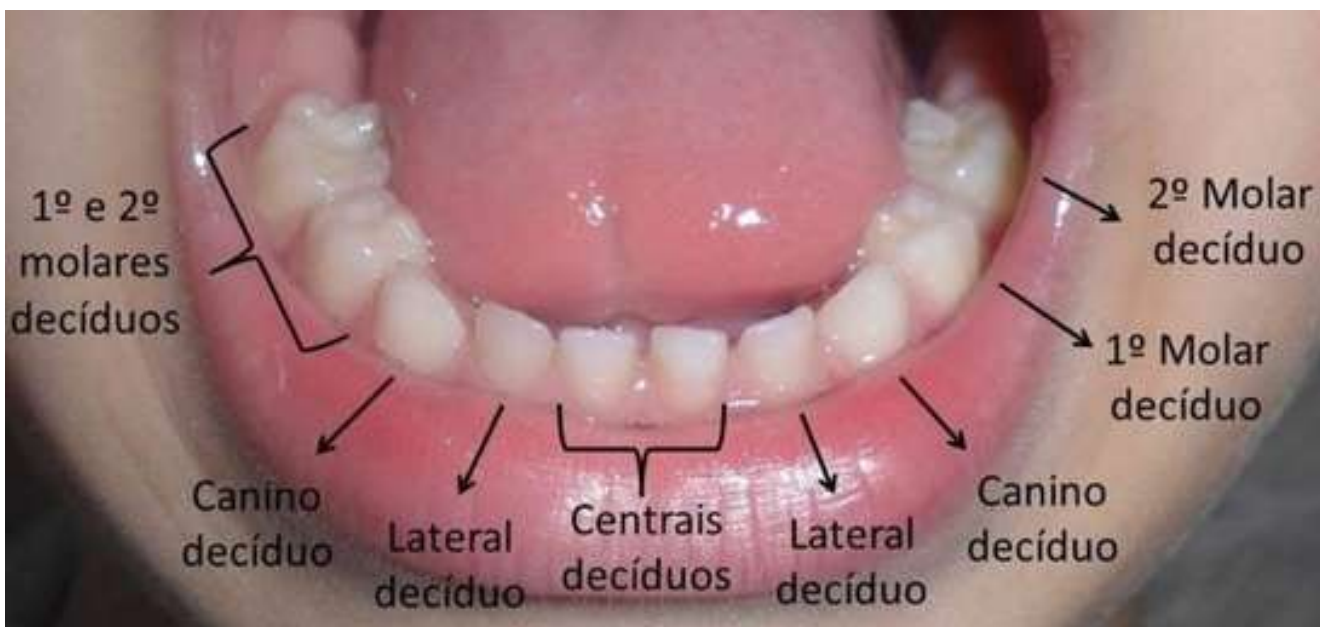
A dentição decídua, também conhecida como dentição temporária ou “dentição de leite”, corresponde à primeira dentição do ser humano. Ela é composta por 20 dentes distribuídos igualmente entre as arcadas superior e inferior. Essa dentição possui: • **8 incisivos**; • **4 caninos**; • **8 molares**.

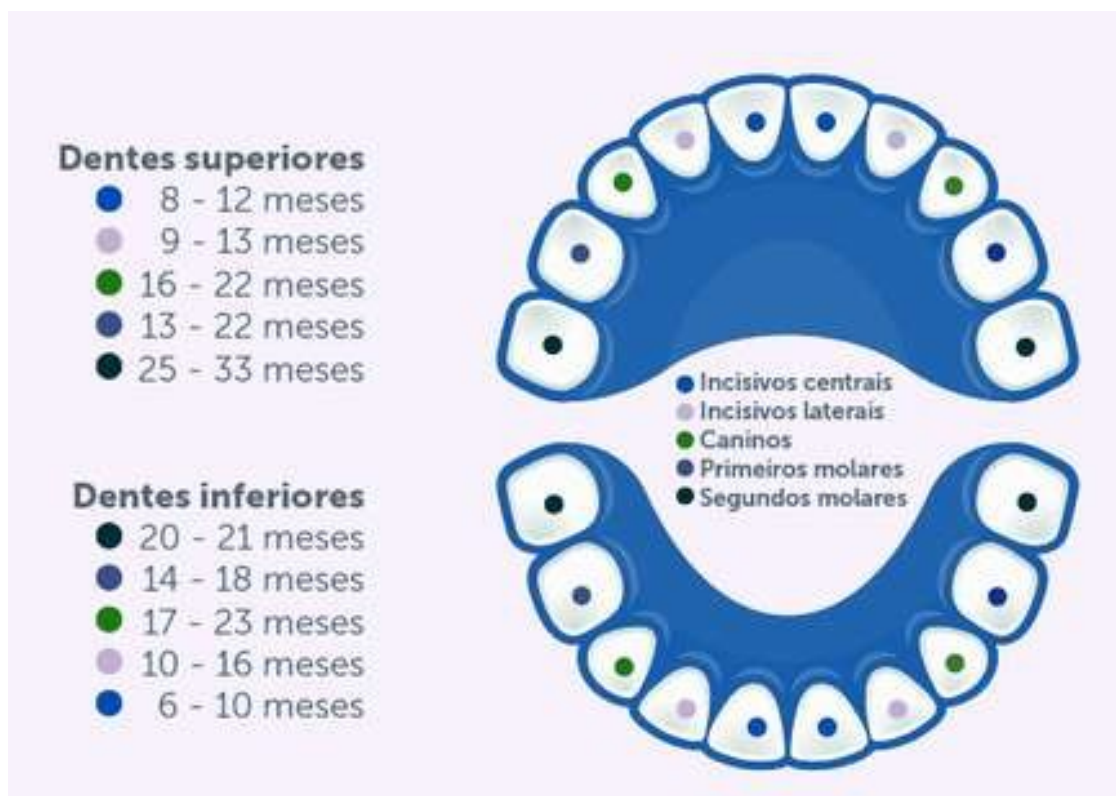
Os **pré-molares** não existem nessa fase do desenvolvimento. Os dentes decíduos apresentam características anatômicas próprias que os diferenciam dos dentes permanentes. As **coroas** são menores e mais arredondadas, o esmalte apresenta menor espessura e menor mineralização, e a coloração tende a ser mais clara e esbranquiçada. As **raízes** dos molares decíduos são mais abertas e divergentes para permitir espaço adequado ao desenvolvimento dos dentes permanentes.

A erupção dos dentes decíduos inicia-se aproximadamente aos **6 meses de idade**, geralmente pelos incisivos centrais inferiores. O processo eruptivo ocorre gradualmente até cerca dos 30 meses, quando a dentição temporária encontra-se completa. A sequência eruptiva normalmente segue: • **incisivos centrais**; • **incisivos laterais**; • **primeiros molares**; • **caninos**; • **segundos molares**.

Durante a erupção podem surgir sintomas leves como irritabilidade, aumento da salivagem e desconforto gengival. Entretanto, manifestações sistêmicas intensas não são consideradas fisiológicas.

Apesar de serem temporários, os dentes decíduos possuem papel fundamental no desenvolvimento infantil. Eles auxiliam na mastigação, no aprendizado da fala, no desenvolvimento ósseo facial e na manutenção do espaço necessário para erupção correta dos dentes permanentes. A perda precoce desses dentes pode gerar problemas ortodônticos importantes, incluindo apinhamento, perda de espaço e desvios eruptivos. Além disso, infecções em dentes decíduos podem comprometer os germes dos dentes permanentes em formação.





ANOTAÇÕES

03

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Dentição Permanente

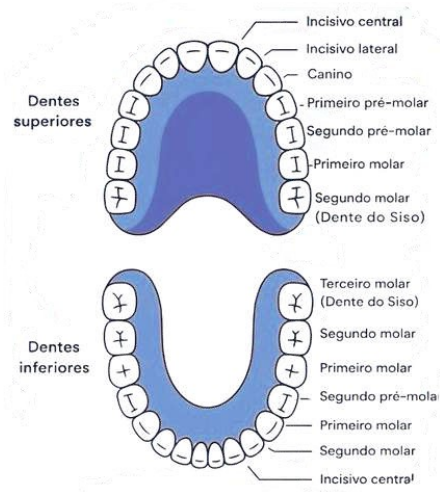
A dentição permanente corresponde à dentição definitiva do ser humano e substitui gradativamente os dentes decíduos durante a infância e adolescência. É composta por **32 dentes**: • 8 incisivos; • 4 caninos; • 8 pré-molares; • 12 molares.

Os terceiros molares, conhecidos como dentes do siso, apresentam grande variação quanto à forma, tamanho e erupção, podendo permanecer inclusos ou até ausentes. A dentição permanente inicia sua erupção aproximadamente aos 6 anos de idade, geralmente com os primeiros molares permanentes e os incisivos centrais inferiores. O processo eruptivo completo pode prolongar-se até os 21 anos.

Os dentes permanentes apresentam estrutura mais resistente que os dentes decíduos. O esmalte é mais espesso e altamente mineralizado, as raízes são mais robustas e a anatomia coronária é mais complexa. Essas características permitem maior resistência às forças mastigatórias intensas exercidas ao longo da vida adulta. C

Dentes de Leite

Dentes Permanentes



ANOTAÇÕES

04

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Arcadas Dentárias

As arcadas dentárias correspondem aos conjuntos de dentes localizados nos ossos maxilares:

PONTOS-CHAVE

maxila → arcada superior;
mandíbula → arcada inferior.

Os dentes distribuem-se em quatro quadrantes:

superior direito;
superior esquerdo;
inferior esquerdo;
inferior direito.

Essa divisão facilita a identificação dos elementos dentários e a organização clínica dos tratamentos odontológicos.

A relação funcional entre as arcadas recebe o nome de oclusão. Uma oclusão equilibrada permite distribuição adequada das forças mastigatórias, estabilidade muscular e proteção das articulações temporomandibulares. O correto encaixe entre os dentes superiores e inferiores favorece eficiência mastigatória e estabilidade funcional do sistema estomatognático.

Arcadas

Superior

DireitaEsquerda

Inferior

Superior

Inferior

Superior

Inferior



ANOTAÇÕES

05

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Classificação dos Dentes

Os dentes humanos são classificados de acordo com suas características anatômicas e funções mastigatórias em quatro grupos principais: incisivos, caninos, pré-molares e molares. Essa diferenciação permite que cada grupo execute funções específicas durante a mastigação e contribua para equilíbrio funcional da oclusão.

Os **incisivos** localizam-se na região anterior das arcadas dentárias e possuem bordas incisais cortantes. Sua principal função é cortar os alimentos durante o início do processo mastigatório. Além disso, possuem grande importância estética e fonética. Os incisivos centrais superiores, por exemplo, desempenham papel fundamental na harmonia do sorriso e na pronúncia de diversos sons da fala.

Os **caninos** apresentam anatomia pontiaguda e raízes longas e resistentes. São considerados os dentes mais fortes da arcada dentária devido à sua capacidade de suportar forças laterais intensas. Sua principal função é rasgar alimentos e orientar movimentos mandibulares durante lateralidade. A chamada “guia canina” protege os dentes posteriores contra desgastes excessivos.

Os **pré-molares** possuem características intermediárias entre caninos e molares. Suas cúspides auxiliam no esmagamento e trituração inicial dos alimentos. Já os **molares** apresentam coroas amplas, múltiplas cúspides e raízes robustas, sendo especializados na trituração eficiente dos alimentos durante a mastigação final.

Classificação funcional: Incisivos → corte Caninos → rasgamento Pré-molares → esmagamento Molares → trituração

alalal rrrtrtrl laaennerr oolateeta rmm l c caol a--vovovoo lom oléénoiiivn- mprpriisissinié ° nncncncciapr
1°21°alllnC° CI1



ANOTAÇÕES

06

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Nomenclatura Dental

A nomenclatura dental consiste em sistemas padronizados utilizados para identificar individualmente cada elemento dental. Esses sistemas são fundamentais para comunicação entre profissionais e para documentação clínica precisa. A correta identificação dos dentes permite registro adequado de:

PONTOS-CHAVE

- restaurações;
- extrações;
- tratamentos endodônticos;
- cirurgias;
- alterações patológicas.

Sem uma nomenclatura padronizada, a comunicação odontológica seria extremamente limitada e sujeita a erros clínicos graves.

Diversos sistemas de nomenclatura foram desenvolvidos ao longo da história da odontologia. Entre os mais importantes destacam-se:

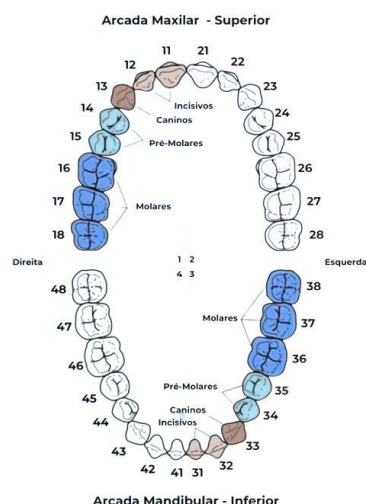
Sistema FDI;

Sistema Universal;

Sistema Palmer.

Cada sistema possui metodologia própria para identificação dental, sendo utilizado conforme o país, instituição acadêmica ou especialidade odontológica.

Com a evolução tecnológica e digitalização dos prontuários, a nomenclatura dental tornou-se ainda mais importante. Atualmente, sistemas digitais dependem da padronização das informações para organização adequada dos dados clínicos e integração entre diferentes áreas da odontologia



ANOTAÇÕES

07

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Sistema FDI

O Sistema FDI, criado pela Federação Dentária Internacional, é atualmente o método de nomenclatura dental mais utilizado no mundo. Esse sistema utiliza dois dígitos para identificar cada dente. O primeiro dígito representa o quadrante e o segundo indica a posição do dente dentro do quadrante.

Na dentição permanente:

PONTOS-CHAVE

- 1 → quadrante superior direito;
- 2 → superior esquerdo;
- 3 → inferior esquerdo;
- 4 → inferior direito. O segundo dígito varia conforme a posição:
- 1 → incisivo central;
- 2 → incisivo lateral;
- 3 → canino;
- 4 → primeiro pré-molar;
- 5 → segundo pré-molar;
- 6 → primeiro molar;
- 7 → segundo molar;
- 8 → terceiro molar.

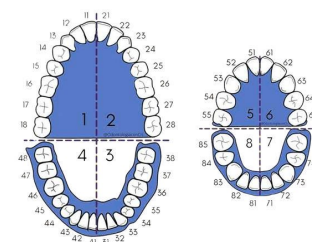
DireitaEsquerda DireitaEsquerda

Na dentição decídua:

- 5 → superior direito;
- 6 → superior esquerdo;
- 7 → inferior esquerdo;
- 8 → inferior direito.

SISTEMA ISO/FDI		Direito								Esquerdo							
		55 54 53 52 51								61 62 64 65							
Superior		18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
Inferior		48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
		85 84 83 82 81								71 72 74 75							

Figura 3 - Sistema ISO / FDI. Representação dos dentes permanentes ao centro e dos decíduos acima e abaixo.



ANOTAÇÕES

08

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Sistema Palmer

O Sistema Palmer utiliza símbolos gráficos associados aos quadrantes dentários juntamente com números ou letras para identificação dos dentes. Na dentição permanente utiliza números de 1 a 8 a partir da linha média. Na dentição decídua utiliza letras de A a E.

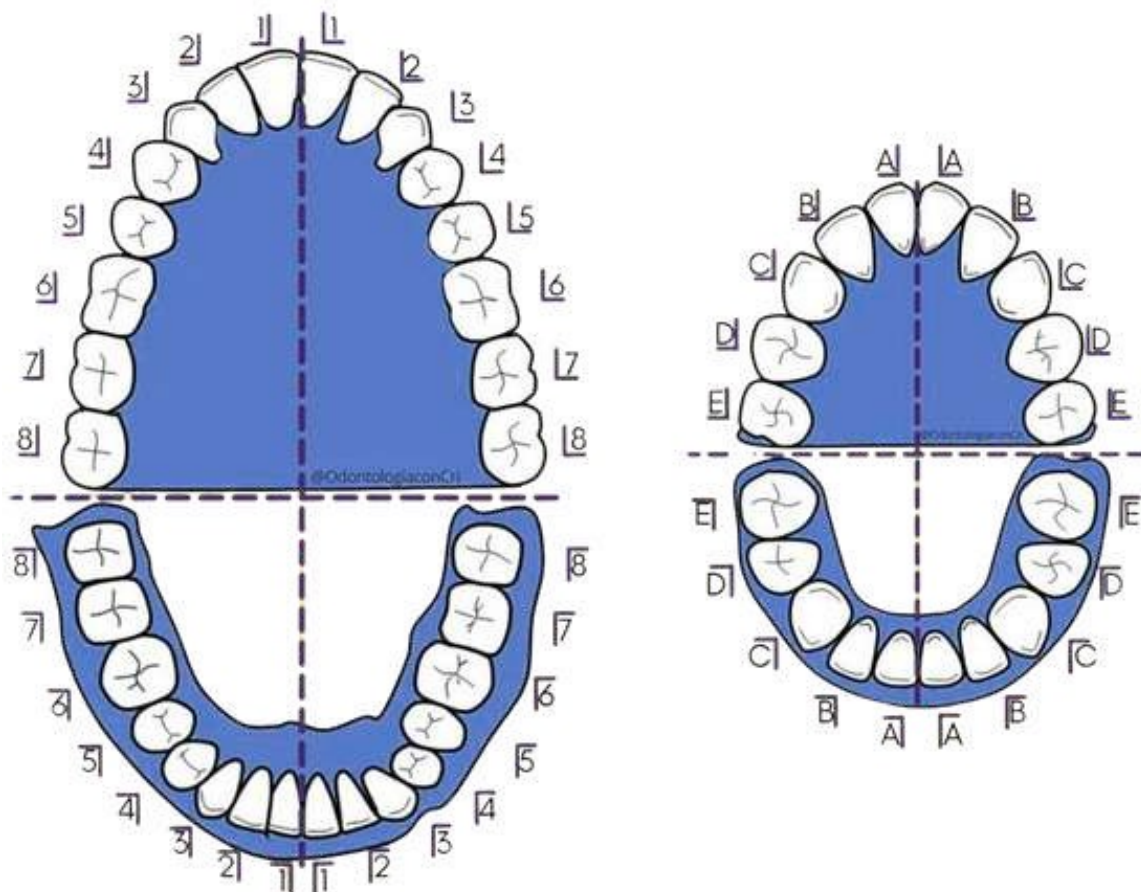
Os símbolos gráficos indicam o quadrante correspondente e permitem visualização intuitiva da posição dos dentes dentro da arcada. Esse sistema é especialmente utilizado em: • ortodontia; • odontopediatria; • diagramas clínicos manuais.

Sua principal vantagem é facilitar a representação gráfica rápida dos dentes em anotações clínicas.

Entretanto, o Sistema Palmer apresenta limitações em sistemas informatizados devido à dificuldade de reprodução digital dos símbolos gráficos. Além disso, possui menor padronização internacional quando comparado ao Sistema FDI.

Apesar disso, continua sendo importante para compreensão histórica da evolução das nomenclaturas odontológicas e interpretação de registros clínicos antigos.

DireitaEsquerda DireitaEsquerda



ANOTAÇÕES

09

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Sistema Universal

O Sistema Universal é amplamente utilizado nos Estados Unidos e apresenta metodologia diferente do Sistema FDI. Nesse sistema, os dentes permanentes são numerados de 1 a 32 em sequência contínua.

A numeração inicia-se no:

PONTOS-CHAVE

terceiro molar superior direito → dente 1; e segue pela arcada superior até:

terceiro molar superior esquerdo → dente 16.

Posteriormente continua pela arcada inferior:

terceiro molar inferior esquerdo → dente 17; até:

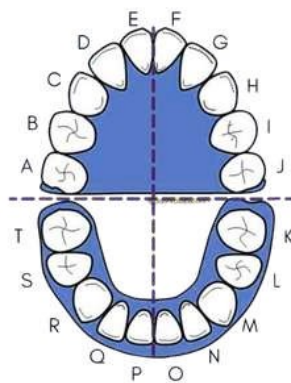
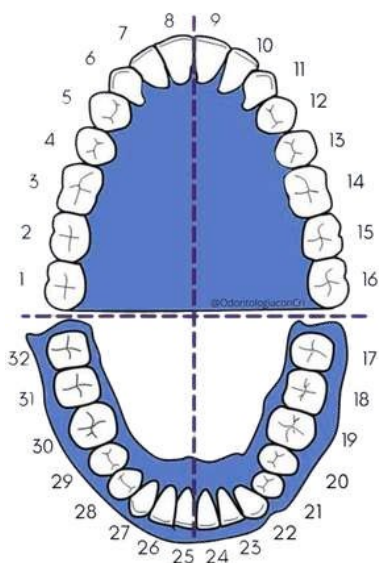
terceiro molar inferior direito → dente 32.

Na dentição decídua utilizam-se letras de A até T.

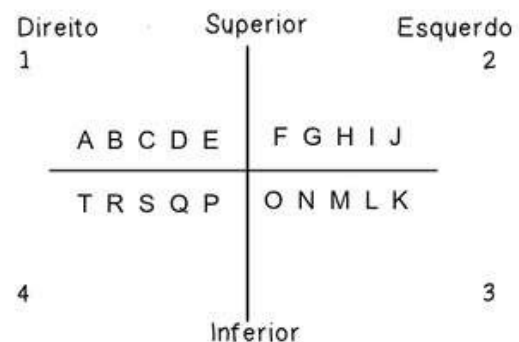
Embora seja relativamente simples para profissionais acostumados ao método, o Sistema Universal possui limitações internacionais devido à ausência de identificação direta dos quadrantes.

O conhecimento desse sistema é importante para interpretação de documentos científicos e comunicação internacional.

DireitaEsquerda



SISTEMA UNIVERSAL		Direito										Esquerdo											
		36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	[Desitivos Original]	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J											[Desitivos Modificada]	
Superior		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(Permanentes)					
Inferior		32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	(Permanentes)					
		T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K											[Desitivos Modificada]	
		20d	19d	18d	17d	16d	15d	14d	13d	12d	11d											[Desitivos Original]	



ANOTAÇÕES

10

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Cronologia da Erupção

A erupção dentária corresponde ao processo fisiológico pelo qual o dente desloca-se do interior do osso alveolar até atingir posição funcional na cavidade oral. Esse processo ocorre tanto na dentição decídua quanto na permanente e segue padrões cronológicos relativamente previsíveis.

Na dentição decídua:**PONTOS-CHAVE**

inicia aproximadamente aos 6 meses;
completa-se entre 2 e 3 anos.

Sequência eruptiva mais comum:

incisivos centrais;
incisivos laterais;
primeiros molares;
caninos;
segundos molares.

Na dentição permanente:

inicia aos 6 anos;
pode finalizar aos 21 anos.

Sequência geral:

primeiros molares;
incisivos;
pré-molares;
caninos;
segundos molares;
terceiros molares.

S
u
p
e
ri
o
r
In
fe
ri
o

r



Ordem de nascimento dos dentes do bebê



ERUPÇÃO DOS DENTES DECÍDUOS

	DENTES SUPERIORES	DENTES INFERIORES
Incisivos centrais	8 meses	6 meses
Incisivos laterais	10 meses	9 meses
Caninos	20 meses	18 meses
Primeiros molares	16 meses	16 meses
Segundos molares	29 meses	27 meses

Fonte: CURITIBA, Secretário da Saúde. Protocolo integrado de atenção à saúde bucal. Curitiba: SMS. Centro de Informações em Saúde, 2004.100p.

ANOTAÇÕES

11

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Anatomia Externa dos Dentes

A coroa corresponde à porção visível do dente e encontra-se revestida por esmalte. Sua anatomia varia conforme o grupo dental e apresenta estruturas importantes como cúspides, sulcos, fóssulas e cristas marginais. Essas estruturas auxiliam diretamente na eficiência mastigatória e no encaixe oclusal entre os dentes superiores e inferiores.

O colo dental representa a região de transição entre coroa e raiz. Trata-se de uma área clinicamente importante devido à susceptibilidade a processos como retração gengival, abrasão cervical e erosão dentária. Quando ocorre exposição radicular nessa região, o paciente pode apresentar hipersensibilidade dentinária.

A raiz encontra-se inserida no osso alveolar e revestida por cimento. Sua principal função é garantir estabilidade ao elemento dental através da inserção das fibras periodontais. Quanto ao número de raízes:

PONTOS-CHAVE

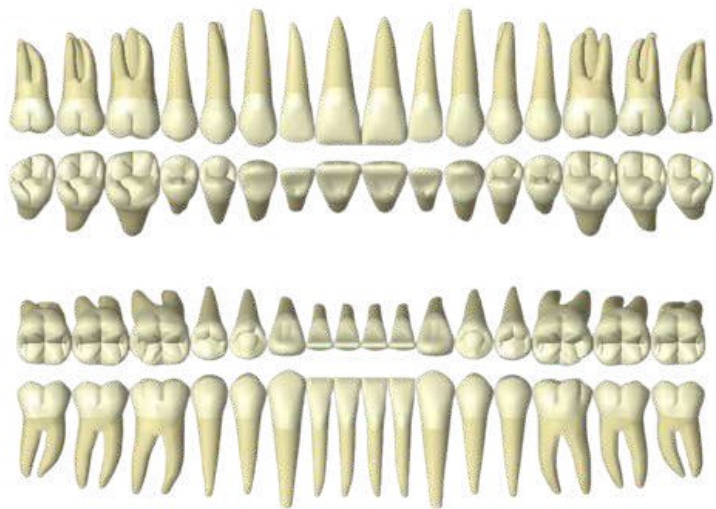
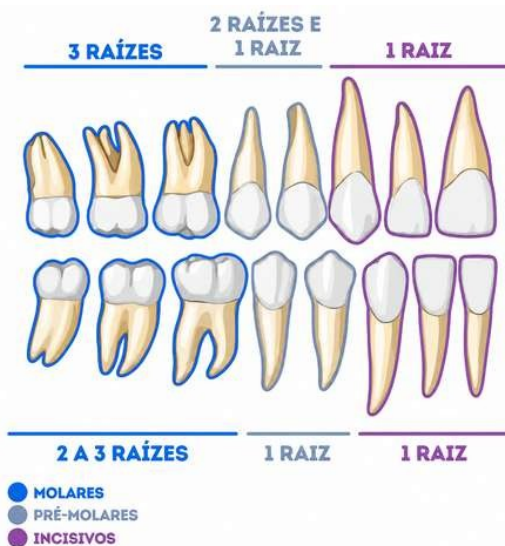
incisivos → geralmente uma raiz;

caninos → uma raiz longa;

pré-molares → uma ou duas raízes;

molares superiores → três raízes;

molares inferiores → duas raízes.



ANOTAÇÕES

12

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

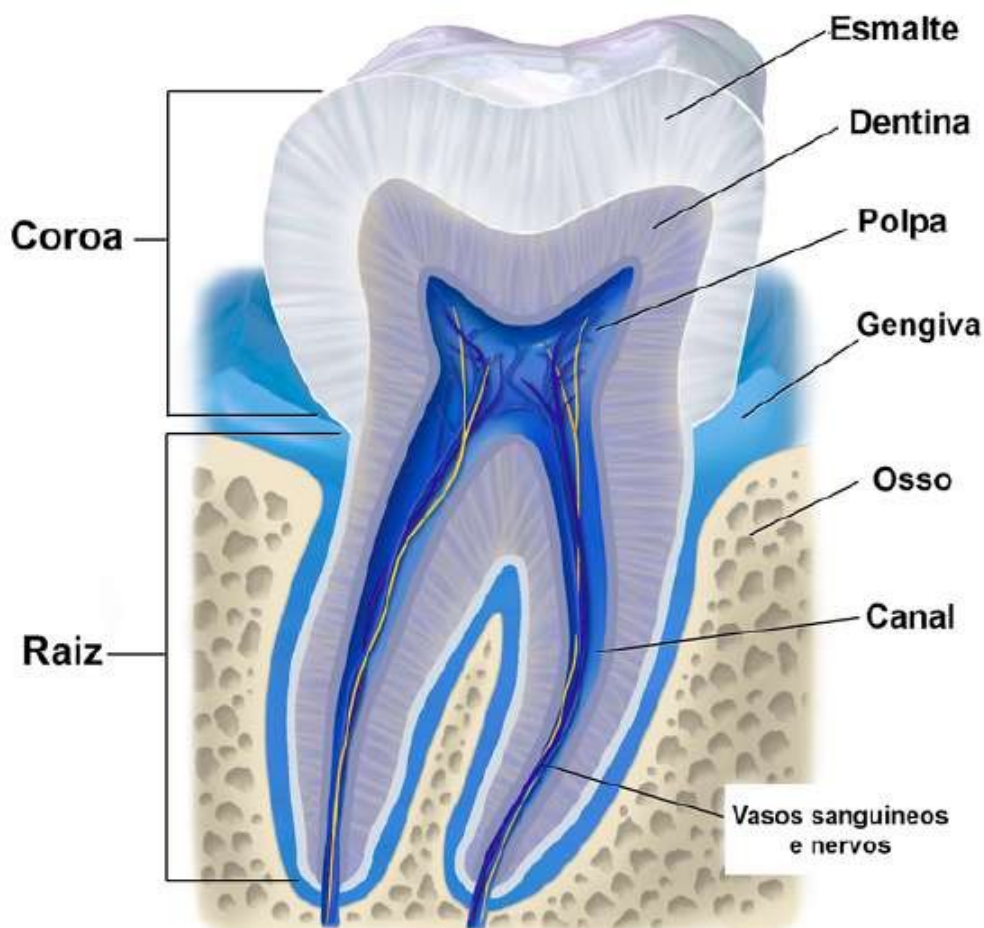
Anatomia Interna dos Dentes

Internamente, os dentes são formados por tecidos especializados responsáveis por proteção, sustentação e vitalidade. O **esmalte** dentário é o tecido mais duro do organismo humano, composto principalmente por hidroxiapatita. Sua elevada mineralização confere grande resistência mecânica e química, protegendo a coroa dentária contra desgaste mastigatório e ação dos ácidos produzidos pelas bactérias do biofilme dental.

A **dentina** localiza-se abaixo do esmalte e constitui a maior parte da estrutura do dente. Trata-se de um tecido mineralizado menos rígido que o esmalte, porém mais resiliente. A presença de túbulos dentinários permite transmissão de estímulos térmicos, químicos e mecânicos, explicando fenômenos de sensibilidade dentária quando há exposição da dentina.

O **cemento** recobre a superfície radicular e participa da fixação do dente ao osso alveolar através das fibras periodontais. Já a **polpa dentária** localiza-se no interior do elemento dental e contém vasos sanguíneos, fibras nervosas e células conjuntivas. Suas funções incluem: • nutrição; • defesa imunológica; • formação de dentina; • sensibilidade dental.

Quando a polpa sofre inflamação ocorre a pulpite, condição que pode evoluir para necrose pulpar caso não seja tratada adequadamente.



ANOTAÇÕES

13

DENTIÇÕES E NOMENCLATURAS

Fases do Dente

A **face vestibular** é a superfície voltada para os lábios e bochechas. Nos dentes anteriores, também pode ser chamada de face labial, pois fica voltada para os lábios. Nos dentes posteriores, pode ser chamada de face bucal, por estar voltada para a bochecha.

A **face lingual** é aquela voltada para a língua, sendo usada principalmente para os dentes inferiores. Nos dentes superiores, essa mesma face recebe o nome de palatina, pois fica voltada para o palato, ou céu da boca.

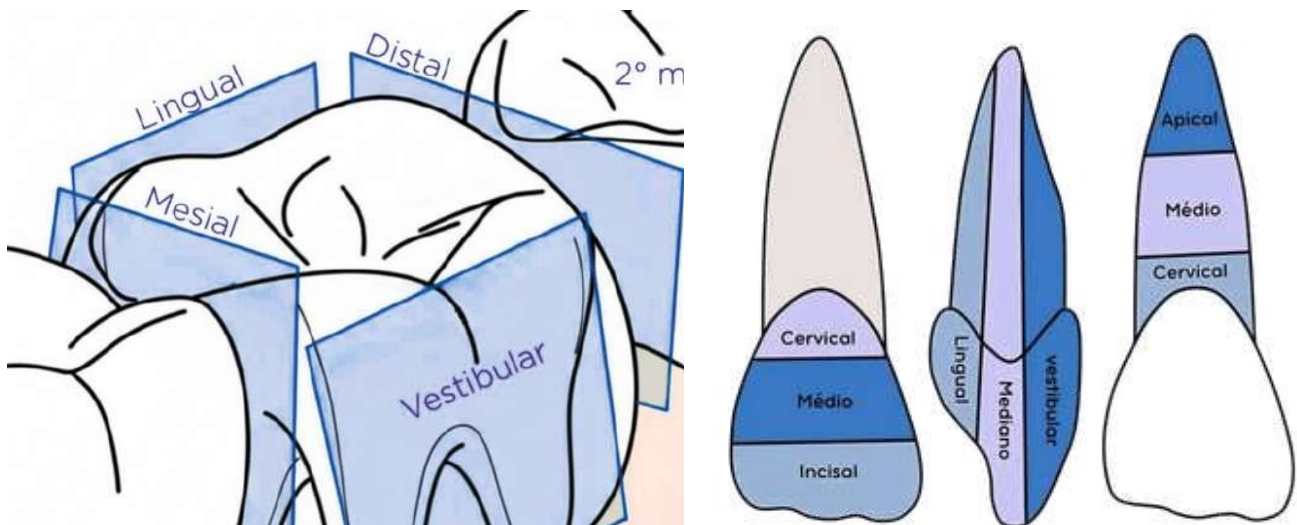
As **faces proximais** são aquelas que ficam em contato ou próximas dos dentes vizinhos. Elas se dividem em face mesial e face distal. A face mesial é a superfície voltada para a linha média da arcada dentária, enquanto a face distal é a superfície voltada para longe dessa linha média.

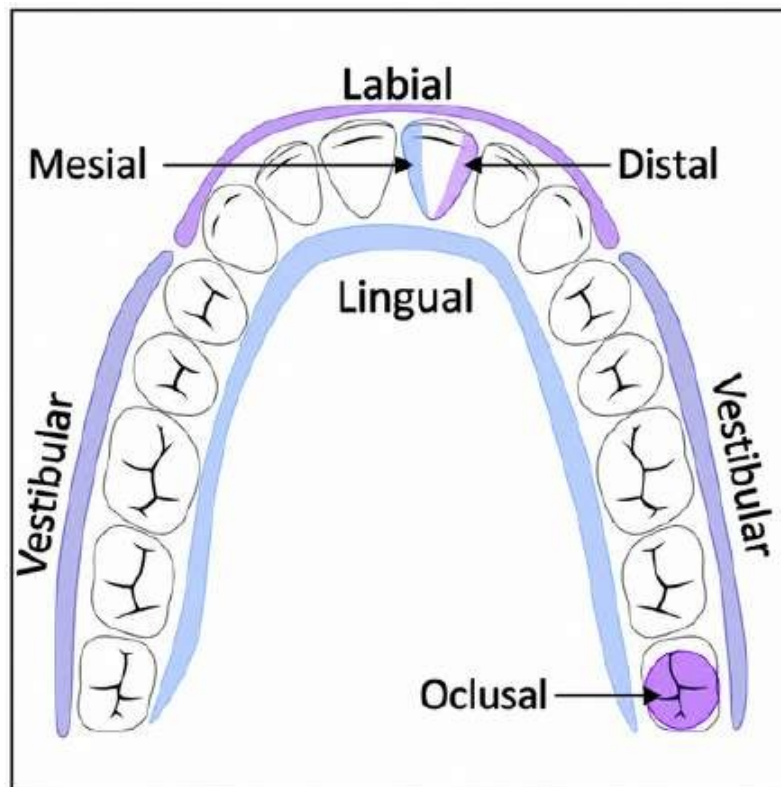
Nos dentes posteriores, como pré-molares e molares, existe a **face oclusal**, que é a superfície usada na mastigação. Já nos dentes anteriores, como incisivos e caninos, existe a **borda incisal**, responsável pelo corte dos alimentos.

O dente também apresenta divisões anatômicas importantes. Ele é formado por coroa, colo e raiz. A coroa é a parte visível do dente na boca, revestida por esmalte. O colo é a região de transição entre a coroa e a raiz, próxima à gengiva. A raiz é a parte implantada no osso alveolar, responsável pela fixação do dente.

Além disso, para facilitar o estudo e a localização de alterações, o dente pode ser dividido em terços. Na coroa, temos o terço cervical, médio e incisal ou oclusal. Na raiz, temos o terço cervical, médio e apical. Essas divisões são muito usadas na odontologia para descrever cáries, fraturas, restaurações e outras condições clínicas.

es
ac
F
al
us
cl
O





ANOTAÇÕES

Anatomia Dental

Terços e Elementos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Divisão dos Dentes em Terços	4
03 Faces Dentárias	5
04 Lóbulos de Desenvolvimento	6
05 Cíngulo e Cristas Marginais	7
06 Cúspides Dentárias	8
07 Sulcos Dentários	9
08 Fossas e Fóssulas	10
09 Fissuras Dentárias	11
10 Bossas e Convexidades	12
11 Pontos e Áreas de Contato	13
12 Elementos Complementares	14

01

TERÇOS E ELEMENTOS

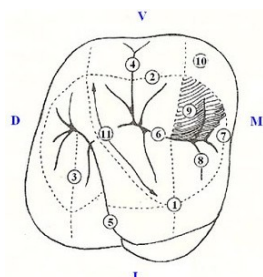
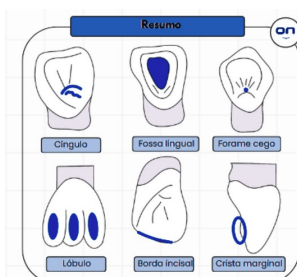
Introdução

Os terços e elementos anatômicos dos dentes constituem a base do estudo sistematizado da Anatomia Dental. Compreender essas divisões e nomenclaturas é indispensável para a comunicação clínica precisa entre profissionais da Odontologia, além de facilitar a **identificação, descrição e análise morfológica** de cada dente. Os terços dentários são subdivisões didáticas que permitem localizar com exatidão qualquer estrutura anatômica ao longo da coroa e da raiz, enquanto os elementos anatômicos representam as formas, superfícies e estruturas que compõem a morfologia dental.

A **divisão dos dentes em terços, faces e elementos anatômicos** fundamenta os procedimentos clínicos nas diferentes especialidades odontológicas. Em Dentística, Endodontia, Prótese, Periodontia, Ortodontia e Cirurgia, o domínio dessas nomenclaturas orienta desde o diagnóstico até o planejamento e execução de tratamentos. O conhecimento aprofundado dessa anatomia permite ao profissional reconhecer **variações morfológicas, identificar patologias e reproduzir com fidelidade as estruturas dentárias durante procedimentos restauradores e reabilitadores**.

A aplicação clínica dos terços e elementos anatômicos reflete diretamente na qualidade dos tratamentos odontológicos. Ao descrever com precisão a localização de uma lesão cariosa, de uma fratura dental, de uma área de reabsorção radicular ou de um ponto de contato alterado, o profissional favorece a comunicação interdisciplinar e o registro clínico adequado. Além disso, o estudo detalhado desses elementos permite compreender como as diferentes superfícies dentárias interagem funcionalmente, influenciando a mastigação, a fonética e a estética do sorriso.

Resumo



- Legenda
1. Vértice da cúspide
 2. Aresta longitudinal
 3. Aresta transversal
 4. Sulco vestibular
 5. Sulco lingual
 6. Sulco méso-distal
 7. Crista marginal transversal
 8. Sulco secundário de escape
 9. Vertente trirante ou occlusal
 10. Vertente lisa ou vestibular
 11. Ponte de esmalte



ANOTAÇÕES

02

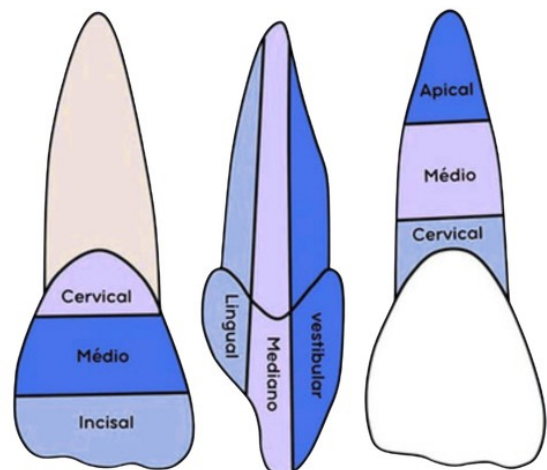
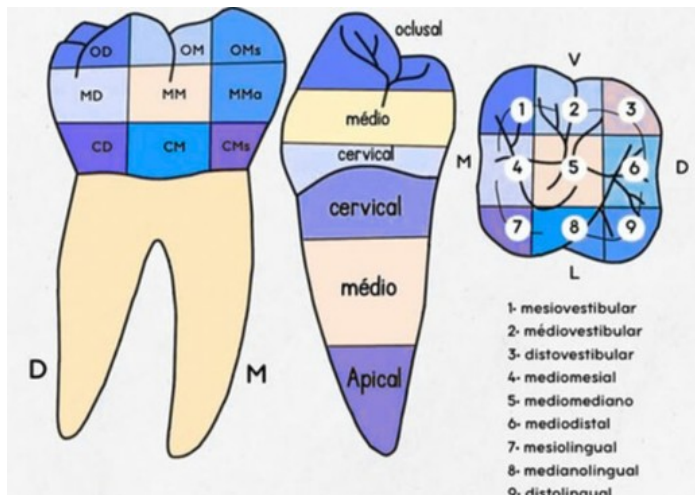
TERÇOS E ELEMENTOS

Divisão dos Dentes em Terços

A divisão dos dentes em terços é uma ferramenta fundamental para a localização anatômica precisa de estruturas na coroa e na raiz. No sentido longitudinal, os dentes são divididos em **terço cervical**, **terço médio** e **terço incisal ou oclusal**, permitindo descrever a localização de lesões, reabsorções, fraturas ou preparos ao longo do eixo axial do dente. Essa divisão é amplamente utilizada em Endodontia, Periodontia e Prótese para padronização dos registros clínicos e radiográficos.

No sentido transversal, os dentes são divididos em **terço mesial**, **terço médio** e **terço distal**. Essa subdivisão é especialmente importante para descrever a localização de lesões interproximais, pontos de contato, áreas de desgaste e contornos de restaurações. Combinando as divisões longitudinal e transversal, o clínico obtém uma grade de referência completa que facilita a comunicação com outros profissionais e a documentação dos casos.

A divisão dos dentes em terços também se aplica no sentido vestibulo-lingual ou vestibulo-palatino, definindo terços vestibular, médio e lingual. Essa análise é fundamental em planejamentos de próteses, preparos para coroas totais e avaliação de contornos axiais. O conhecimento das divisões tridimensionais do dente em terços, combinado à anatomia das faces e elementos anatômicos, torna o exame clínico mais sistemático, preciso e comunicável.



ANOTAÇÕES

03

TERÇOS E ELEMENTOS

FACES Dentárias

As faces dentárias representam as superfícies externas da coroa que recebem nomenclatura específica conforme sua orientação anatômica. A **face vestibular** é voltada para o vestíbulo da boca, estando em contato com os lábios nos dentes anteriores ou com as bochechas nos dentes posteriores. A **face lingual**, presente nos dentes inferiores, e a face palatina, nos superiores, são voltadas para a língua e o palato respectivamente. As **faces mesial e distal** são superfícies de contato interproximal, orientadas para os dentes vizinhos no mesmo arco.

Nos **dentes anteriores**, a superfície mastigatória recebe o nome de borda incisal, enquanto nos **dentes posteriores** é denominada face oclusal. Essa diferenciação reflete as distintas funções executadas por cada grupo dentário: os dentes anteriores participam do corte e da incisão dos alimentos, enquanto os posteriores realizam a trituração e o esmagamento. A correta identificação das faces dentárias é essencial para a descrição clínica e para a elaboração de diagnósticos e planos de tratamento.

A análise das faces dentárias em dentes anteriores e posteriores evidencia diferenças morfológicas importantes. Os dentes anteriores possuem faces vestibulares mais planas e faces linguais com destaque para o cingulo e as cristas marginais. Nos dentes posteriores, as faces vestibulares e linguais apresentam contornos convexos que protegem o periodonto e favorecem a autolimpeza. O conhecimento detalhado de cada face é indispensável em Dentística, Ortodontia e Prótese para execução de tratamentos anatômica e funcionalmente corretos.

ANOTAÇÕES

04

TERÇOS E ELEMENTOS

Lóbulos de Desenvolvimento

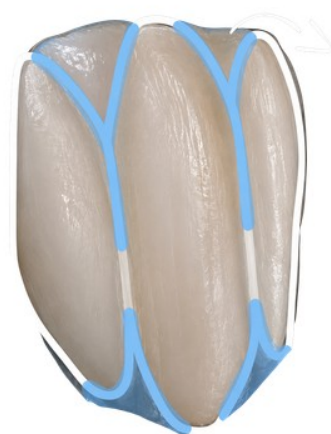
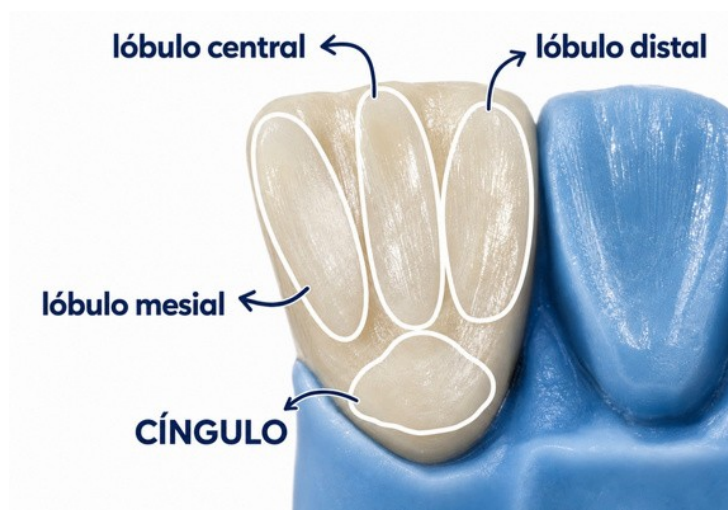
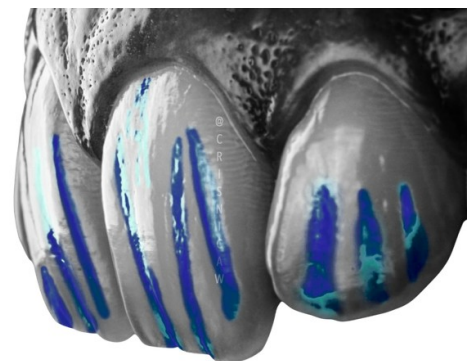
Os lóbulos de desenvolvimento são centros de calcificação que se formam durante a odontogênese e se fusionam para constituir a coroa dentária definitiva. Cada dente é formado por um número específico de lóbulos que se unem ao longo do desenvolvimento, sendo que a linha de junção entre eles frequentemente origina sulcos, depressões e irregularidades anatômicas na superfície da coroa. Nos dentes anteriores geralmente se distinguem quatro lóbulos, enquanto nos posteriores o número pode variar conforme o tipo dentário.

Nos **incisivos e caninos**, os lóbulos de desenvolvimento são responsáveis pela formação dos mamelões incisais presentes nos dentes recém-erupcionados. Com o desgaste fisiológico, esses mamelões tendem a desaparecer, tornando a borda incisal mais uniforme. Nos dentes posteriores, cada cúspide corresponde à calcificação de um lóbulo independente, explicando a morfologia cuspeada característica e a presença dos sulcos principais entre as cúspides.

S s d o

sulcos de desenvolvimento são linhas ou depressões na superfície do dente. Eles aparecem onde os lóbulos de desenvolvimento se uniram. A diferença é: o lóbulo forma o dente; sulco é a marca deixada entre os lóbulos após a união.

Sulcos de Desenvolvimento



ANOTAÇÕES

05

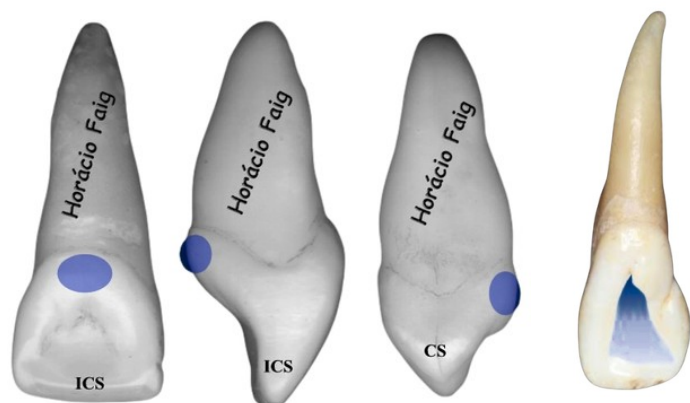
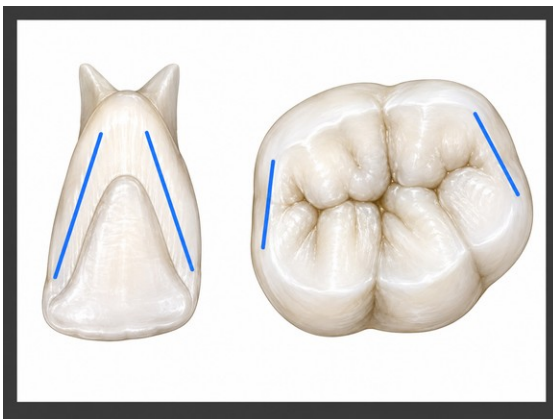
TERÇOS E ELEMENTOS

Cíngulo e Cristas Marginais

O **cíngulo** é uma elevação anatômica localizada no terço cervical das faces linguais ou palatinas dos dentes anteriores. Representa o lóbulo lingual de desenvolvimento e está presente em incisivos e caninos de ambas as arcadas. O cíngulo funciona como ponto de referência para a língua durante a fonética e participa da delimitação da área de contato entre os dentes anteriores superiores e inferiores durante a oclusão. Sua morfologia varia conforme o dente, sendo mais proeminente nos caninos e mais discreto nos incisivos laterais.

As **cristas marginais** são elevações lineares presentes nas superfícies dentárias com diferentes denominações conforme sua localização e orientação. As cristas marginais delimitam as extremidades mesial e distal das superfícies linguais dos dentes anteriores e da face oclusal dos dentes posteriores, sendo fundamentais para o estabelecimento dos pontos de contato e para a proteção das papilas interdentais. As **cristas triangulares** partem do ápice de cada cúspide em direção ao centro da superfície oclusal, formando componentes das cristas transversais e oblíquas.

As **cristas transversais** resultam da união de duas cristas triangulares opostas, cruzando a superfície oclusal no sentido vestibulo-lingual. As **cristas oblíquas**, exclusivas dos molares superiores, conectam cúspides em diagonal, sendo importante referência anatômica para a identificação desses dentes. O conhecimento dessas elevações anatômicas é essencial em Dentística Restauradora para a reprodução fiel da anatomia oclusal durante confecção de restaurações, garantindo eficiência mastigatória e equilíbrio oclusal adequado.



ANOTAÇÕES

06

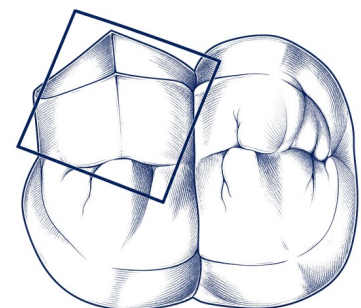
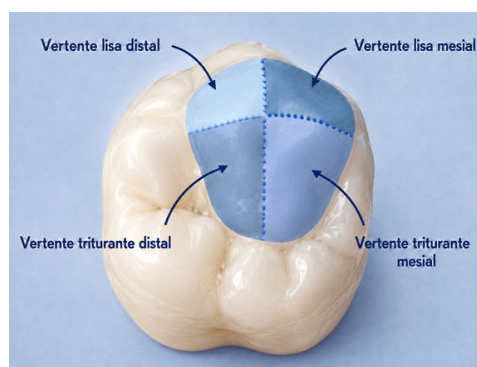
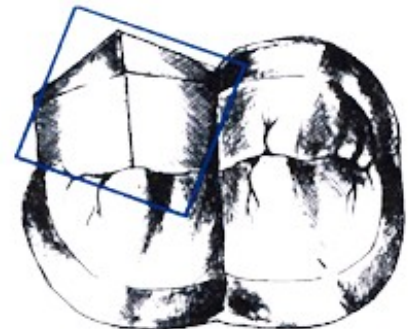
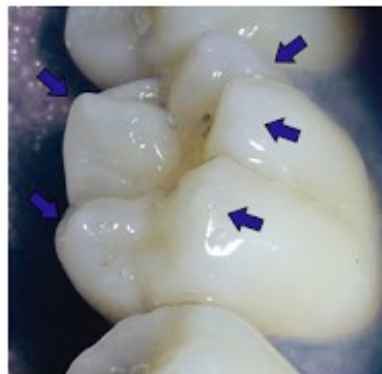
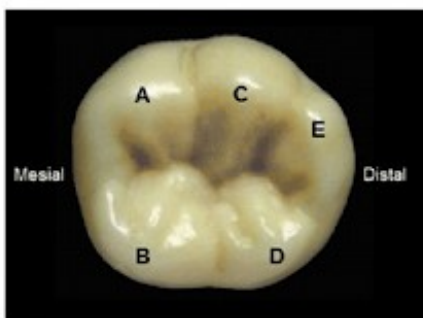
TERÇOS E ELEMENTOS

Cúspides Dentárias

As cúspides dentárias são elevações anatômicas presentes na face oclusal ou na borda incisal dos dentes. Cada cúspide é formada a partir de um lóbulo de desenvolvimento independente e possui um ápice, faces inclinadas e uma crista triangular que parte do ápice em direção ao centro da superfície oclusal. O número, a forma e o tamanho das cúspides variam conforme o tipo dentário, refletindo a função mastigatória específica de cada grupo de dentes.

Nos dentes posteriores, as cúspides são classificadas em funcionais e não funcionais conforme seu papel na oclusão. As **cúspides funcionais** são aquelas que ocluem com as fossas ou cristas marginais dos dentes antagonistas durante a oclusão habitual, sendo fundamentais para a eficiência mastigatória e para a estabilidade da oclusão. As **cúspides não funcionais** possuem menor participação oclusal direta, mas contribuem para o guiamento dos movimentos mandibulares durante a mastigação.

A integridade das cúspides dentárias é determinante para o funcionamento adequado do sistema mastigatório. Fraturas cuspídeas, desgastes excessivos por bruxismo ou procedimentos restauradores inadequados podem comprometer a oclusão, provocar sensibilidade dentinal e resultar em dor e disfunção. Em Prótese Dentária, a reprodução anatômica fiel das cúspides é indispensável para restaurações que restabeleçam a função mastigatória, os contatos oclusais e a estética dental em harmonia com o sistema estomatognático.



ANOTAÇÕES

07

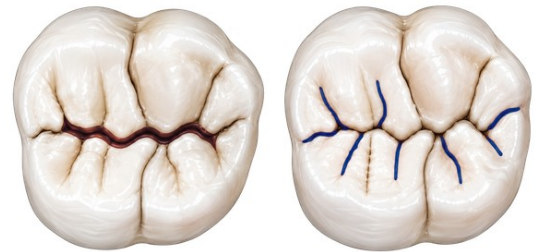
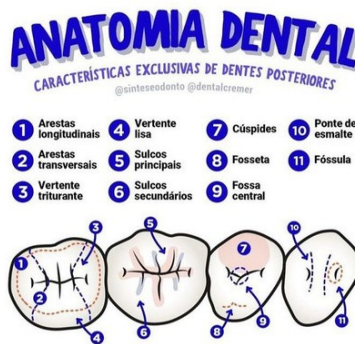
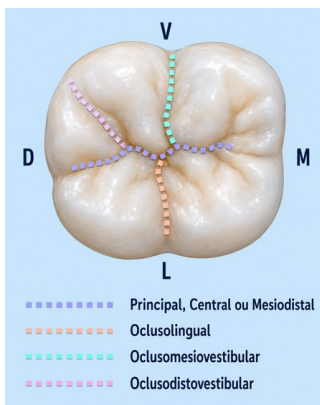
TERÇOS E ELEMENTOS

Sulcos Dentários

Os sulcos dentários são depressões lineares presentes principalmente na face oclusal dos dentes posteriores, resultantes da junção entre os lóbulos de desenvolvimento durante a formação da coroa. São classificados em **sulcos principais**, sulcos secundários e sulcos suplementares conforme sua extensão, profundidade e localização. Os sulcos principais são os de maior extensão e profundidade, geralmente demarcando os limites entre as cúspides e dividindo a superfície oclusal em regiões distintas.

Os **sulcos secundários** partem dos sulcos principais e se ramificam em direção às regiões cuspídeas, criando padrões mais complexos na superfície oclusal. Os **sulcos suplementares** são menores e menos profundos, distribuídos de forma irregular na superfície coronária. Esses sulcos contribuem para a organização anatômica da superfície mastigatória, aumentando a área de contato com os alimentos e melhorando a eficiência trituradora durante a mastigação.

Sulcos principais Sulcos secundários



ANOTAÇÕES

08

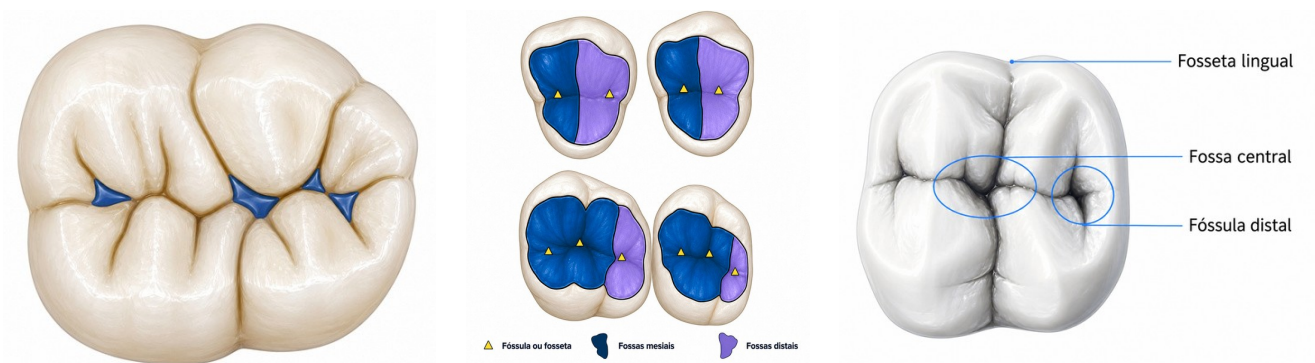
TERÇOS E ELEMENTOS

Fossas e Fóssulas

As **fossas dentárias** são depressões arredondadas ou ovaladas presentes nas superfícies coronárias dos dentes, especialmente nas faces oclusais dos dentes posteriores e nas faces linguais dos dentes anteriores. Nos dentes posteriores, as fossas mesial e distal localizam-se nas extremidades da superfície oclusal, próximas às cristas marginais, enquanto a fossa central ocupa a região central da face oclusal. Essas estruturas participam do direcionamento dos alimentos durante a mastigação, conduzindo o bolo alimentar para as regiões de trituração de forma eficiente.

As **fóssulas** são depressões pequenas e localizadas, geralmente encontradas nos pontos de junção entre sulcos principais e secundários. Sua presença é anatômicamente normal, mas clinicamente relevante, pois representam regiões de difícil higienização e maior susceptibilidade à cárie dental. Nas faces linguais ou palatinas dos dentes anteriores superiores, a fossa lingual é delimitada pelo cíngulo e pelas cristas marginais, sendo importante estrutura de referência para procedimentos restauradores anteriores.

Fóssulas



ANOTAÇÕES

09

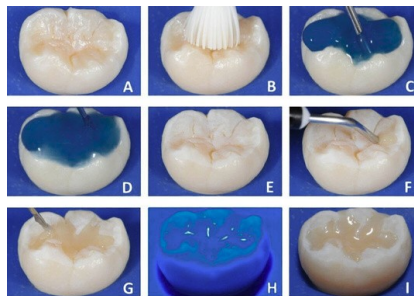
TERÇOS E ELEMENTOS

Fissuras Dentárias

As fissuras dentárias são formações anatômicas resultantes da fusão incompleta entre os lóbulos de desenvolvimento durante a odontogênese. Diferentemente dos sulcos, as fissuras apresentam profundidade e estreitamento progressivos que dificultam ou impedem a penetração das cerdas da escova de dentes, favorecendo o acúmulo de biofilme dental e o desenvolvimento da cárie oclusal. São encontradas predominantemente nas regiões oclusais dos molares e pré-molares, mas também podem ocorrer nas faces vestibulares e linguais de alguns dentes.

Do ponto de vista clínico, as fissuras são consideradas áreas de alto risco para a cárie dental, especialmente em crianças e adolescentes durante a erupção dos dentes permanentes. A morfologia estreita e profunda das fissuras cria um ambiente propício para a colonização bacteriana e a fermentação de substratos cariogênicos, resultando em desmineralização progressiva do esmalte. O diagnóstico precoce de fissuras susceptíveis pode ser realizado por exame visual, uso de sondas exploradoras e exames de fluorescência a laser.

A principal estratégia preventiva para as fissuras dentárias é o **selamento com resinas selantes, materiais fluidos que penetram nas irregularidades** da superfície e impedem o acesso bacteriano às regiões mais profundas. O selamento é especialmente indicado nos primeiros anos após a erupção dos dentes permanentes posteriores. Além disso, a aplicação tópica de flúor e os programas de higiene oral são medidas complementares fundamentais para a prevenção das lesões de fissura.



ANOTAÇÕES

10

TERÇOS E ELEMENTOS

Bossas e Convexidades

As **bossas dentárias** são elevações convexas arredondadas presentes principalmente nas faces vestibulares dos dentes. A bossa vestibular é encontrada no terço cervical ou médio das faces vestibulares, sendo mais evidente em caninos e primeiros molares. Sua presença é anatômicamente normal e possui função protetora, pois direciona os alimentos para fora do sulco gengival durante a mastigação, auxiliando na autolimpeza das superfícies dentárias e na proteção da margem gengival.

As **convexidades anatômicas** dos dentes possuem funções essenciais para a saúde periodontal e para a eficiência mastigatória. A convexidade adequada nas faces vestibulares e linguais ou palatinas garante que o bolo alimentar seja desviado do sulco gengival durante os movimentos mastigatórios, reduzindo o acúmulo de resíduos alimentares e o risco de inflamação gengival. A ausência ou inadequação das convexidades axiais, como ocorre em restaurações subcontornadas ou sobrecontornadas, pode resultar em dano ao periodonto de proteção.

Em Prótese Dentária e Dentística Restauradora, a reprodução correta das convexidades axiais é requisito fundamental para o sucesso clínico. Coroas protéticas com contornos inadequados podem favorecer o acúmulo de placa, dificultar a higienização e provocar inflamação gengival crônica. O conhecimento das bossas e convexidades normais de cada dente permite ao profissional avaliar a qualidade de restaurações existentes, identificando necessidade de ajustes ou substituições.



ANOTAÇÕES

11

TERÇOS E ELEMENTOS

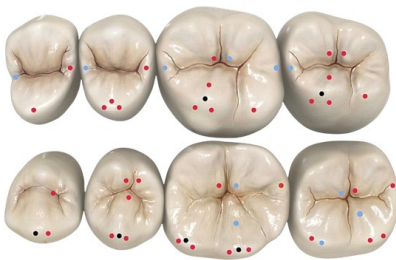
Pontos e Áreas de Contato

Os pontos e áreas de contato dentários são regiões de contigüidade entre faces proximais de dentes adjacentes no mesmo arco dentário. Nos **dentes anteriores**, o contato interproximal ocorre predominantemente nas faces mesiais e distais, na altura do terço incisal ou médio, formando pontos de contato relativamente pequenos e localizados. Nos **dentes posteriores**, especialmente nos molares, esses contatos tendem a ser mais amplos, assumindo a forma de áreas de contato de maior extensão.

A **integridade** dos pontos e áreas de contato é essencial para a estabilidade dos arcos dentários. Contatos adequados impedem a migração e rotação dos dentes, mantendo o alinhamento e a oclusão equilibrada. Além disso, protegem a papila interdental e o osso alveolar subjacente, funcionando como barreira mecânica que impede a impactação de alimentos no espaço interproximal.

Alterações nos pontos e áreas de contato, como abertura de diastemas, contatos prematuros ou áreas ausentes, podem provocar impactação alimentar repetida, inflamação gengival localizada e formação de lesões cariosas interproximais. Em Dentística e Prótese, a restauração adequada dos contatos proximais é requisito fundamental do tratamento.

Em Dentística, matrizes, cunhas interdentais e técnicas restauradoras específicas são utilizadas para garantir a correta reconstrução das áreas de contato. Em Ortodontia, a análise dos contatos proximais auxilia no diagnóstico de apinhamentos, desgastes e projeção do tratamento. A avaliação sistemática dos pontos de contato faz parte do exame clínico periodontal e dentário, orientando o diagnóstico e o plano de tratamento de forma precisa e eficiente.



ANOTAÇÕES

12

TERÇOS E ELEMENTOS

Elementos Complementares

Ameias dentárias As ameias são os espaços triangulares formados entre dentes vizinhos, principalmente próximos às áreas de contato. Elas podem ser incisais/oclusais, cervicais, vestibulares ou linguais. Têm importância estética e funcional, pois ajudam no escoamento dos alimentos, protegem a papila interdental e influenciam a harmonia do sorriso.

Zênites gengivais O zênite gengival é o ponto mais alto ou mais apical da margem gengival ao redor do dente. Ele é muito importante na estética anterior, principalmente em incisivos e caninos. Quando os zênites estão bem posicionados, o contorno gengival fica mais harmônico; quando estão desalinhados, podem causar aparência irregular no sorriso.

Áreas de sombra As áreas de sombra são regiões mais escuras percebidas na superfície dental por causa da anatomia, inclinação das faces, profundidade dos sulcos ou transição entre planos. Elas ajudam a dar sensação de volume e naturalidade ao dente, principalmente em restaurações estéticas.

Áreas de espelho As áreas de espelho são regiões mais lisas e refletivas da superfície dental, onde a luz incide com maior intensidade. Elas estão relacionadas ao brilho e à percepção visual da forma do dente. Em Dentística Restauradora, reproduzir corretamente essas áreas ajuda a deixar a restauração mais natural.

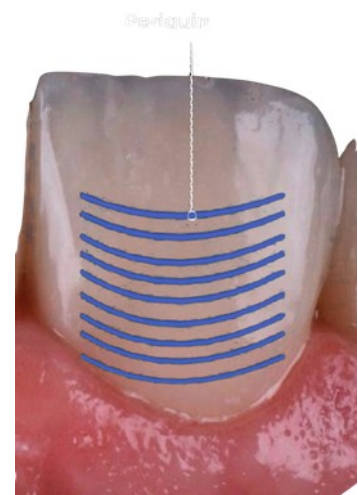
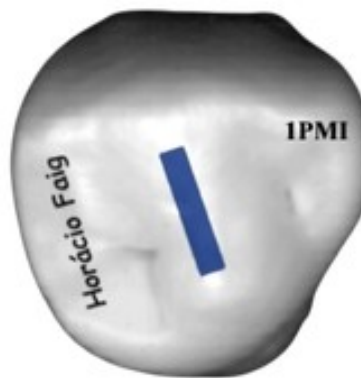
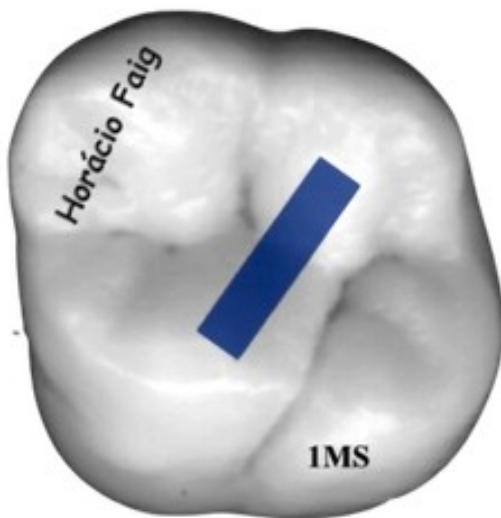
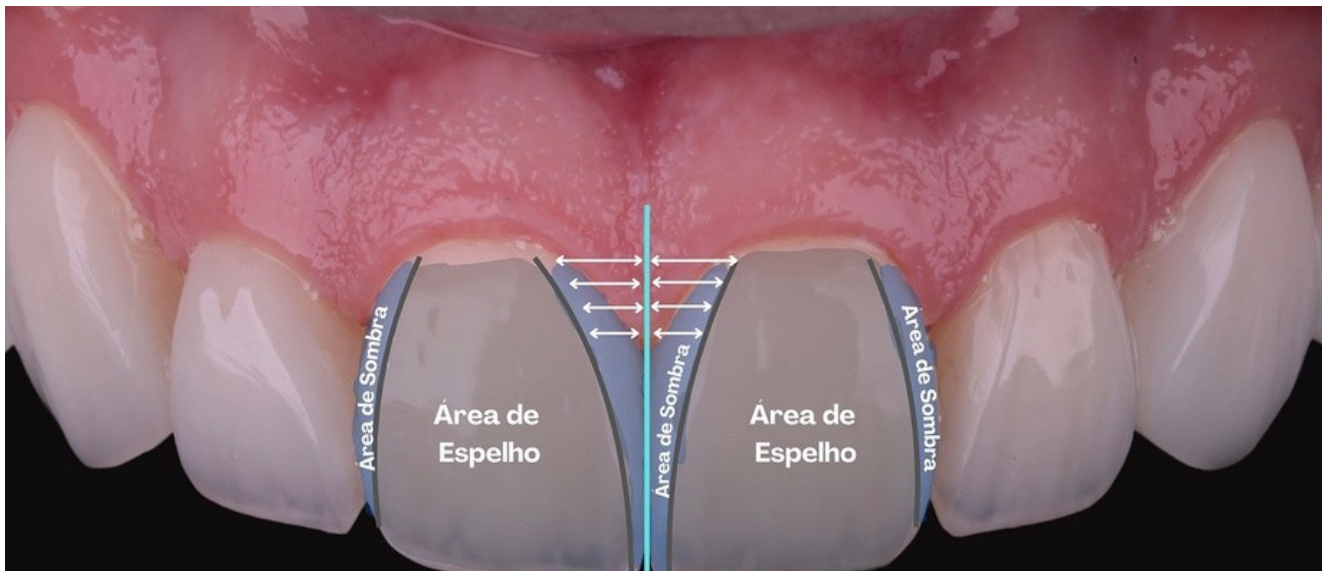
Ponte de esmalte A ponte de esmalte é uma elevação de esmalte que une duas cúspides em alguns dentes posteriores, principalmente nos molares. Ela interrompe ou cruza a região do sulco principal, funcionando como uma estrutura anatômica de reforço.

Periquimácias Pequenas linhas horizontais na superfície do esmalte, mais comuns em dentes anteriores jovens. Dão textura e naturalidade ao dente.

Flor de lis Forma anatômica vista principalmente na borda incisal de incisivos recém-erupcionados, relacionada aos mamilos. Tem aspecto recortado e tende a desaparecer com o desgaste.

Mamelos Pequenas elevações arredondadas na borda incisal de incisivos jovens. São três saliências formadas durante o desenvolvimento do esmalte.







ANOTAÇÕES

Anatomia Dental

Incisivos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Características Gerais	4
03 Coroa Dos Incisivos	6
04 Raiz Dos Incisivos	7
05 Incisivo central superior	8
06 Incisivo Lateral Superior	9
07 Incisivo Central Inferior	10
08 Incisivo Lateral Inferior	11
09 Diferenças Superiores e Inferiores	12
10 Funções dos Incisivos	13
11 Importância Clínica	14

01

INCISIVOS

Introdução

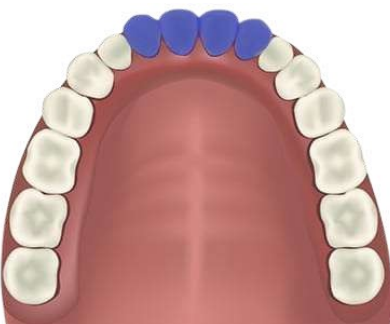
Os dentes incisivos estão localizados na **região anterior** da boca e representam um dos grupos dentários mais importantes para a **função, estética e comunicação**. Eles são os primeiros dentes observados durante o sorriso e a fala, por isso possuem grande influência na harmonia facial. Em cada arcada dentária existem quatro incisivos: dois **centrais** e dois **laterais**. Ao todo, a dentição permanente possui oito incisivos, sendo quatro superiores e quatro inferiores.

A principal função dos incisivos é **cortar os alimentos** durante o início da mastigação. Sua **borda incisal fina** e afiada permite que o alimento seja seccionado antes de ser levado aos dentes posteriores, responsáveis pela trituração. Além disso, esses dentes participam da **sustentação dos lábios, da formação do sorriso e da pronúncia correta de diversos sons**. Por isso, alterações na forma, tamanho, posição ou ausência dos incisivos podem causar prejuízos mastigatórios, estéticos e fonéticos.

Anatomicamente, os incisivos apresentam **coroa achatada no sentido vestibulolingual e uma única raiz**. Os incisivos superiores costumam ser maiores, mais largos e com formato semelhante a uma pá, enquanto os inferiores são mais estreitos, alongados e semelhantes a uma lâmina. Essas diferenças anatômicas permitem que os dentes superiores e inferiores se relacionem corretamente durante os movimentos mandibulares.

Superiores

Inferiores



ANOTAÇÕES

02

INCISIVOS

Características Gerais

Os incisivos são dentes anteriores especializados no corte e apreensão dos alimentos. Diferentemente dos dentes posteriores, que apresentam cúspides para triturar e moer, os incisivos possuem uma borda incisal fina, reta ou levemente inclinada, adaptada para seccionar alimentos. Essa característica faz com que eles funcionem como instrumentos cortantes naturais, iniciando o processo mastigatório de forma eficiente.

Além da mastigação, os incisivos são fundamentais para a estética do sorriso. Como ocupam a região mais visível da boca, qualquer alteração nesses dentes pode comprometer a aparência facial. O tamanho dos incisivos, sua posição na arcada, a cor, o alinhamento e a proporção entre centrais e laterais influenciam diretamente a beleza do sorriso e a simetria facial.

Os incisivos também exercem papel importante na fonética. Durante a fala, a língua e os lábios entram em contato com esses dentes para formar sons específicos. Quando há perda dentária, apinhamento, inclinação inadequada ou desgaste excessivo, a pronúncia pode ser alterada. Por esse motivo, o estudo dos incisivos é importante não apenas para compreender a anatomia dental, mas também para entender sua relação com funções gerais da boca.

PONTOS-CHAVE

Localizam-se na região anterior dos arcos dentários

São responsáveis pelo corte inicial dos alimentos

Participam da estética facial e do sorriso

Auxiliam na pronúncia de diversos sons

Possuem borda incisal cortante

Geralmente apresentam uma única raiz





ANOTAÇÕES

03

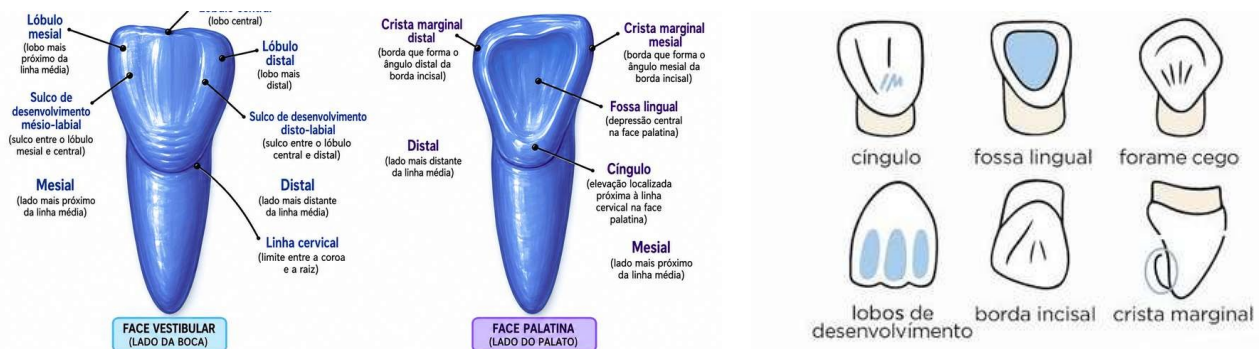
INCISIVOS

Coroa Dos Incisivos

A coroa dos dentes incisivos corresponde à parte visível do dente na cavidade oral. Ela possui formato adaptado ao corte dos alimentos e apresenta diferenças importantes entre os incisivos superiores e inferiores. Nos **superiores**, a coroa é mais larga, volumosa e semelhante a uma pá, principalmente no incisivo central superior. Nos **inferiores**, a coroa é mais estreita, fina e alongada, lembrando uma lâmina ou cinzel.

A coroa apresenta faces bem definidas: **vestibular, lingual, mesial, distal e borda incisal**. A face vestibular é voltada para os lábios e costuma ser lisa, convexa e muito importante para a estética. A face lingual é voltada para a língua e apresenta estruturas anatômicas como cingulo, cristas marginais e fossa lingual. Essas estruturas são mais evidentes nos incisivos superiores e mais discretas nos inferiores.

A **borda incisal** é uma das principais características da coroa dos incisivos. Ela atua como uma lâmina cortante durante a mastigação. Em dentes jovens, pode apresentar mamelos, pequenas elevações formadas durante o desenvolvimento dental. Com o tempo, esses mamelos sofrem desgaste natural devido ao contato entre os dentes. Por sua importância estética e funcional, a coroa dos incisivos deve ser cuidadosamente observada em restaurações, facetas, próteses e tratamentos ortodônticos.



ANOTAÇÕES

04

INCISIVOS

Raiz Dos Incisivos

A raiz dos dentes incisivos é a porção localizada dentro do osso alveolar e tem como principal função sustentar o dente. Ela mantém o elemento dental fixo na arcada e transmite as forças recebidas pela coroa para os tecidos de suporte. Todos os incisivos permanentes normalmente apresentam uma única raiz, o que os diferencia de muitos dentes posteriores, que podem ter duas ou três raízes.

Nos **incisivos superiores**, a raiz costuma ser mais cônica, volumosa e resistente. O incisivo central superior apresenta uma raiz forte, relativamente reta e com leve inclinação distal no ápice. O incisivo lateral superior possui raiz mais fina, delicada e frequentemente mais inclinada para distal. Essa curvatura pode ter importância clínica, principalmente em tratamentos de canal e extrações.

Nos **incisivos inferiores**, a raiz é mais achatada no sentido mesiodistal, ou seja, é mais fina quando observada de frente e mais alongada no sentido vestibulolingual. Esse achatamento pode formar sulcos longitudinais nas faces proximais. Apesar do pequeno tamanho da coroa, as raízes dos incisivos inferiores podem ser relativamente longas. Em alguns casos, podem existir dois canais radiculares, o que torna essencial o conhecimento anatômico em procedimentos endodônticos.

PONTOS-CHAVE

- Geralmente possuem uma única raiz
- Incisivos superiores têm raiz mais cônica
- Incisivos inferiores têm raiz achatada
- Podem apresentar sulcos radiculares
- A raiz sustenta o dente no osso alveolar
- Tem importância em endodontia, periodontia e ortodontia

DENTE	COMPRIMENTO TOTAL (COROA + RAIZ)	COROA HOMENS	COROA MULHERES	RAIZ MÉDIA (COMPRIMENTO)
INCISIVO CENTRAL SUPERIOR	≈ 22,5 mm	≈ 10,6 mm	≈ 9,8 mm	≈ 13,0 – 13,5 mm
INCISIVO LATERAL SUPERIOR	≈ 22,0 mm	≈ 9,6 mm	≈ 8,6 mm	≈ 13,5 – 14,0 mm
INCISIVO CENTRAL INFERIOR	≈ 21,5 mm	≈ 10,0 mm	≈ 9,0 mm	≈ 11,5 – 12,0 mm
INCISIVO LATERAL INFERIOR	≈ 21,0 mm	≈ 9,0 mm	≈ 8,0 mm	≈ 12,0 – 12,5 mm



ANOTAÇÕES

05

INCISIVOS

Incisivo central superior

O incisivo central superior é o maior dente do grupo dos incisivos e um dos mais importantes para a estética do sorriso. Ele está localizado próximo à linha média facial, sendo facilmente visível durante a fala e o sorriso. Sua forma, tamanho, cor e posicionamento influenciam diretamente a aparência do paciente, pois esse dente ocupa uma posição de destaque na arcada superior.

A **coroa** do incisivo central superior é larga no sentido mesiodistal e relativamente alta no sentido cérvico-incisal. Quando observada pela face vestibular, apresenta formato retangular ou trapezoidal. O ângulo mesioincisal costuma ser mais reto e definido, enquanto o distoincisal é mais arredondado. Essa diferença entre os ângulos ajuda na identificação do lado do dente e contribui para uma aparência natural.

A face lingual apresenta cúngulo evidente, cristas marginais e fossa lingual. A **raiz** é única, cônica, forte e geralmente levemente inclinada para distal no terço apical. Clinicamente, esse dente merece grande atenção, pois é muito afetado por traumatismos e qualquer alteração estética nele se torna bastante perceptível. Por isso, restaurações e tratamentos nesse elemento exigem precisão anatômica.

PONTOS-CHAVE

- Maior incisivo permanente
- Muito importante para a estética
- Coroa larga e retangular
- Ângulo mesial mais reto
- Ângulo distal mais arredondado
- Cúngulo evidente
- Raiz única, cônica e forte



ANOTAÇÕES

06

INCISIVOS

Incisivo Lateral Superior

O incisivo central superior é o maior dente do grupo dos incisivos e um dos mais importantes para a estética do sorriso. Ele está localizado próximo à linha média facial, sendo facilmente visível durante a fala e o sorriso. Sua forma, tamanho, cor e posicionamento influenciam diretamente a aparência do paciente, pois esse dente ocupa uma posição de destaque na arcada superior.

A **coroa** do incisivo central superior é larga no sentido mesiodistal e relativamente alta no sentido cérvico-incisal. Quando observada pela face vestibular, apresenta formato retangular ou trapezoidal. O ângulo mesioincisal costuma ser mais reto e definido, enquanto o distoincisal é mais arredondado. Essa diferença entre os ângulos ajuda na identificação do lado do dente e contribui para uma aparência natural.

A face lingual apresenta **cíngulo evidente, cristas marginais e fossa lingual**. A **raiz** é única, cônica, forte e geralmente levemente inclinada para distal no terço apical. Clinicamente, esse dente merece grande atenção, pois é muito afetado por traumatismos e qualquer alteração estética nele se torna bastante perceptível. Por isso, restaurações e tratamentos nesse elemento exigem precisão anatômica.

PONTOS-CHAVE

- Maior incisivo permanente
- Muito importante para a estética
- Coroa larga e retangular
- Ângulo mesial mais reto
- Ângulo distal mais arredondado
- Cíngulo evidente
- Raiz única, cônica e forte

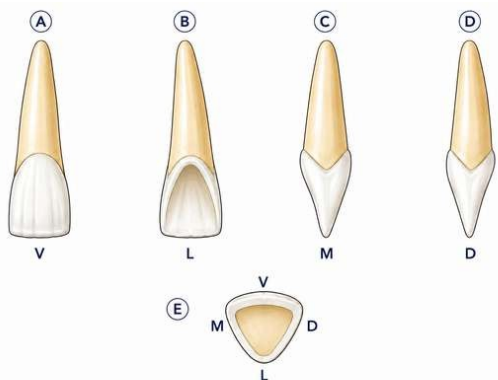
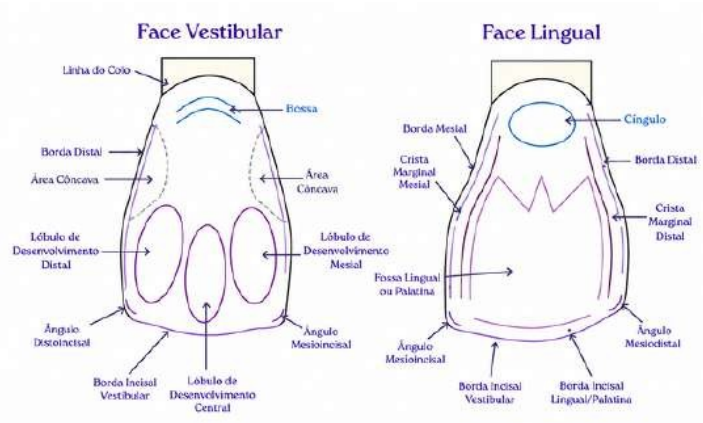


Figura 3.1 – Anatomia do incisivo lateral superior (22).
A – Face vestibular; B – Face lingual; C – Face mesial; D – Face distal; E – Borda incisal.



ANOTAÇÕES

07

INCISIVOS

Incisivo Central Inferior

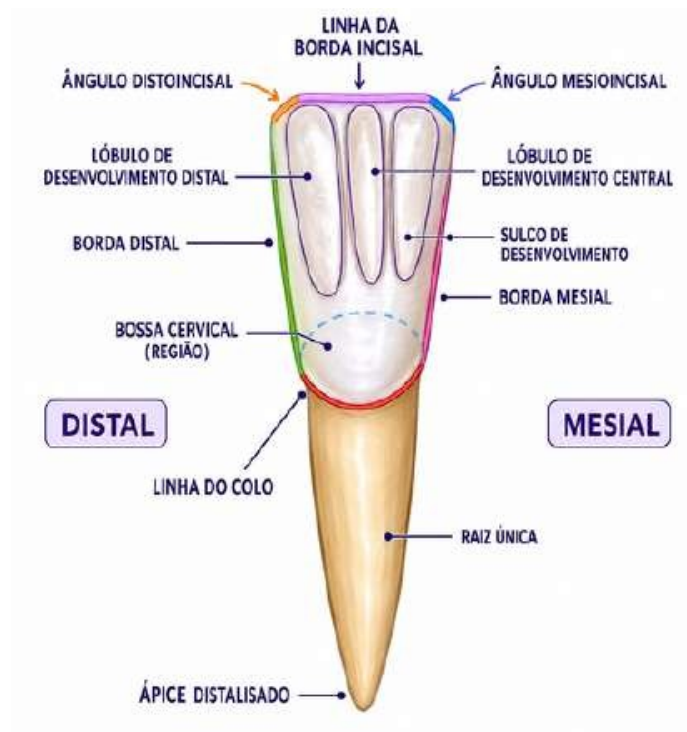
O incisivo central inferior é o menor dente permanente da dentição humana. Ele está localizado na região anterior da mandíbula, bem próximo à linha média. Apesar de seu tamanho reduzido, possui grande importância funcional, pois participa diretamente do corte dos alimentos e da relação oclusal com os incisivos superiores.

A **coroa** desse dente é estreita no sentido mesiodistal e alongada no sentido cérvico-incisal. Sua anatomia é bastante simples e simétrica, o que dificulta a identificação entre direito e esquerdo. A face vestibular é lisa e discretamente convexa. A borda incisal geralmente é reta e quase perpendicular ao longo eixo do dente, especialmente quando não há desgaste.

A face lingual é pouco marcada, apresentando **cíngulo discreto, cristas marginais suaves e fossa lingual rasa**. A **raiz** é única, fina e achatada no sentido mesiodistal, podendo apresentar sulcos longitudinais. Em alguns casos pode haver dois canais radiculares. Por ser pequeno e delicado, exige cuidado em procedimentos restauradores, periodontais e ortodônticos.

PONTOS-CHAVE

- Menor dente permanente
- Coroa estreita e alongada
- Anatomia simples e simétrica
- Cíngulo discreto
- Fossa lingual rasa
- Raiz achatada mesiodistalmente



ANOTAÇÕES

08

INCISIVOS

Incisivo Lateral Inferior

O incisivo lateral inferior é semelhante ao incisivo central inferior, porém apresenta dimensões um pouco maiores. Ele está localizado distalmente ao incisivo central inferior e acompanha a curvatura natural do arco mandibular. Sua anatomia é menos simétrica que a do central inferior, o que facilita sua identificação.

A **coroa** é estreita, mas um pouco mais larga que a do incisivo central inferior. A borda incisal apresenta inclinação distal, acompanhando o formato do arco dentário. Essa inclinação é uma das principais características anatômicas do incisivo lateral inferior. A face vestibular é lisa e levemente convexa, enquanto a face lingual apresenta cingulo discreto e fossa rasa.

A **raiz** geralmente é única, achatada no sentido mesiodistal e um pouco mais longa que a do incisivo central inferior. Pode apresentar sulcos proximais e variações internas nos canais radiculares. Clinicamente, esse dente é importante para a estabilidade anterior da mandíbula e para a guia dos movimentos mandibulares, especialmente nos movimentos protrusivos.

PONTOS-CHAVE

- Maior que o incisivo central inferior
- Menos simétrico
- Borda incisal inclinada distalmente
- Cingulo discreto
- Raiz longa e achatada
- Acompanha a curvatura mandibular



ANOTAÇÕES

09

INCISIVOS

Diferenças Superiores e Inferiores

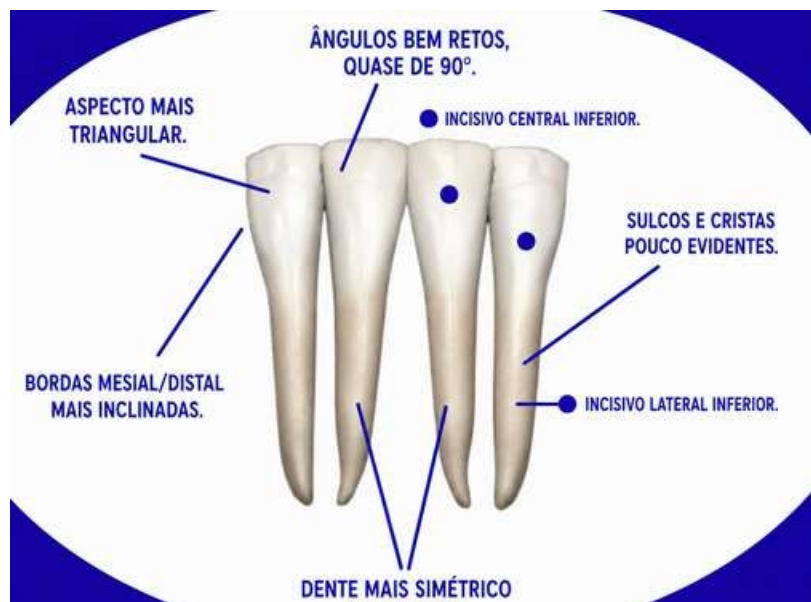
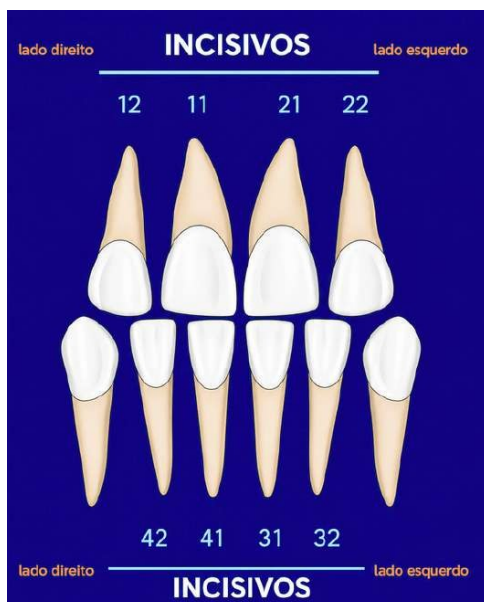
Os **incisivos superiores** são maiores, mais largos e mais visíveis que os inferiores. Eles apresentam coroas mais volumosas e faces linguais mais marcadas, com cingulo evidente, cristas marginais e fossas linguais mais profundas. Sua principal importância está relacionada à estética do sorriso, ao suporte do lábio superior e à guia dos movimentos mandibulares.

Os **incisivos inferiores**, por outro lado, são menores, mais estreitos e possuem anatomia mais simples. Suas coroas são delicadas e suas raízes geralmente achatadas. Embora tenham menor destaque estético, são essenciais para a função mastigatória, pois entram em contato com a face lingual dos incisivos superiores durante os movimentos mandibulares.

Essas diferenças anatômicas são fundamentais para o equilíbrio da oclusão. O encaixe adequado entre incisivos superiores e inferiores permite corte eficiente dos alimentos, boa fonética e proteção dos dentes posteriores durante movimentos da mandíbula. Por isso, alterações de posição ou forma nesses dentes podem comprometer a função e a estética.

PONTOS-CHAVE

- Superiores são maiores e mais largos
- Inferiores são menores e mais estreitos
- Superiores têm cingulo mais evidente
- Inferiores têm anatomia mais simples
- Superiores são mais estéticos
- Inferiores têm grande importância funcional



ANOTAÇÕES

10

INCISIVOS

Funções dos Incisivos

A principal função dos incisivos é **cortar os alimentos**. Durante a mastigação, eles realizam o primeiro contato com o alimento e o seccionam em pedaços menores. Essa função depende diretamente da borda incisal, que deve estar íntegra, alinhada e bem posicionada na arcada. Quando há desgaste, fratura ou desalinhamento, a capacidade de corte pode ser prejudicada.

Os incisivos também exercem papel importante na **fonética**. Eles auxiliam na formação de sons produzidos pelo contato da língua e dos lábios com os dentes. Sons como “f”, “v”, “s” e “z” podem ser alterados quando há perda, má posição ou alteração anatômica dos incisivos. Assim, esses dentes contribuem diretamente para a clareza da fala.

Além disso, os incisivos são indispensáveis para a **estética** facial. Eles sustentam os lábios, definem o sorriso e influenciam a aparência geral do rosto. Em tratamentos odontológicos, é essencial preservar ou reproduzir a forma natural desses dentes para manter função, beleza e equilíbrio facial.

PONTOS-CHAVE

- Cortam os alimentos
- Participam da mastigação inicial
- Auxiliam na fala
- Sustentam os lábios
- Influenciam o sorriso
- Participam da guia anterior

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO
CORTAM OS ALIMENTOS	Cortam os alimentos em pedaços menores, facilitando a mastigação.
PARTICIPAM DA MASTIGAÇÃO INICIAL	Iniciam o processo de mastigação, preparando o alimento para os demais dentes.
AUXILIAM NA FALA	Ajudam na pronúncia correta de sons como “f”, “v”, “t” e “d”.
SUSTENTAM OS LÁBIOS	Dão suporte aos lábios, contribuindo para a estética e para a expressão facial.
INFLUENCIAM O SORRISO	São fundamentais para a harmonia do sorriso e para a aparência do rosto.
PARTICIPAM DA GUIA ANTERIOR	Orientam os movimentos da mandíbula, protegendo os dentes posteriores.



ANOTAÇÕES

11

INCISIVOS

Importância Clínica

Os incisivos possuem grande importância clínica porque estão muito **expostos a traumatismos**. Os incisivos centrais superiores são os mais atingidos em quedas, acidentes esportivos e impactos diretos na região anterior da boca. Fraturas coronárias, luxações e avulsões são situações relativamente comuns envolvendo esses dentes.

Na Dentística, os incisivos exigem grande **cuidado estético**. Restaurações mal adaptadas podem alterar cor, forma, brilho e proporção dental. Em tratamentos com resina, facetas ou coroas, é necessário respeitar a anatomia natural da coroa, a textura superficial, a translucidez da borda incisal e a proporção entre os dentes anteriores.

Na Endodontia e Ortodontia, o conhecimento da raiz é essencial. Incisivos inferiores podem apresentar canais duplos e raízes achatadas, enquanto incisivos laterais superiores podem ter curvaturas radiculares. Em Ortodontia, a inclinação dos incisivos influencia o perfil facial, a estética do sorriso e a estabilidade da oclusão.

PONTOS-CHAVE

- Muito expostos a traumatismos
- Importantes em restaurações estéticas
- Fundamentais na ortodontia
- Podem apresentar variações radiculares
- Influenciam a oclusão
- Exigem precisão anatômica



ANOTAÇÕES

Anatomia Dental

Caninos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Características Gerais	4
03 Desenvolvimento e Erupção	5
04 Anatomia Da Coroa	6
05 Anatomia Das Raízes	7
06 Canino Superior	8
07 Canino Inferior	9
08 Funções mastigatórias	10
09 Guia canina	11
10 Importância Clínica	12

01

CANINOS

Introdução

Os caninos são dentes permanentes localizados entre os incisivos e os pré-molares, desempenhando papel fundamental na **estética, função mastigatória e estabilidade oclusal**. Na dentição humana existem quatro caninos, sendo dois superiores e dois inferiores, identificados pelos números **13, 23, 33 e 43** no sistema FDI. Esses dentes apresentam anatomia única, caracterizada principalmente pela presença de uma **cúspide única e raiz longa** e resistente. Sua posição estratégica na arcada dentária permite participação direta nos movimentos mandibulares e na harmonia do sorriso.

Durante a mastigação, os caninos atuam principalmente no **rasgamento dos alimentos**, funcionando como dentes de transição entre os incisivos, responsáveis pelo corte, e os dentes posteriores, encarregados da trituração. Além disso, apresentam grande importância na proteção da oclusão, pois auxiliam na distribuição das forças mastigatórias durante os movimentos excursivos da mandíbula. A anatomia robusta e a resistência radicular tornam esses dentes extremamente importantes na estabilidade funcional da boca.

Os caninos também possuem enorme relevância estética devido ao suporte que oferecem aos lábios e ao contorno facial. Alterações em sua posição, formato ou ausência podem comprometer significativamente a aparência do sorriso e a simetria facial. Por esse motivo, o estudo anatômico dos caninos é indispensável em áreas como Dentística, Ortodontia, Endodontia, Prótese e Cirurgia Oral.



ANOTAÇÕES

02

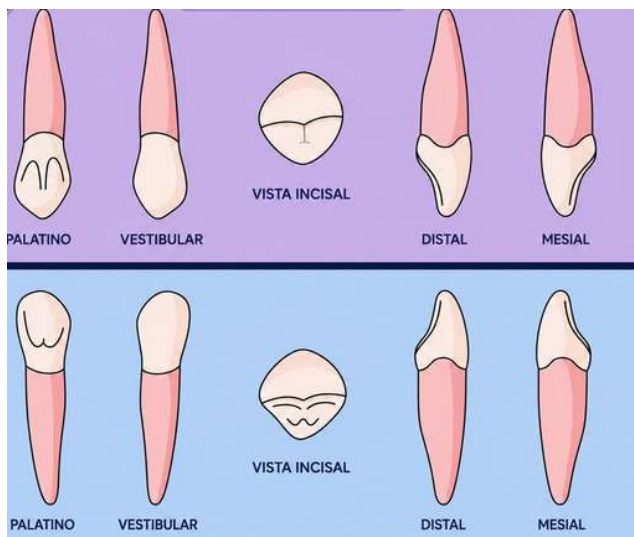
CANINOS

Características Gerais

Os caninos apresentam anatomia bastante característica, diferenciando-se dos demais dentes por sua **cúspide única, coroa robusta e raiz extremamente longa**. A face vestibular geralmente possui **formato pentagonal**, sendo convexa e marcada pela presença da crista vestibular, estrutura anatômica responsável pelo aspecto volumoso do dente. A cúspide é dividida em vertentes mesial e distal, sendo a vertente mesial geralmente menor que a distal.

A raiz dos caninos é considerada a mais longa da dentição humana, proporcionando grande estabilidade óssea e resistência funcional. Em muitos casos, especialmente nos caninos inferiores, pode haver presença de dois canais radiculares, fato de grande relevância clínica em tratamentos endodônticos. Sua anatomia radicular favorece a sustentação das forças mastigatórias e a manutenção da integridade da arcada dentária.

Outra característica importante dos caninos é sua participação na guia canina. Durante os movimentos laterais da mandíbula, esses dentes entram em contato e promovem desocclusão dos dentes posteriores, reduzindo sobrecargas mastigatórias. Essa função protetora demonstra que os caninos possuem papel fundamental não apenas na mastigação, mas também na preservação funcional do sistema estomatognático.



ANOTAÇÕES

03

CANINOS

Desenvolvimento e Erupção

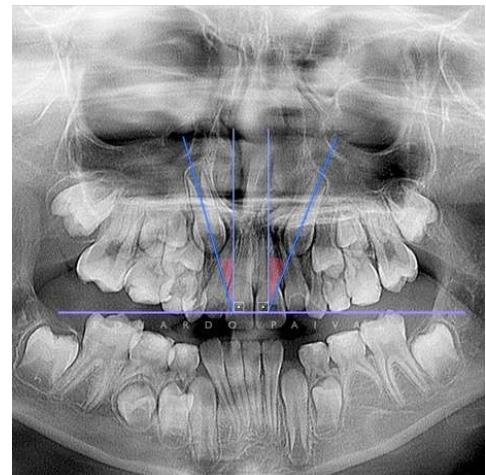
O desenvolvimento dos caninos inicia-se ainda na infância, por meio da formação dos germes dentários no interior dos ossos maxilares e mandibulares. A mineralização coronária ocorre progressivamente até que o dente esteja apto a iniciar seu processo eruptivo. Os caninos permanentes substituem os caninos decíduos e possuem cronologia eruptiva relativamente tardia quando comparados aos incisivos.

Os caninos superiores geralmente erupcionam **entre os 11 e 12 anos de idade, enquanto os inferiores costumam surgir um pouco antes, entre os 9 e 10 anos**. O longo trajeto eruptivo dos caninos superiores faz com que esses dentes apresentem alta incidência de retenção e erupção ectópica. A falta de espaço na arcada dentária pode dificultar seu posicionamento correto, favorecendo apinhamentos e alterações oclusais.

Anomalias relacionadas ao desenvolvimento dos caninos incluem agenesias, impactações, transmigrações e alterações de forma coronária ou radicular. Clinicamente, os caninos inclusos representam importante desafio ortodôntico e cirúrgico, exigindo diagnóstico precoce e planejamento adequado para evitar prejuízos funcionais e estéticos.

Tabela da data e ordem de irrupção aproximada dos dentes permanentes

DENTES	INFERIOR	SUPERIOR
Incisivos Centrais	6-7 anos	7-8 anos
Incisivos Laterais	7-8 anos	8-9 anos
Caninos	9-10 anos	11-12 anos (encerramento da dentição mista)
1º Pré-molares	10-11 anos	10-11 anos
2º Pré-molares	11-12 anos	10-12 anos
1º molares	6-7 anos	6-7 anos
2º molares	11 - 13 anos	12-13 anos



ANOTAÇÕES

04

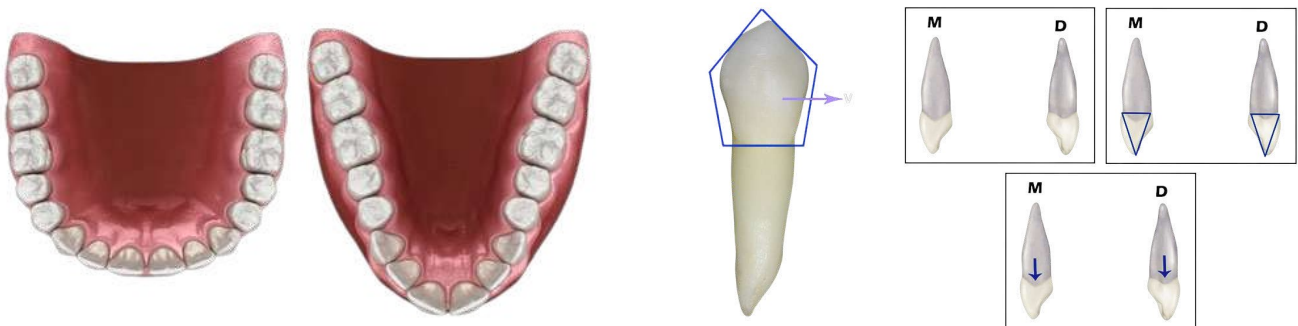
CANINOS

Anatomia Da Coroa

A coroa dos caninos apresenta anatomia adaptada principalmente ao rasgamento dos alimentos. Sua cúspide única e pontiaguda favorece a penetração inicial nos alimentos durante a mastigação. Em vista **vestibular**, a coroa possui formato pentagonal e superfície convexa, destacando-se a crista vestibular central, que confere aspecto robusto ao dente.

Na **face lingual**, observa-se presença de cingulo bem desenvolvido, principalmente nos caninos superiores. Também podem estar presentes cristas marginais e uma crista lingual que divide a superfície em duas fossas rasas. Essas estruturas anatômicas variam conforme o dente e o indivíduo, sendo geralmente mais discretas nos caninos inferiores.

A borda incisal dos caninos é substituída pela cúspide, formada pelas vertentes mesial e distal. Com o passar do tempo, desgastes fisiológicos podem reduzir a ponta da cúspide, alterando parcialmente a anatomia funcional do dente. Mesmo assim, os caninos continuam exercendo papel importante na dinâmica mastigatória e na proteção oclusal.



ANOTAÇÕES

05

CANINOS

Anatomia Das Raízes

Os caninos apresentam raízes extremamente desenvolvidas, sendo responsáveis pela elevada estabilidade desses dentes na arcada dentária. A raiz dos caninos **superiores** é considerada a mais longa da dentição humana, apresentando formato cônico e ápice geralmente afilado. Sua anatomia favorece excelente sustentação funcional e resistência mastigatória.

Nos caninos **inferiores**, a raiz costuma ser mais achatada no sentido méso-distal. Em alguns indivíduos, pode ocorrer bifurcação radicular parcial ou presença de dois canais radiculares independentes. Essas variações anatômicas possuem grande importância em Endodontia, pois podem dificultar instrumentação e obturação adequada dos canais.

A anatomia radicular dos caninos também influencia procedimentos cirúrgicos, ortodônticos e protéticos. Devido ao comprimento radicular elevado, esses dentes apresentam excelente capacidade de suporte para próteses fixas e estabilidade durante movimentações ortodônticas controladas.

Canino superior: comprimento médio de raiz de 30 a 31 mm (é o dente mais longo da arcada) 2. **Canino inferior:** média de 25 mm



ANOTAÇÕES

06

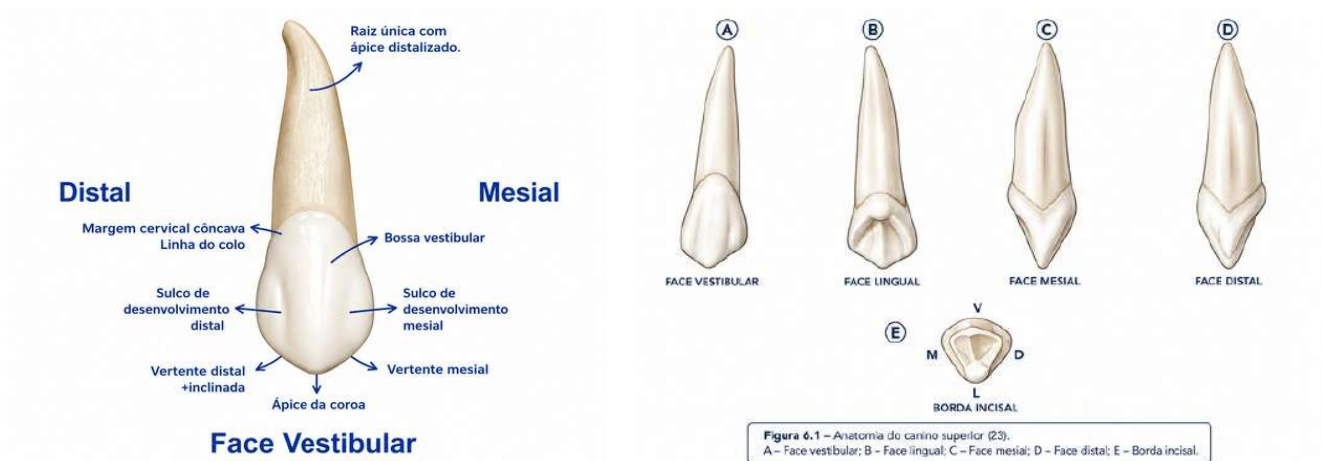
CANINOS

Canino Superior

O canino superior é considerado o dente mais longo da cavidade oral. Sua coroa apresenta grande volume vestibular e cúspide afiada, conferindo elevada capacidade de rasgamento. A **face vestibular** é altamente convexa e apresenta crista vestibular bastante evidente, característica importante para identificação anatômica.

Na **face lingual**, o canino superior apresenta cingulo volumoso e cristas marginais bem desenvolvidas. Essas estruturas tornam a anatomia lingual mais complexa quando comparada à dos caninos inferiores. A raiz é longa, cônica e geralmente única, embora pequenas variações anatômicas possam ocorrer em determinados casos clínicos.

Clinicamente, o canino superior possui enorme importância estética e funcional. Sua ausência pode comprometer significativamente o sorriso e a estabilidade da oclusão. Além disso, devido ao longo trajeto eruptivo, é um dos dentes mais frequentemente impactados, exigindo intervenções ortodônticas e cirúrgicas para reposicionamento.



ANOTAÇÕES

07

CANINOS

Canino Inferior

O canino inferior apresenta anatomia mais discreta e estreita quando comparado ao superior. Sua coroa é menos volumosa, e a **superfície lingual** costuma apresentar estruturas anatômicas menos evidentes. Apesar disso, continua sendo um dente extremamente resistente e importante para a estabilidade da arcada inferior.

A cúspide do canino inferior é geralmente menos pontiaguda e mais alinhada ao eixo longitudinal do dente. Sua raiz é longa e achatada no sentido méso-distal, podendo apresentar bifurcação ou dois canais radiculares em alguns casos. Essas variações anatômicas possuem relevância clínica principalmente em procedimentos endodônticos.

A **face vestibular** do canino inferior é a superfície voltada para os lábios e apresenta características mais suaves e discretas quando comparadas ao canino superior. Sua coroa possui formato pentagonal, sendo mais estreita no sentido méso-distal e com menor volume.

Funcionalmente, o canino inferior participa ativamente da guia oclusal e dos movimentos excursivos mandibulares. Sua posição estratégica contribui para distribuição das forças mastigatórias e manutenção do equilíbrio funcional entre os dentes anteriores e posteriores.



ANOTAÇÕES

08

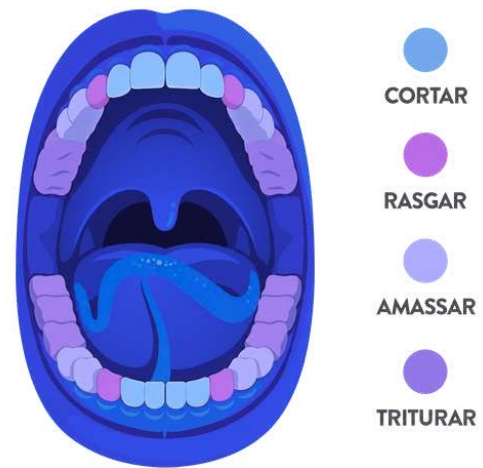
CANINOS

Funções mastigatórias

Os caninos exercem papel fundamental na mastigação, principalmente no **rasgamento e fragmentação inicial dos alimentos**. Sua cúspide afiada permite maior eficiência durante a penetração nos alimentos fibrosos, funcionando como importante elemento de transição entre incisivos e dentes posteriores.

Além da função mastigatória, os caninos possuem participação essencial na dinâmica oclusal. Durante os movimentos laterais da mandíbula, ocorre a chamada guia canina, mecanismo no qual os caninos promovem desocclusão dos dentes posteriores. Essa função reduz forças excessivas sobre pré-molares e molares, protegendo estruturas dentárias e articulares.

Os caninos também auxiliam na **manutenção da dimensão vertical da face e no equilíbrio muscular da mastigação**. Alterações em sua posição ou desgaste excessivo podem provocar desequilíbrios funcionais, interferências oclusais e dores musculares associadas à articulação temporomandibular.



ANOTAÇÕES

09

CANINOS

Guia canina

A guia canina é uma das funções mais importantes desempenhadas pelos caninos dentro do sistema estomatognático. Durante os movimentos laterais da mandíbula, os **caninos superiores e inferiores entram em contato, promovendo desocclusão dos dentes posteriores**. Esse mecanismo reduz a intensidade das forças mastigatórias aplicadas sobre pré-molares e molares, protegendo dentes posteriores, músculos mastigatórios e articulações temporomandibulares.

Os caninos são considerados ideais para essa função devido à sua anatomia robusta, raiz longa e excelente inserção óssea. A resistência estrutural desses dentes permite absorção eficiente das forças laterais produzidas durante os movimentos excursivos. Além disso, a posição estratégica dos caninos favorece distribuição equilibrada das cargas mastigatórias ao longo da arcada dentária.

Quando ocorre perda da guia canina devido a desgaste, ausência dental ou alterações oclusais, podem surgir diversos problemas funcionais. Entre eles destacam-se **sobrecarga muscular, bruxismo, dores articulares, fraturas dentárias e desgaste excessivo dos dentes posteriores**. Por esse motivo, a preservação da anatomia dos caninos é considerada fundamental em tratamentos restauradores, ortodônticos e protéticos.

Antes

Depois



Figura 3: Antes, lado esquerdo. Observa-se contato nos incisivos e pré-molares.



Figura 4: Depois, lado esquerdo. Desocclusão durante a lateralidade.

ANOTAÇÕES

10

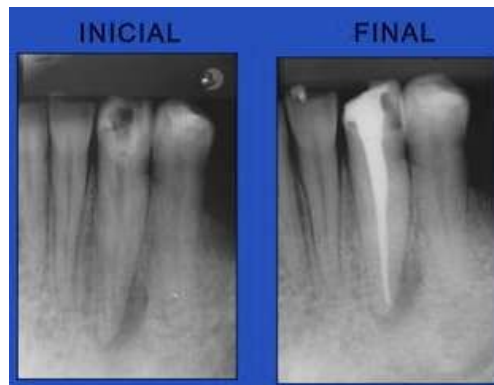
CANINOS

Importância Clínica

Na prática odontológica, os caninos possuem enorme relevância clínica devido à sua **anatomia, posição estratégica e importância funcional**. Em Ortodontia, os caninos superiores impactados representam uma das alterações eruptivas mais frequentes, exigindo diagnóstico radiográfico precoce e planejamento detalhado para tracionamento adequado.

Na Endodontia, os caninos geralmente apresentam anatomia interna relativamente simples, porém variações anatômicas podem ocorrer, principalmente nos inferiores. O conhecimento detalhado da anatomia radicular é essencial para evitar falhas terapêuticas e garantir sucesso clínico nos tratamentos.

Em Prótese e Dentística Restauradora, os caninos desempenham papel fundamental na estética do sorriso e na estabilidade oclusal. Sua forma anatômica deve ser cuidadosamente reproduzida em restaurações e próteses para garantir harmonia funcional e estética adequada.



ANOTAÇÕES

Anatomia Dental

Pré-Molares

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Características Gerais	4
03 Desenvolvimento e Erupção	5
04 Anatomia Da Coroa	6
05 Anatomia Oclusal	7
06 Anatomia Das Raízes	8
07 Primeiro Pré-Molar Superior	9
08 Segundo Pré-Molar Superior	10
09 Primeiro Pré-Molar Inferior	11
10 Segundo Pré-Molar Inferior	12
11 Funções mastigatórias	13
12 Importância Clínica	14

01

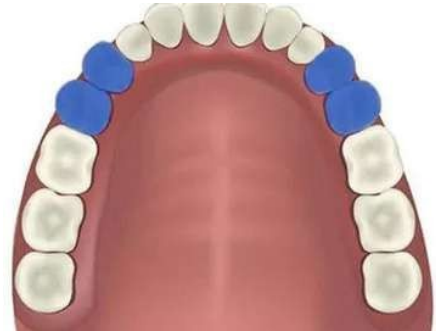
PRÉ-MOLARES

Introdução

Os pré-molares são dentes permanentes localizados entre os caninos e os molares, ocupando posição intermediária na arcada dentária. Eles fazem parte do grupo dos dentes posteriores e possuem características anatômicas próprias que os tornam fundamentais para o funcionamento adequado do sistema mastigatório. Na dentição permanente existem oito pré-molares, distribuídos em quatro dentes superiores e quatro inferiores. Diferentemente dos incisivos e caninos, os pré-molares apresentam superfície oclusal mais ampla e cúspides adaptadas para esmagamento e trituração dos alimentos.

Esses dentes surgem apenas na dentição permanente, substituindo os molares decíduos durante o período de troca dentária. Sua erupção geralmente ocorre entre os 10 e 12 anos de idade, sendo um marco importante no desenvolvimento da oclusão definitiva. A presença adequada dos pré-molares garante melhor estabilidade dos arcos dentários, correta distribuição das forças mastigatórias e equilíbrio funcional da boca. Quando há ausência, perda precoce ou alterações anatômicas nesses dentes, podem ocorrer desequilíbrios funcionais e movimentações dentárias inadequadas.

Os pré-molares possuem grande importância clínica e funcional, pois atuam diretamente na transição entre os dentes anteriores e posteriores. Enquanto os caninos realizam rasgamento dos alimentos e os molares promovem a trituração intensa, os pré-molares executam funções intermediárias, participando tanto do corte quanto da mastigação propriamente dita. Sua anatomia específica influencia procedimentos restauradores, ortodônticos, endodônticos e protéticos, tornando o estudo desses dentes indispensável na Anatomia Dental



ANOTAÇÕES

02

PRÉ-MOLARES

Características Gerais

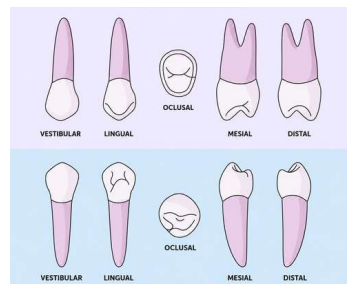
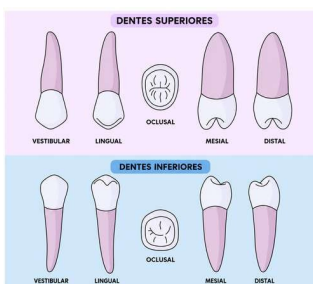
Os pré-molares apresentam anatomia adaptada para suportar forças mastigatórias consideráveis. Sua coroa possui dimensões maiores que as dos dentes anteriores, porém menores que as dos molares. Em geral, esses dentes possuem duas cúspides principais, uma vestibular e outra lingual, embora algumas variações possam ocorrer, principalmente no segundo pré-molar inferior, que pode apresentar três cúspides. Essa disposição anatômica favorece a mastigação eficiente dos alimentos.

A superfície oclusal dos pré-molares apresenta sulcos, fossas e cristas importantes para o funcionamento mastigatório. O sulco central geralmente divide a superfície oclusal entre as cúspides vestibular e lingual. As fossas mesial e distal participam do direcionamento dos alimentos durante a mastigação, enquanto as cristas marginais ajudam na estabilidade do contato oclusal entre dentes antagonistas. Essas estruturas anatômicas precisam ser preservadas em procedimentos restauradores para garantir o correto funcionamento mastigatório.

Primeiro Pré-Molar

Os pré-molares também desempenham papel importante na manutenção da dimensão vertical da face e na estabilidade da oclusão. Sua perda pode provocar migrações dentárias, alterações na mordida, extrusão dos dentes antagonistas e sobrecarga em dentes vizinhos. Além disso, contribuem para a sustentação das bochechas e manutenção do contorno facial, demonstrando que sua importância vai além da mastigação.

Segundo Pré-Molar



ANOTAÇÕES

03

PRÉ-MOLARES

Desenvolvimento e Erupção

O desenvolvimento dos pré-molares ocorre ainda durante a infância, a partir da formação dos germes dentários dentro dos ossos maxilares e mandibulares. Esses dentes pertencem exclusivamente à dentição permanente, substituindo os molares decíduos após o período de rizólise fisiológica. O processo de formação envolve mineralização gradual da coroa, desenvolvimento radicular e posterior erupção na cavidade oral.

Os primeiros pré-molares geralmente erupcionam antes dos segundos pré-molares. Nos dentes superiores, a erupção costuma ocorrer entre os 10 e 11 anos, enquanto nos inferiores pode ocorrer ligeiramente antes. Durante esse processo, é essencial que exista espaço adequado na arcada dentária, pois a falta de espaço pode resultar em apinhamento, erupção ectópica ou retenção dental.

O desenvolvimento correto dos pré-molares é fundamental para o equilíbrio da dentição permanente. Alterações na formação desses dentes podem provocar anomalias como agenesias, fusões, geminações, cúspides acessórias e alterações radiculares. Essas condições possuem grande importância clínica e podem interferir diretamente na função mastigatória, estética e planejamento odontológico.

Tabela da data e ordem de irrupção aproximada dos dentes permanentes

DENTES	INFERIOR	SUPERIOR
Incisivos Centrais	6-7 anos	7-8 anos
Incisivos Laterais	7-8 anos	8-9 anos
Caninos	9-10 anos	11-12 anos (encerramento da dentição mista)
1º Pré-molares	10-11 anos	10-11 anos
2º Pré-molares	11-12 anos	10-12 anos
1º molares	6-7 anos	6-7 anos
2º molares	11 - 13 anos	12-13 anos



ANOTAÇÕES

04

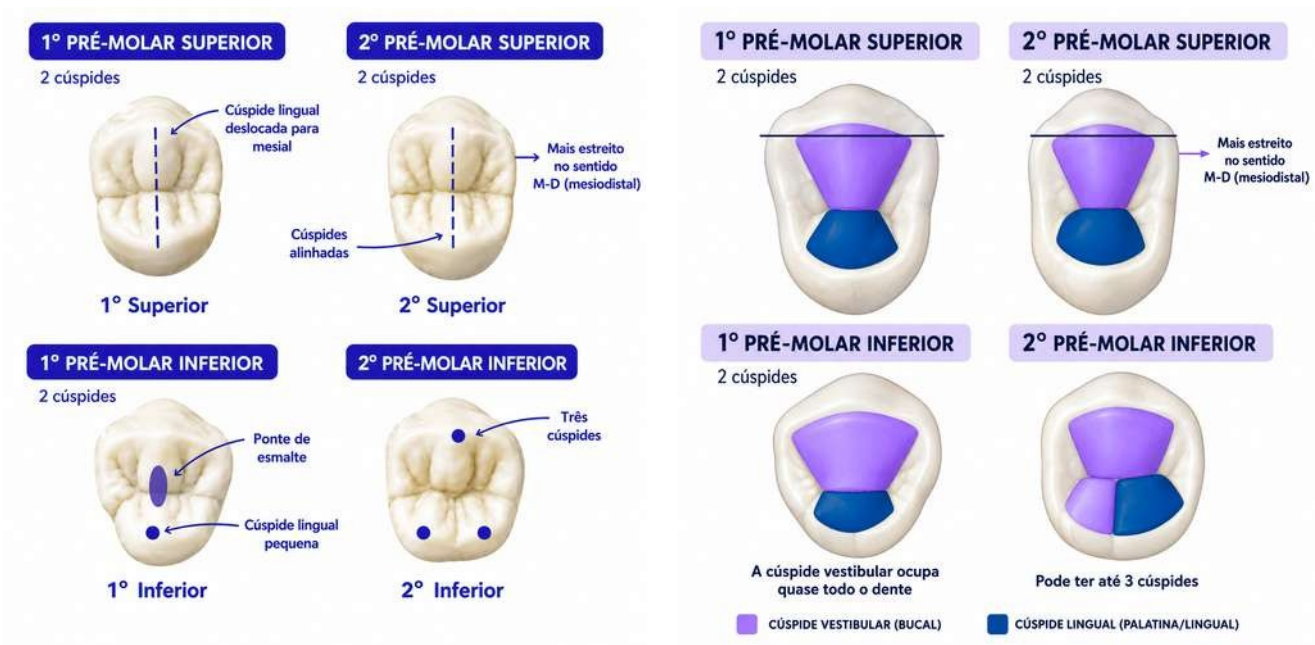
PRÉ-MOLARES

Anatomia Da Coroa

A coroa dos pré-molares possui anatomia adaptada à mastigação. Sua superfície apresenta cúspides elevadas e região oclusal ampla, permitindo esmagamento eficiente dos alimentos. Em comparação aos dentes anteriores, a coroa dos pré-molares é mais volumosa e robusta, preparada para suportar maiores forças mastigatórias.

A face vestibular geralmente apresenta formato semelhante ao dos caninos, principalmente no primeiro pré-molar superior. Ela costuma ser convexa e possuir crista vestibular evidente. A face lingual varia conforme o dente analisado. Nos pré-molares superiores, a cúspide lingual é mais desenvolvida e funcional, enquanto nos inferiores pode ser reduzida, especialmente no primeiro pré-molar inferior.

A superfície oclusal apresenta importantes estruturas anatômicas, como sulco central, fossas triangulares, cristas marginais e cristas triangulares. Essas estruturas são fundamentais para o correto relacionamento oclusal entre os dentes superiores e inferiores. Qualquer alteração anatômica nessa região pode comprometer a eficiência mastigatória e provocar interferências oclusais.



ANOTAÇÕES

05

PRÉ-MOLARES

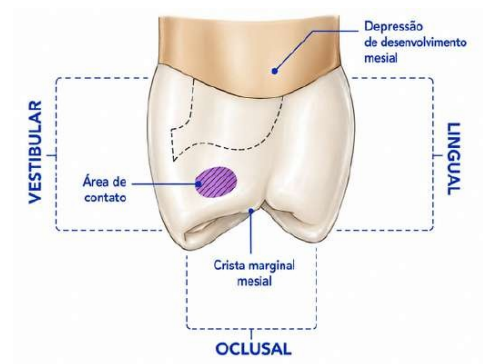
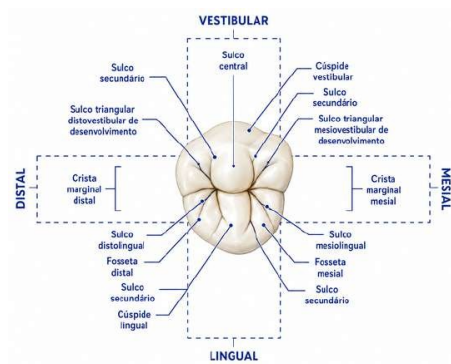
Anatomia Oclusal

A anatomia oclusal dos pré-molares é uma das características mais importantes desses dentes, pois está diretamente relacionada à eficiência mastigatória e ao equilíbrio funcional da oclusão. A superfície oclusal é composta por cúspides, sulcos, fossas e cristas anatômicas que trabalham em conjunto para permitir o esmagamento e a trituração dos alimentos durante a mastigação. Diferentemente dos incisivos, que possuem borda cortante, os pré-molares apresentam superfície mastigatória mais ampla e preparada para suportar forças oclusais maiores.

Arcada superior

Arcada superior

Arcada inferior



ANOTAÇÕES

06

PRÉ-MOLARES

Anatomia Das Raízes

A coroa dos pré-molares possui anatomia adaptada à mastigação. Sua superfície apresenta cúspides elevadas e região oclusal ampla, permitindo esmagamento eficiente dos alimentos. Em comparação aos dentes anteriores, a coroa dos pré-molares é mais volumosa e robusta, preparada para suportar maiores forças mastigatórias.

A face vestibular geralmente apresenta formato semelhante ao dos caninos, principalmente no primeiro pré-molar superior. Ela costuma ser convexa e possuir crista vestibular evidente. A face lingual varia conforme o dente analisado. Nos pré-molares superiores, a cúspide lingual é mais desenvolvida e funcional, enquanto nos inferiores pode ser reduzida, especialmente no primeiro pré-molar inferior.

A superfície oclusal apresenta importantes estruturas anatômicas, como sulco central, fossas triangulares, cristas marginais e cristas triangulares. Essas estruturas são fundamentais para o correto relacionamento oclusal entre os dentes superiores e inferiores. Qualquer alteração anatômica nessa região pode comprometer a eficiência mastigatória e provocar interferências oclusais.



SUPERIORES				
DENTE	NUMERAÇÃO FDI	RAÍZES	CÚSPIDES	DICA PARA DIFERENCIAR
1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR	14 24	2 (vestibular e palatina)	2 (vestibular maior que a palatina)	Menor que o molar; cúspides mais pontiagudas.
2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR	15 25	1 (pode bifurcar ~10% dos casos)	2 (semelhante ao 1º, porém menores)	Menor que o 1º; cúspides menos pronunciadas; raiz pode bifurcar.
INFERIORES				
DENTE	NUMERAÇÃO FDI	RAÍZES	CÚSPIDES	DICA PARA DIFERENCIAR
1º PRÉ-MOLAR INFERIOR	34 44	1 (única)	2 (vestibular maior que a lingual)	Raiz única e mais estreita que os molares.
2º PRÉ-MOLAR INFERIOR	35 45	1 (única)	2 (semelhante ao 1º, porém menores)	Menor que o 1º; cúspides menos pronunciadas.

RESUMO GERAL: Superiores → 1º PM = 2 raízes | 2º PM = 1 raiz (pode bifurcar)
Inferiores → ambos 1 raiz (sempre única) | Todos com 2 cúspides e sulco central na face oclusal.

ANOTAÇÕES

07

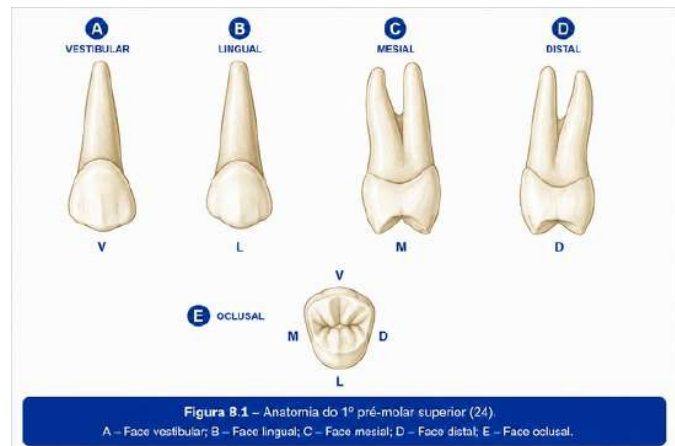
PRÉ-MOLARES

Primeiro Pré-Molar Superior

O primeiro pré-molar superior é considerado um dos dentes mais complexos da anatomia dental humana. Sua coroa apresenta formato hexagonal quando observada pela face oclusal. A cúspide vestibular é alta, volumosa e mais desenvolvida que a cúspide palatina. Essa diferença de tamanho entre as cúspides influencia diretamente a dinâmica mastigatória e o relacionamento oclusal.

A superfície oclusal desse dente apresenta sulco central longo e bem marcado, além de fossas mesial e distal relativamente profundas. Uma característica anatômica importante é a presença do sulco marginal mesial, estrutura frequentemente utilizada na identificação anatômica do dente. A face vestibular apresenta semelhança com a anatomia dos caninos, devido à presença da crista vestibular bem evidente.

A anatomia radicular do primeiro pré-molar superior merece destaque especial. Em muitos casos, esse dente apresenta duas raízes e dois canais radiculares, aumentando significativamente sua complexidade clínica. Em Endodontia, é considerado um dos pré-molares mais desafiadores devido às variações anatômicas internas. Além disso, fraturas coronárias e fraturas de cúspides são relativamente comuns nesse dente devido às forças mastigatórias exercidas sobre ele.



ANOTAÇÕES

08

PRÉ-MOLARES

Segundo Pré-Molar Superior

O segundo pré-molar superior apresenta anatomia mais regular e menos complexa que o primeiro. Suas cúspides vestibular e palatina possuem tamanhos mais semelhantes, proporcionando aspecto mais equilibrado à coroa. Sua superfície oclusal apresenta formato ovalado e sulco central mais curto e menos profundo.

A face vestibular é convexa e menos angulada quando comparada ao primeiro pré-molar superior. A superfície lingual apresenta cúspide funcional bem desenvolvida, importante para a trituração dos alimentos. Em geral, esse dente possui anatomia externa mais suave e harmoniosa.

Sua raiz normalmente é única e apresenta menor complexidade anatômica. Entretanto, variações internas podem ocorrer, incluindo bifurcações radiculares e múltiplos canais. Clinicamente, esse dente possui importante participação na estabilidade da oclusão e eficiência mastigatória, além de desempenhar papel importante em tratamentos restauradores e protéticos.

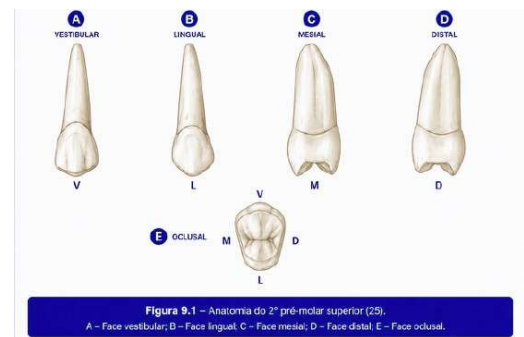


Figura 9.1 - Anatomia do 2º pré-molar superior (25).

A - Face vestibular, B - Face lingual, C - Face mesial, D - Face distal, E - Face oclusal.

ANOTAÇÕES

09

PRÉ-MOLARES

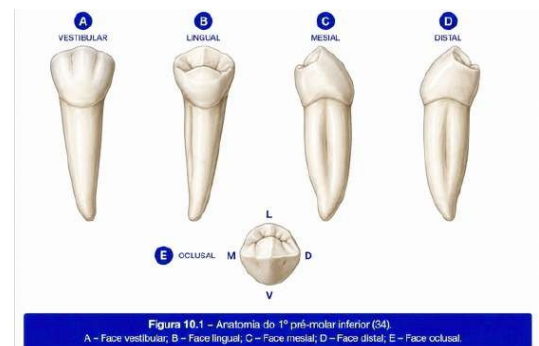
Primeiro Pré-Molar Inferior

O primeiro pré-molar inferior possui anatomia bastante peculiar e diferente dos demais pré-molares. Sua cúspide vestibular é extremamente dominante e funcional, enquanto a cúspide lingual costuma ser pequena, curta e pouco funcional. Por esse motivo, esse dente apresenta características semelhantes às dos caninos.

A coroa apresenta forte inclinação para lingual, característica marcante desse dente. A superfície oclusal possui área funcional reduzida e frequentemente apresenta sulco mesiolingual, importante estrutura anatômica para identificação dental. A anatomia da superfície oclusal é assimétrica e relativamente complexa.

A raiz geralmente é única, longa e resistente. Em Endodontia, pode apresentar variações anatômicas importantes, incluindo bifurcação de canais radiculares. Clinicamente, esse dente merece atenção especial em restaurações e ajustes oclusais devido à sua inclinação característica e anatomia funcional reduzida.

Formato Ovoide



ANOTAÇÕES

10

PRÉ-MOLARES

Segundo Pré-Molar Inferior

O segundo pré-molar inferior é considerado um dos pré-molares mais eficientes funcionalmente. Sua coroa é maior e mais robusta que a do primeiro pré-molar inferior. A anatomia oclusal é mais desenvolvida, proporcionando melhor capacidade mastigatória.

Esse dente pode apresentar duas ou três cúspides. Na forma tricúspide, existem uma cúspide vestibular e duas linguais, formando superfície oclusal em formato de “Y”. Nas formas bicúspides, a anatomia oclusal pode apresentar formatos em “H” ou “U”. Essas variações anatômicas possuem grande importância para identificação dental e procedimentos restauradores.

Sua raiz normalmente é única e robusta, garantindo boa sustentação funcional. A ampla superfície oclusal e a presença de múltiplas cúspides tornam esse dente altamente eficiente na trituração dos alimentos e na distribuição das forças mastigatórias.

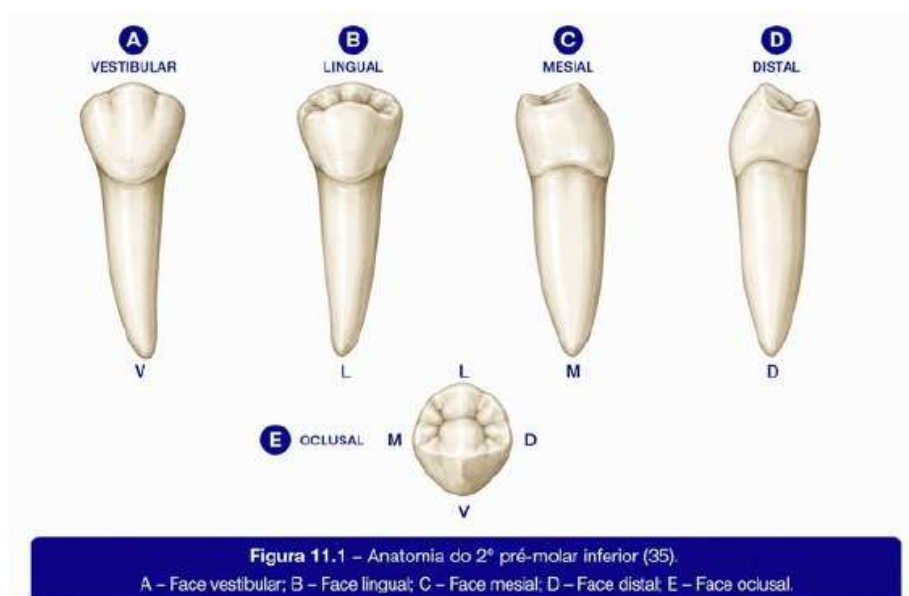


Figura 11.1 – Anatomia do 2º pré-molar inferior (35).

A – Face vestibular; B – Face lingual; C – Face mesial; D – Face distal; E – Face oclusal.

ANOTAÇÕES

11

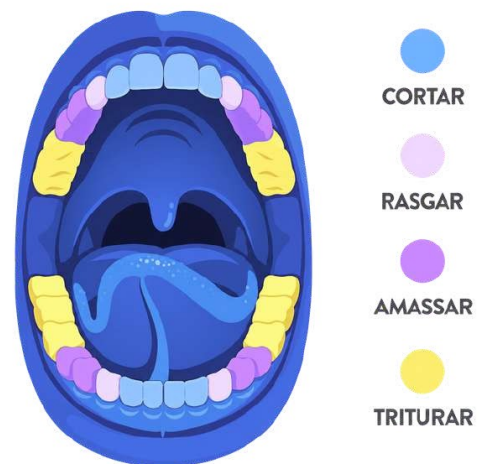
PRÉ-MOLARES

Funções mastigatórias

Os pré-molares possuem papel essencial no processo mastigatório. Sua principal função é triturar, esmagar e fragmentar os alimentos após o corte inicial realizado pelos incisivos e caninos. A presença de cúspides e superfície oclusal ampla permite maior eficiência mastigatória.

Durante os movimentos mandibulares, os pré-molares participam ativamente da distribuição das forças mastigatórias. Eles ajudam a reduzir a sobrecarga sobre os molares e estabilizam a oclusão durante movimentos funcionais. Além disso, auxiliam na proteção dos dentes anteriores contra forças excessivas.

A eficiência mastigatória dos pré-molares depende diretamente da integridade anatômica de suas cúspides, sulcos e cristas. Desgastes excessivos, fraturas ou restaurações inadequadas podem comprometer significativamente a função mastigatória e gerar alterações oclusais importantes.



ANOTAÇÕES

12

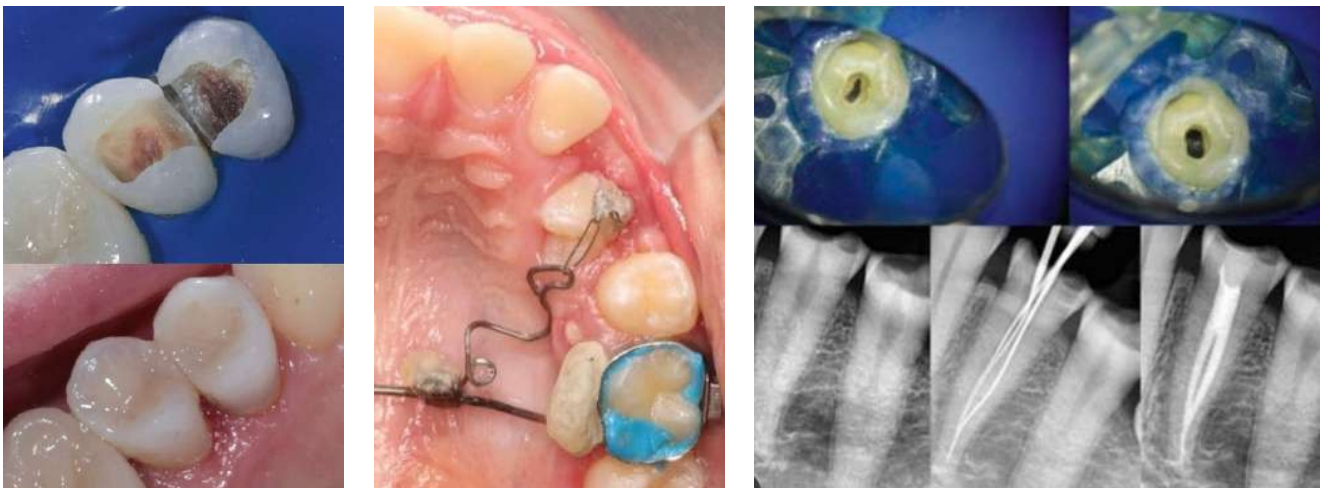
PRÉ-MOLARES

Importância Clínica

Os pré-molares possuem enorme importância clínica em praticamente todas as especialidades odontológicas. Em Dentística Restauradora, o conhecimento detalhado da anatomia coronária é essencial para reprodução adequada das cúspides, sulcos e cristas durante restaurações em resina composta ou próteses indiretas. A perda da anatomia natural pode provocar interferências oclusais, desconforto mastigatório e desgaste prematuro de dentes antagonistas.

Na Endodontia, os pré-molares são considerados dentes de atenção especial devido às frequentes variações anatômicas radiculares e dos canais. O primeiro pré-molar superior é especialmente complexo, podendo apresentar dois ou mais canais radiculares. O desconhecimento dessas variações pode resultar em falhas no tratamento endodôntico, persistência de infecção e necessidade de retratamento. Já em procedimentos cirúrgicos e exodontias, raízes divergentes ou curvas aumentam o grau de dificuldade operatória.

Os pré-molares também possuem grande importância em Ortodontia. Muitas vezes esses dentes são selecionados para extrações terapêuticas em casos de apinhamento dentário, discrepâncias ósseas ou necessidade de retração anterior. Além disso, participam diretamente da estabilidade oclusal e distribuição das forças mastigatórias. Sua perda precoce pode causar alterações funcionais importantes, migrações dentárias, colapso da mordida e prejuízos estéticos significativos.



ANOTAÇÕES

Anatomia Dental

Molares

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 7

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Características Gerais	4
03 Desenvolvimento e Erupção	5
04 Anatomia Da Coroa	6
05 Anatomia Oclusal	7
06 Anatomia Das Raízes	8
07 Primeiro Molar Superior	9
08 Segundo Molar Superior	10
09 Primeiro Molar Inferior	11
10 Segundo Molar Inferior	12
11 Terceiros Molares	13
12 Funções Mastigatórias	14
13 Importância Clínica	15

01

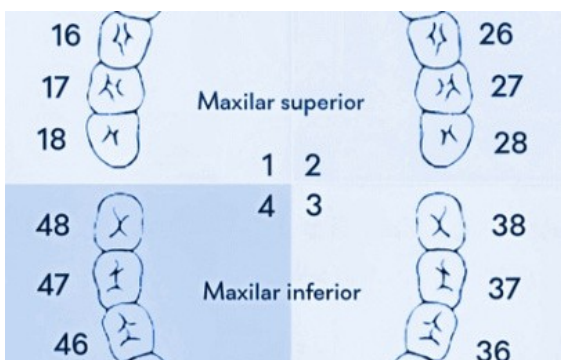
MOLARES

Introdução

Os molares são os dentes mais robustos e volumosos da dentição humana, localizados na **porção posterior das arcadas dentárias**, imediatamente atrás dos pré-molares. Na dentição permanente, são doze molares ao total, sendo três em cada quadrante: primeiro, segundo e terceiro molar. Sua anatomia ampla e multifacetada os torna fundamentais para a mastigação eficiente, sendo responsáveis pela maior parte da **trituração dos alimentos ingeridos diariamente**.

O papel dos molares vai além da simples mastigação. Eles são responsáveis pela **distribuição equilibrada das forças oclusais sobre o osso alveolar, contribuindo para a manutenção da estabilidade das arcadas e da dimensão vertical da face**. Sua presença garante equilíbrio funcional ao sistema estomatognático, sendo indispensáveis para uma oclusão saudável e duradoura.

A importância dos molares para a saúde bucal é amplamente reconhecida. O primeiro molar permanente, que erupciona por volta dos seis anos, estabelece a oclusão permanente e serve de referência para todo o desenvolvimento dental subsequente. Sua perda precoce provoca migração dos dentes vizinhos, extrusão dos antagonistas e comprometimento progressivo de toda a arcada dentária, evidenciando a necessidade de sua preservação ao longo da vida.



ANOTAÇÕES

02

MOLARES

Características Gerais

Os molares apresentam características anatômicas únicas que os diferenciam dos demais dentes da dentição. Sua **coroa é volumosa** e apresenta ampla superfície oclusal com múltiplas cúspides, sulcos, fossas e cristas bem definidas. Os molares superiores possuem geralmente quatro cúspides principais, enquanto os inferiores podem apresentar quatro ou cinco cúspides, dependendo do dente. Essa anatomia complexa é diretamente responsável pela eficiência mastigatória na região posterior das arcadas.

A **superfície oclusal** é a característica mais importante dos molares, sendo por meio dela que ocorre o contato com os dentes antagonistas durante a mastigação. Os sulcos principais dividem as cúspides em diferentes áreas funcionais, enquanto as fossas servem de receptáculo para as cúspides opostas. As cristas marginais delimitam a superfície no sentido méso-distal, contribuindo para a estabilidade dos contatos interproximais e protegendo o periodonto.

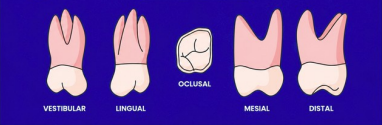
Primeiro Molar

As diferenças entre molares superiores e inferiores são marcantes e clinicamente importantes. Os **superiores** apresentam formato coronário quadrangular ou romboide, com três raízes distintas que garantem excelente sustentação no osso maxilar. Os **inferiores** possuem formato mais retangular e duas raízes achatadas no sentido méso-distal. Essas características morfológicas são fundamentais para identificação dental precisa e têm implicações diretas em procedimentos restauradores, endodônticos e cirúrgicos.

Segundo Molar

SEGUNDO MOLAR

DENTES SUPERIORES



DENTES INFERIORES



PRIMEIRO MOLAR

DENTES SUPERIORES



DENTES INFERIORES



	1º molar superior	2º molar superior
Coroa	Maior, com cúspides mesiais maiores que as distais	Menor, com cúspides mesiais muito maiores que as distais
Cúspide mesioangular	Maior e bem colada	Menor
Contorno da face occlusal	Losango, com ângulos bem definidos	Losango
Ponto de contato	Presente	Interrompido por um sulco
Tubérculo de Carabelli	Presente	Ausente
Raízes	Três desinclinadas	Desenvolvimento menor

	1º molar inferior	2º molar inferior
Coroa	Mais volumosa, com 3 cúspides vestibulares e duas linguais	Menos volumosa, duas cúspides vestibulares e duas linguais
Tamanho da face vestibular	Maior, com suas bordas mesiais e distais bem convergentes	Desenvolvimento maior
Contorno da face occlusal	Retangular com sua borda vestibular curva	Retangular com borda vestibular menos curva
Sulcos principais da face occlusal	Mais numerosos	Menor quantidade
Raízes	Maiores mais divergentes	Menores e menos divergentes

ANOTAÇÕES

OdontoLab | Resumo de estudo

4

03

MOLARES

Desenvolvimento e Erupção

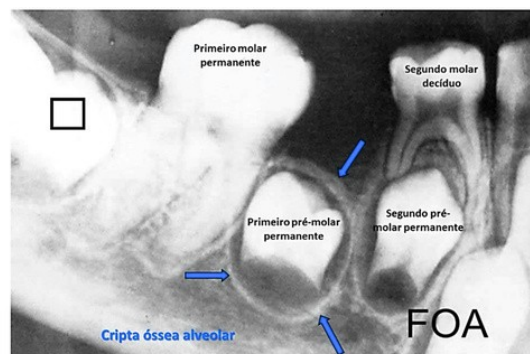
Diferentemente dos demais dentes permanentes, os molares não substituem nenhum dente da dentição decídua. Eles surgem em **regiões retromolares** que se formam graças ao crescimento posterior dos maxilares e da mandíbula durante o desenvolvimento craniofacial. O primeiro molar permanente erupciona por volta dos seis anos, sendo o primeiro dente permanente a surgir na cavidade oral. O segundo molar aparece entre os doze e treze anos, e o terceiro molar, o siso, apresenta erupção variável entre os dezessete e vinte e cinco anos.

O **processo de formação** dos molares inicia-se ainda na infância, com mineralização gradual da coroa, desenvolvimento radicular e posterior erupção. Para que ocorra adequadamente, é essencial que haja espaço suficiente na arcada. A deficiência de espaço é uma das principais causas de impatção dos molares, especialmente dos terceiros molares, sendo condição muito comum na população atual.

As alterações de erupção dos molares são frequentes e clinicamente relevantes. A erupção ectópica do primeiro molar superior pode causar reabsorção do segundo molar decíduo adjacente. A impatção dos terceiros molares é a condição mais comum em cirurgia oral, podendo causar pericoronarite, cárie nos dentes vizinhos, reabsorção radicular e formação de cistos. O acompanhamento radiográfico periódico desde a infância é indispensável para identificar precocemente qualquer alteração no processo eruptivo.

Tabela da data e ordem de irrupção aproximada dos dentes permanentes

DENTES	INFERIOR	SUPERIOR
Incisivos Centrais	6-7 anos	7-8 anos
Incisivos Laterais	7-8 anos	8-9 anos
Caninos	9-10 anos	11-12 anos (encerramento da dentição mista)
1º Pré-molares	10-11 anos	10-11 anos
2º Pré-molares	11-12 anos	10-12 anos
1º molares	6-7 anos	6-7 anos
2º molares	11 - 13 anos	12-13 anos



ANOTAÇÕES

04

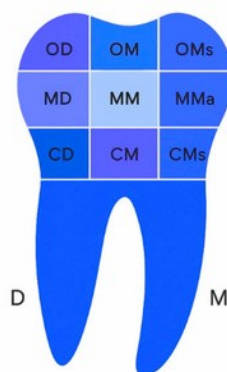
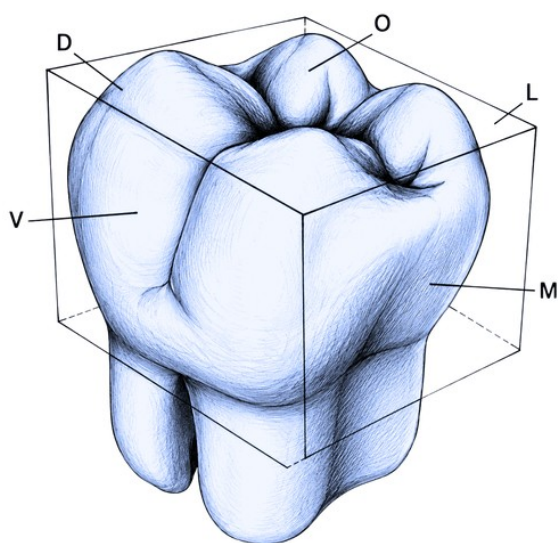
MOLARES

Anatomia Da Coroa

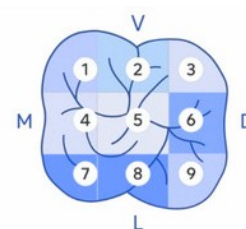
A coroa dos molares apresenta anatomia complexa e robusta, com grande volume e múltiplas faces bem definidas. A face vestibular é convexa, com sulcos ou cristas verticais que variam entre os diferentes molares. A face lingual ou palatina é igualmente convexa, com cúspides bem desenvolvidas que participam ativamente da mastigação. As faces mesial e distal apresentam cristas marginais elevadas, que delimitam a superfície oclusal e garantem estabilidade nos contatos interproximais.

A face oclusal é a mais complexa de toda a dentição, com múltiplas cúspides, sulcos principais e secundários, fossas e cristas triangulares organizadas de forma precisa. As cúspides dos molares superiores incluem a méso-vestibular, disto-vestibular, méso-palatina e disto-palatina, podendo existir também a cúspide de Carabelli no primeiro molar. Nos molares inferiores, identificam-se as cúspides méso-vestibular, disto-vestibular, méso-lingual e disto-lingual, com possibilidade de quinta cúspide distal no primeiro molar inferior.

O conhecimento detalhado da anatomia coronária dos molares é indispensável em todas as especialidades odontológicas. Em Dentística, a reprodução fiel das cúspides, cristas e sulcos é fundamental para o sucesso das restaurações. Em Ortodontia, a anatomia oclusal determina os pontos de contato e as guias oclusais para movimentação dentária adequada. Em Prótese, orienta o preparo de pilares e a confecção de coroas artificiais, garantindo função e estética ao tratamento reabilitador.



OD - oclusodistal OM - oclusomediano
OMs - oclusomesial MD - mediodistal
MM - mediomediano MMa - mediomesial
CD - cervicodistal CM - cervicomediano
CMs - cervicomesial



1. mesiovestibular
2. médiovestibular
3. disto-vestibular
4. mediomesial
5. mediomediano
6. mediodistal
7. mesiolingual
8. medianolingual
9. distolingual

ANOTAÇÕES

05

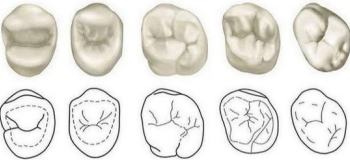
MOLARES

Anatomia Oclusal

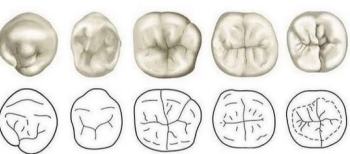
A superfície oclusal dos molares é a região anatômica de maior complexidade e importância funcional de toda a dentição humana. Ela é composta por **cúspides, sulcos principais e secundários, fossas e cristas triangulares** que trabalham em conjunto para garantir eficiência mastigatória e equilíbrio oclusal. As cúspides funcionais são aquelas que contatam as fossas ou cristas marginais dos antagonistas durante o fechamento mandibular, exercendo as forças mastigatórias diretamente sobre o alimento.

Nos molares superiores, o padrão oclusal mais comum é quadrangular, com quatro cúspides. O sulco central em H divide a superfície oclusal transversalmente, conectando as fossas mesial e distal. Nos molares inferiores, o primeiro molar apresenta padrão em Y com cinco cúspides, enquanto o segundo molar possui padrão em cruz com quatro cúspides simétricas. Cada padrão anatômico tem importância específica em restaurações, reabilitações e ajustes oclusais.

Aspecto oclusal de dentes posteriores maxilares

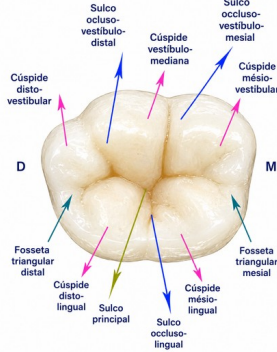


Aspecto oclusal de dentes posteriores mandibulares



DENTE	QUANTIDADE DE CÚSPIDES	CÚSPIDES
1º MOLAR SUPERIOR	4 (podendo apresentar tubérculo de Carabelli)	- Mésio-vestibular (MV) - Disto-vestibular (DV) - Mésio-palatina (MP) - Disto-palatina (DP)
2º MOLAR SUPERIOR	3 ou 4 (o padrão com 3 cúspides é o mais comum)	- Mésio-vestibular (MV) - Disto-vestibular (DV) - Mésio-palatina (MP) - Disto-palatina (DP) (quando presente)
3º MOLAR SUPERIOR	3, 4 ou mais (apresenta grande variação anatômica individual)	- Mésio-vestibular (MV) - Disto-vestibular (DV) - Mésio-palatina (MP) - Disto-palatina (DP) - Podem existir cúspides acessórias
1º MOLAR INFERIOR	5 (bem desenvolvidas)	- Mésio-vestibular (MV) - Médio-vestibular (MDV) - Disto-vestibular (DV) - Mésio-lingual (ML) - Disto-lingual (DL)
2º MOLAR INFERIOR	4	- Mésio-vestibular (MV) - Disto-vestibular (DV) - Mésio-lingual (ML) - Disto-lingual (DL)
3º MOLAR INFERIOR	4 ou 5 (varia bastante de pessoa para pessoa)	- Mésio-vestibular (MV) - Disto-vestibular (DV) - Mésio-lingual (ML) - Disto-lingual (DL) - Quando 5 cúspides: Médio-vestibular (MDV)

Primeiro Molar Inferior Esquerdo



ANOTAÇÕES

06

MOLARES

Anatomia Das Raízes

Os molares possuem **raízes múltiplas**, projetadas para distribuir as forças mastigatórias de maneira ampla sobre o osso alveolar e garantir a estabilidade desses dentes no arco. Os **molares superiores** apresentam tipicamente três raízes: **mésio-vestibular, disto-vestibular e palatina**. A raiz palatina é geralmente a mais longa e volumosa, enquanto a raiz mésio-vestibular é a mais estreita e com maior prevalência de dois canais radiculares, tornando-a de grande relevância endodôntica.

Os **molares inferiores** apresentam geralmente duas raízes bem individualizadas: **mesial e distal**. A raiz mesial é achatada e frequentemente contém dois canais radiculares. A raiz distal tende a ser mais volumosa e pode apresentar um ou dois canais. O conhecimento preciso da morfologia radicular dos molares é essencial para o sucesso em tratamentos endodônticos, pois variações anatômicas não identificadas estão entre as principais causas de falha terapêutica.

A anatomia radicular dos molares tem impacto direto em múltiplas especialidades odontológicas. Em Periodontia, a morfologia da furca exposta compromete a higienização e o prognóstico periodontal. Em Cirurgia Oral, raízes dilaceradas ou em estreita relação com o seio maxilar e o nervo alveolar inferior exigem planejamento detalhado, com uso de tomografia cone beam para minimizar riscos. Em Implantodontia, a forma das raízes influencia o volume ósseo disponível após as exodontias.

DENTE	IMAGEM	Nº DE RAÍZES (PADRÃO MAIS COMUM)	DESCRIÇÃO DAS RAÍZES	OBSERVAÇÕES
1º Molar Superior		3	2 vestibulares (mésio-vestibular e disto-vestibular) 1 palatina	Raiz palatina geralmente é a maior e mais robusta. As vestibulares são mais delgadas e podem apresentar sulcos.
2º Molar Superior		3	2 vestibulares (mésio-vestibular e disto-vestibular) 1 palatina	Raiz palatina geralmente é maior que as vestibulares. Pode haver raízes vestibulares fusionadas em um único tronco.
3º Molar Superior		3 (variável)	2 vestibulares (mésio-vestibular e disto-vestibular) 1 palatina - Pode haver fusão ou variações no número de raízes	Grande variação anatômica. Pode apresentar raízes adicionais (ex.: 4 raízes) ou fusão radicular.
1º Molar Inferior		2	1 mesial 1 distal	Raízes geralmente bem separadas. A raiz mesial costuma ser mais larga no sentido méso-distal.
2º Molar Inferior		2	1 mesial 1 distal	Raízes geralmente delgadas e bastante separadas.
3º Molar Inferior		2 (variável)	1 mesial 1 distal - Pode haver fusão, dilaceração ou variações no número de raízes	Grande variação anatômica. Pode apresentar raízes curvas, curtas, fusionadas ou número diferente de raízes.



ANOTAÇÕES

07

MOLARES

Primeiro Molar Superior

O primeiro molar superior é considerado um dos dentes mais importantes da oclusão permanente. Erupciona por volta dos seis anos de idade, sendo denominado popularmente de dente dos seis anos. Sua coroa apresenta formato quadrangular ou romboide pela face oclusal, com quatro cúspides principais: **mésio-vestibular**, **disto-vestibular**, **mésio-palatina** e **disto-palatina**. A cúspide mésio-palatina é frequentemente a maior e mais desenvolvida, funcionando como principal cúspide de suporte.

Uma característica anatômica exclusiva desse dente é a **cúspide de Carabelli**, estrutura acessória localizada na face mésio-palatina. Pode se apresentar como sulco superficial, pequena elevação ou cúspide completamente desenvolvida, variando em frequência entre populações. Sua presença é importante referência para identificação do dente e possui relevância clínica em restaurações.

A configuração radicular inclui **três raízes** individualizadas: palatina, mésio-vestibular e disto-vestibular. A raiz mésio-vestibular apresenta alta prevalência de dois canais radiculares, sendo de grande importância endodôntica. Por ser o primeiro permanente a erupcionar, qualquer perda precoce desencadeia graves consequências oclusais e desequilíbrio funcional de toda a arcada.

Tu

bé

rc ul

o d

e C

ar

ab

el li

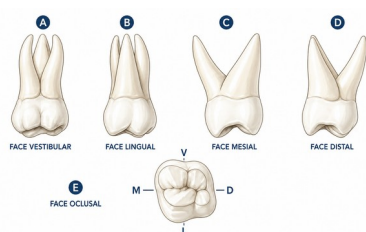


Figura 12.1 - Anatomia do 1º molar superior (D6). A - Face vestibular; B - Face lingual; C - Face mesial; D - Face distal; E - Face oclusal.



ANOTAÇÕES

08

MOLARES

Segundo Molar Superior

O segundo molar superior erupciona por volta dos doze a treze anos de idade. Sua anatomia assemelha-se ao primeiro molar superior, porém com diferenças importantes. O volume coronário é ligeiramente menor e a cúspide disto-palatina pode ser reduzida ou ausente, conferindo à coroa formato mais **triangular ou quadrangular**. Essa redução morfológica é um dos critérios de distinção entre os dois molares superiores.

A cúspide de Carabelli, quando presente, tem expressão muito menor que no primeiro molar, aparecendo apenas como sulco ou pequena depressão na face méso-palatina. A superfície oclusal apresenta quatro cúspides com padrão de sulcos similar ao primeiro molar, porém fossas frequentemente menos profundas.

Sua anatomia radicular inclui **três raízes** com maior tendência à convergência entre si quando comparadas ao primeiro molar. A raiz méso-vestibular ainda pode apresentar dois canais, porém com menor frequência. Clinicamente, tem papel fundamental como suporte protético em reabilitações extensas, e sua perda provoca alterações funcionais importantes na estabilidade posterior da oclusão.

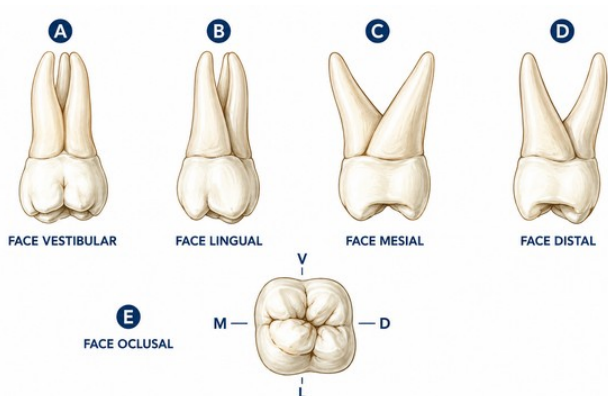
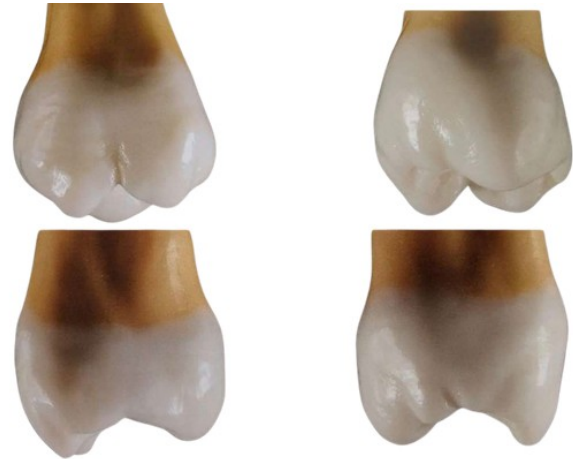


Figura 13.1 – Anatomia do 2º molar superior (27). A – Face vestibular; B – Face lingual; C – Face mesial; D – Face distal; E – Face oclusal.



ANOTAÇÕES

09

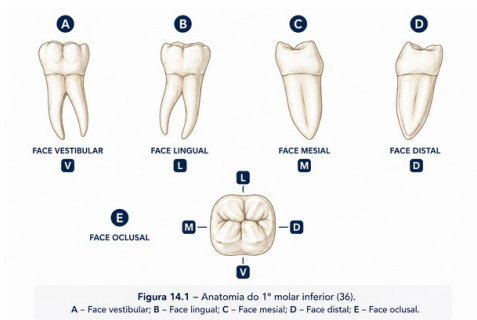
MOLARES

Primeiro Molar Inferior

O primeiro molar inferior é o primeiro dente permanente a aparecer na cavidade oral, geralmente por volta dos seis anos, tornando-o altamente vulnerável à cárie dental. Sua coroa apresenta formato retangular pela face oclusal e é o maior dos molares inferiores. A anatomia oclusal clássica inclui cinco cúspides: **mésio-vestibular, central-vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual e disto-lingual**, formando o característico padrão em Y. Esse padrão oclusal é uma das principais referências anatômicas para identificação do dente.

A superfície oclusal apresenta fossas mesial, central e distal bem definidas, conectadas por sulcos que separam as cúspides. As cristas triangulares convergem para a fossa central, criando morfologia oclusal complexa e funcionalmente eficiente. Sua posição estratégica na arcada o torna o molar de maior participação na mastigação e no estabelecimento da oclusão permanente.

Sua anatomia radicular compreende **duas raízes: mesial e distal**. A raiz mesial é achatada e frequentemente apresenta dois canais radiculares, aumentando a complexidade endodôntica. A raiz distal costuma ser mais volumosa com geralmente um canal. Por ser o primeiro permanente, sua perda precoce provoca consequências oclusais graves, tornando indispensável a orientação familiar sobre higiene bucal desde os seis anos.



ANOTAÇÕES

10

MOLARES

Segundo Molar Inferior

O segundo molar inferior erupciona aproximadamente aos doze anos. Sua coroa apresenta formato retangular pela face oclusal, com quatro cúspides bem definidas: **mésio-vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual e disto-lingual**. Diferentemente do primeiro molar inferior, com cinco cúspides e padrão em Y, o segundo molar possui padrão oclusal em forma de cruz, com sulcos cruzando a superfície oclusal nos sentidos méso-distal e vestibulo-lingual.

Essa anatomia mais simples facilita a identificação e diferenciamento entre os dois molares inferiores. As quatro cúspides apresentam tamanhos mais homogêneos, contribuindo para distribuição equilibrada das forças mastigatórias. A fossa central é profunda e bem definida, servindo de área receptora das cúspides antagonistas durante a oclusão. O segundo molar inferior e o segundo molar superior trabalham em conjunto formando a segunda unidade mastigatória. Seu correto relacionamento oclusal é fundamental para a distribuição equilibrada das forças mastigatórias. Restaurações que alteram a morfologia oclusal podem provocar interferências que sobrecarregam as articulações temporomandibulares e os tecidos periodontais de suporte.

O segundo molar inferior apresenta **duas raízes: mesial e distal**, com menor frequência de variações que no primeiro molar. Junto com o primeiro molar, constitui a principal unidade mastigatória posterior, sendo sua preservação indispensável para a saúde funcional do sistema mastigatório. A perda bilateral desses molares provoca colapso posterior, com graves consequências para a oclusão e qualidade de vida.

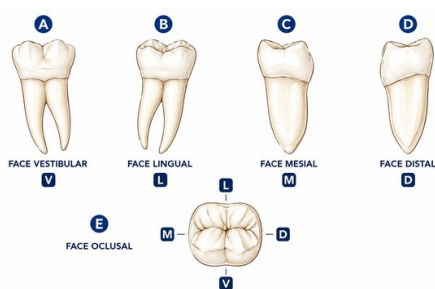


Figura 15.1 – Anatomia do 2º molar inferior (37).
A – Face vestibular; B – Face lingual; C – Face mesial; D – Face distal; E – Face oclusal.



ANOTAÇÕES

11

MOLARES

Terceiros Molares

Os terceiros molares, popularmente conhecidos como **sisos** ou dentes do juízo, são os últimos a erupcionarem na dentição permanente, com cronologia muito variável entre os dezessete e vinte e cinco anos. São os dentes com maior **variabilidade anatômica** da dentição, podendo apresentar desde morfologia semelhante aos demais molares até formas completamente atípicas, com fusão de cúspides, raízes fundidas e coroa de tamanho reduzido.

A impatção dos terceiros molares é a condição mais prevalente em cirurgia oral. Pode ser classificada como vertical, mesioangular, distoangular ou horizontal, cada classificação indicando diferentes graus de dificuldade cirúrgica. Dentes impactados podem causar pericoronarite, cárie no segundo molar adjacente, reabsorção radicular e formação de cistos dentígeros.

Os terceiros molares superiores apresentam **geralmente três raízes, porém com alta frequência de fusão radicular**. Os inferiores costumam apresentar duas raízes com variações de curvatura, sendo comuns raízes dilaceradas que aumentam a dificuldade cirúrgica. A avaliação pré-operatória com radiografia panorâmica e tomografia cone beam é indispensável para planejamento seguro das exodontias e prevenção de complicações.



ANOTAÇÕES

12

MOLARES

Funções Mastigatórias

Os molares são os principais responsáveis pela função mastigatória no sistema estomatognático. Sua grande superfície oclusal, múltiplas cúspides e posição posterior permitem exercer forças mastigatórias elevadas, essenciais para a **trituração e moagem eficiente dos alimentos**. A eficiência mastigatória dos molares é consideravelmente superior à dos demais dentes, sendo responsáveis por grande parte do trabalho mecânico realizado durante a alimentação.

Durante o ciclo mastigatório, os molares participam de movimentos mandibulares complexos: **abertura, fechamento, lateralidade e protrusão**. Em cada fase, cúspides específicas contatam os antagonistas, realizando a fragmentação dos alimentos. A eficiência depende da integridade anatômica, do correto relacionamento oclusal e da saúde dos tecidos de suporte.

A **relação entre a anatomia dos molares e a eficiência mastigatória** é direta e bem estabelecida. Cada sulco, cúspide e fossa contribui para o direcionamento e fragmentação dos alimentos. Restaurações que alteram essa morfologia podem comprometer a função e provocar sintomas no sistema mastigatório. Por isso, o conhecimento anatômico preciso é tão importante quanto a habilidade técnica nos procedimentos restauradores.

A **perda dos molares** compromete diretamente a eficiência mastigatória e provoca sobrecarga nos dentes remanescentes. Esse desequilíbrio pode gerar desgaste prematuro, dores musculares, disfunção temporomandibular e problemas digestivos. A reabilitação oral com próteses ou implantes é fundamental para restaurar a função mastigatória e preservar a saúde do sistema estomatognático.



ANOTAÇÕES

13

MOLARES

Importância Clínica

Os molares possuem importância clínica em praticamente todas as especialidades odontológicas. Em **Dentística Restauradora**, a reconstrução anatômica precisa da face oclusal é essencial para o sucesso de restaurações diretas e indiretas. Em **Endodontia**, são os dentes de maior complexidade anatômica, com alta prevalência de variações nos canais radiculares que exigem magnificação e técnica refinada.

Na **Prótese e Implantodontia**, a perda de molares é a indicação mais frequente para instalação de implantes. A reconstrução com coroas implantossuportadas deve respeitar rigorosamente a anatomia oclusal para garantir função adequada. Em **Periodontia**, molares com furca exposta exigem manutenção especializada. Em Cirurgia Oral, a extração de molares com raízes complexas requer planejamento detalhado e conhecimento anatômico aprofundado.

A **odontologia preventiva** é fundamental na preservação dos molares ao longo da vida. O selamento de fossas e fissuras, aplicação de flúor, higiene oral adequada e consultas periódicas são medidas indispensáveis. Especialmente o primeiro molar inferior, que erupciona aos seis anos e frequentemente é confundido com dente de leite pelos responsáveis, merece atenção especial nos programas de saúde bucal pública.

A perda dos molares provoca consequências funcionais, estéticas e sistêmicas. Funcionalmente, reduz a eficiência mastigatória, provoca migração e extrusão dos dentes adjacentes e antagonistas, e sobrecarrega os remanescentes. Sistemicamente, a mastigação deficiente contribui para problemas nutricionais e digestivos. Por todas essas razões, a prevenção e a reabilitação precoce dos molares ausentes são prioridades na promoção da saúde bucal.



ANOTAÇÕES

Anatomia Dental

Dentes Decíduos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 8

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Odontogênese	5
03 Características Gerais	6
04 Arcada Dentária Decídua	7
05 Classificação Sistema FDI	8
06 Anatomia Dos Incisivos Decíduos	9
07 Anatomia Dos Caninos Decíduos	10
08 Anatomia Dos Molares Decíduos	11
09 Tecidos Dentários dos Decíduos	14
10 Erupção dos Dentes Decíduos	15
11 Rizólise e Esfoliação	16

01

DENTES DECÍDUOS

Introdução

A anatomia dental dos dentes decíduos constitui uma das áreas mais importantes da odontologia, especialmente na odontopediatria, pois envolve o estudo detalhado da **estrutura, forma, composição e função dos dentes temporários presentes na infância**. Os dentes decíduos, popularmente conhecidos como “**dentes de leite**”, representam a primeira dentição humana e desempenham funções fundamentais para o crescimento e desenvolvimento adequado da criança. Apesar de serem temporários, possuem importância biológica extremamente elevada, participando diretamente da **mastigação, fala, respiração, estética facial e manutenção do espaço** necessário para a erupção dos dentes permanentes. O conhecimento anatômico detalhado dessa dentição é indispensável para compreensão dos processos fisiológicos e patológicos que acometem a cavidade oral infantil.

Os dentes decíduos apresentam características anatômicas muito diferentes da dentição permanente. Eles possuem **tamanho reduzido, esmalte e dentina mais finos, coloração mais clara, raízes delgadas e divergentes, além de câmaras pulpares proporcionalmente maiores**. Essas particularidades influenciam diretamente os tratamentos odontológicos, tornando essencial o domínio anatômico para realização de procedimentos restauradores, endodônticos, ortodônticos e cirúrgicos. Além disso, a proximidade anatômica entre as raízes dos dentes decíduos e os germes permanentes exige extremo cuidado clínico, já que infecções ou traumatismos podem comprometer o desenvolvimento da dentição permanente.

A dentição decídua é composta por **20 dentes**, distribuídos igualmente entre maxila e mandíbula. Em cada hemiarcada encontram-se dois incisivos, um canino e dois molares. A **ausência de pré-molares** na dentição decídua constitui uma característica marcante. Esses dentes começam seu desenvolvimento ainda durante a vida intrauterina, através do processo de odontogênese, e permanecem em função até o período da dentição mista, quando ocorre sua substituição gradual pelos dentes permanentes. Portanto, compreender profundamente a anatomia dos dentes decíduos é fundamental para entender não apenas a odontologia infantil, mas também o desenvolvimento global do sistema estomatognático humano.





ANOTAÇÕES

02

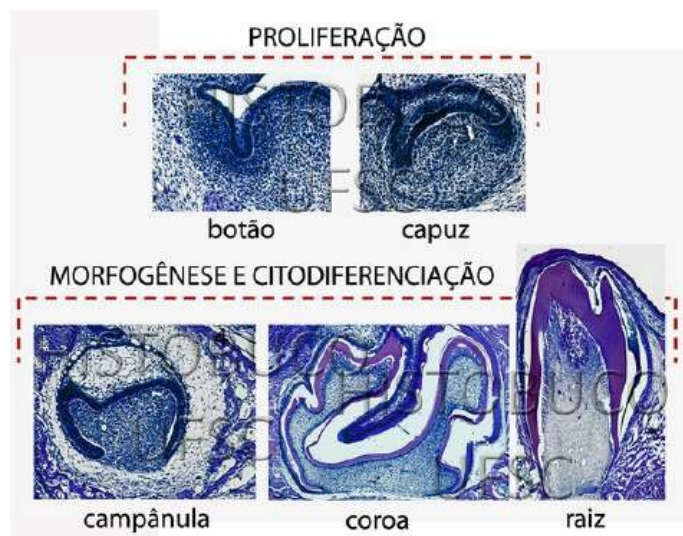
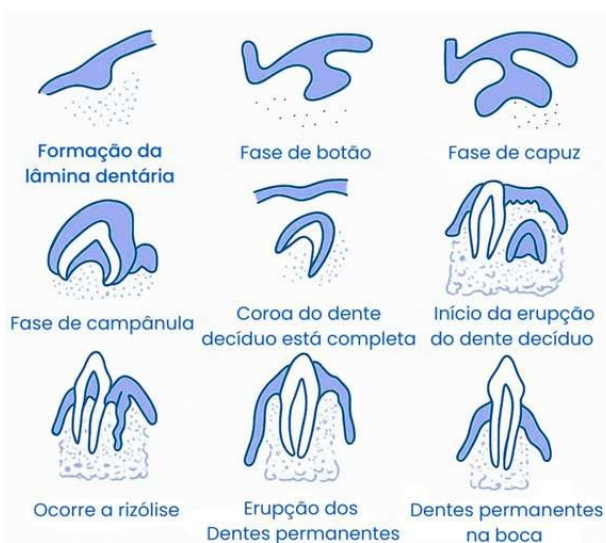
DENTES DECÍDUOS

Odontogênese

A odontogênese é o processo biológico responsável pela formação dos dentes e inicia-se precocemente na vida intrauterina, aproximadamente na sexta semana de desenvolvimento embrionário. Esse processo resulta da interação complexa entre o **epitélio ectodérmico da cavidade oral primitiva** e o **ectomesênquima originado das células da crista neural**. A formação dentária ocorre através de uma sequência ordenada de eventos celulares e moleculares altamente especializados, envolvendo proliferação, diferenciação, deposição de matriz extracelular e mineralização. Qualquer alteração genética, metabólica ou ambiental durante essas etapas pode provocar anomalias estruturais nos dentes decíduos.

O **primeiro estágio** da odontogênese corresponde à formação da lâmina dentária, estrutura epitelial responsável pela origem dos germes dentários. Em seguida ocorre o **estágio de broto**, caracterizado pela intensa proliferação celular em direção ao ectomesênquima subjacente. Posteriormente desenvolvem-se os **estágios de capuz e campânula**, fases nas quais ocorre diferenciação dos tecidos dentários e definição morfológica das coroas. Durante o estágio de campânula surgem células altamente especializadas como os ameloblastos, responsáveis pela produção do esmalte, e os odontoblastos, encarregados da formação da dentina.

A **formação radicular** dos dentes decíduos inicia-se após o término da coroa e depende da bainha epitelial de Hertwig, estrutura responsável pela orientação anatômica das raízes. Nos molares decíduos, as raízes tornam-se extremamente divergentes para acomodar os germes dos dentes permanentes em desenvolvimento. Simultaneamente ocorre mineralização progressiva dos tecidos dentários, principalmente esmalte e dentina.



ANOTAÇÕES

03

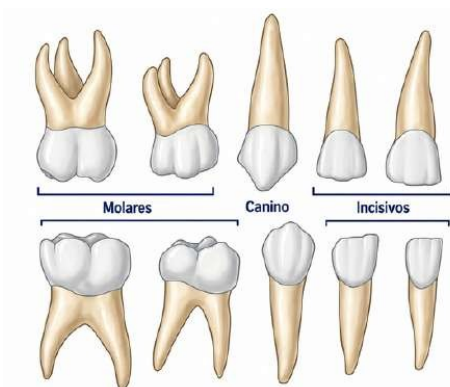
DENTES DECÍDUOS

Características Gerais

Os dentes decíduos apresentam características anatômicas próprias que os diferenciam significativamente dos dentes permanentes. Uma das principais diferenças está relacionada ao **tamanho reduzido das coroas dentárias, que são menores tanto no sentido méso-distal quanto cérvico-oclusal**. Além disso, os dentes decíduos possuem coloração **branco-leitosa** devido à menor espessura da dentina e à maior opacidade do esmalte. Essa aparência mais clara é uma das características clínicas mais marcantes da dentição infantil.

Outra característica anatômica importante é a presença de **esmalte e dentina mais finos**. O esmalte dos dentes decíduos apresenta aproximadamente metade da espessura observada nos permanentes, tornando-os mais suscetíveis ao desgaste e à rápida progressão da cárie dentária. A dentina também é menos espessa e mais permeável, favorecendo a disseminação bacteriana em direção à polpa. Consequentemente, lesões cariosas pequenas podem atingir rapidamente os tecidos pulpare.

Os dentes decíduos apresentam ainda **constricção cervical** bastante acentuada, especialmente nos molares, produzindo coroas bulbosas com grande convexidade vestibular. As **raízes são longas, delgadas e extremamente divergentes**, principalmente nos molares, permitindo espaço para os dentes permanentes em desenvolvimento. Internamente, as câmaras pulpare são amplas e os cornos pulpare muito proeminentes, aumentando o risco de exposição pulpar durante procedimentos restauradores. Essas características anatômicas possuem enorme importância clínica na odontopediatria.



ANOTAÇÕES

04

DENTES DECÍDUOS

Arcada Dentária Decídua

A arcada dentária decídua corresponde ao conjunto de dentes temporários distribuídos nos ossos maxilares da criança durante a primeira fase da dentição humana. Essa arcada possui enorme importância anatômica e funcional, pois participa diretamente do desenvolvimento craniofacial, mastigação, fala, respiração e crescimento adequado das estruturas ósseas da face.

A dentição decídua é composta por **20 dentes, distribuídos igualmente entre maxila e mandíbula, sendo 10 dentes em cada arcada**. Em cada hemiarcada encontram-se dois incisivos, um canino e dois molares, não existindo pré-molares na dentição decídua. A organização desses dentes dentro das arcadas segue um padrão anatômico específico que garante equilíbrio funcional durante a infância.

As arcadas dentárias decíduas apresentam características anatômicas próprias que as diferenciam significativamente das arcadas permanentes. De modo geral, a **arcada superior** possui formato mais arredondado e amplo, enquanto a **inferior** tende a apresentar formato mais parabólico.

Os dentes decíduos são menores e mais espaçados, sendo comum a presença de diastemas fisiológicos entre eles. Esses espaços são extremamente importantes para acomodar os dentes permanentes futuros, que possuem dimensões maiores. A ausência desses espaços pode indicar predisposição ao apinhamento dentário na dentição permanente.



Dente	Arcada Superior	Arcada Inferior
Incisivo Central	2	2
Incisivo Lateral	2	2
Canino	2	2
1º Molar	2	2
2º Molar	2	2
TOTAL	10	10

ANOTAÇÕES

05

DENTES DECÍDUOS

Classificação Sistema FDI

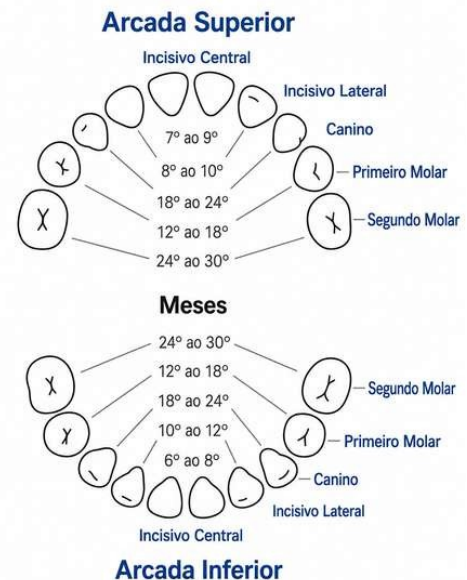
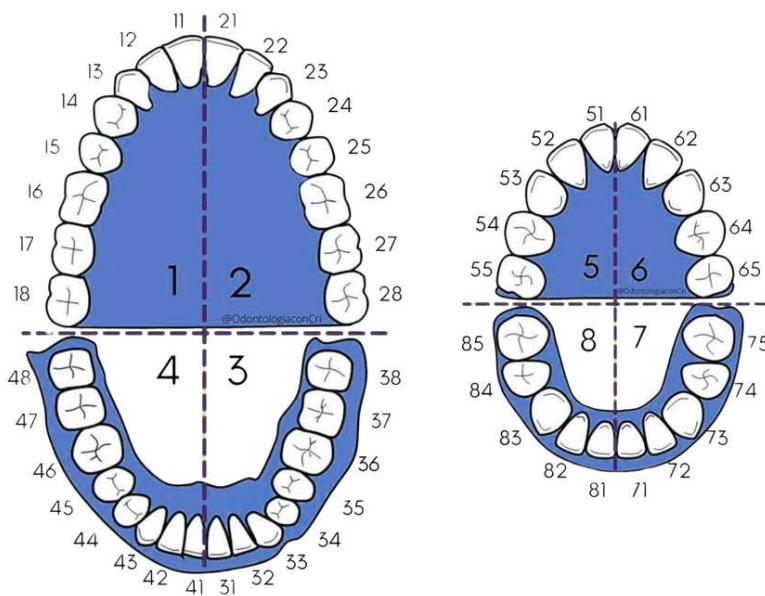
Quadrante Superior Direito — Quadrante 5 51 → Incisivo Central Superior Direito 52 → Incisivo Lateral Superior Direito 53 → Canino Superior Direito 54 → Primeiro Molar Superior Direito 55 → Segundo Molar Superior Direito

Quadrante Superior Esquerdo — Quadrante 6 61 → Incisivo Central Superior Esquerdo 62 → Incisivo Lateral Superior Esquerdo 63 → Canino Superior Esquerdo 64 → Primeiro Molar Superior Esquerdo 65 → Segundo Molar Superior Esquerdo

Quadrante Inferior Esquerdo — Quadrante 7 71 → Incisivo Central Inferior Esquerdo 72 → Incisivo Lateral Inferior Esquerdo 73 → Canino Inferior Esquerdo 74 → Primeiro Molar Inferior Esquerdo 75 → Segundo Molar Inferior Esquerdo

Quadrante Inferior Direito — Quadrante 8 81 → Incisivo Central Inferior Direito 82 → Incisivo Lateral Inferior Direito 83 → Canino Inferior Direito 84 → Primeiro Molar Inferior Direito 85 → Segundo Molar Inferior Direito

DireitaEsquerda



ANOTAÇÕES

06

DENTES DECÍDUOS

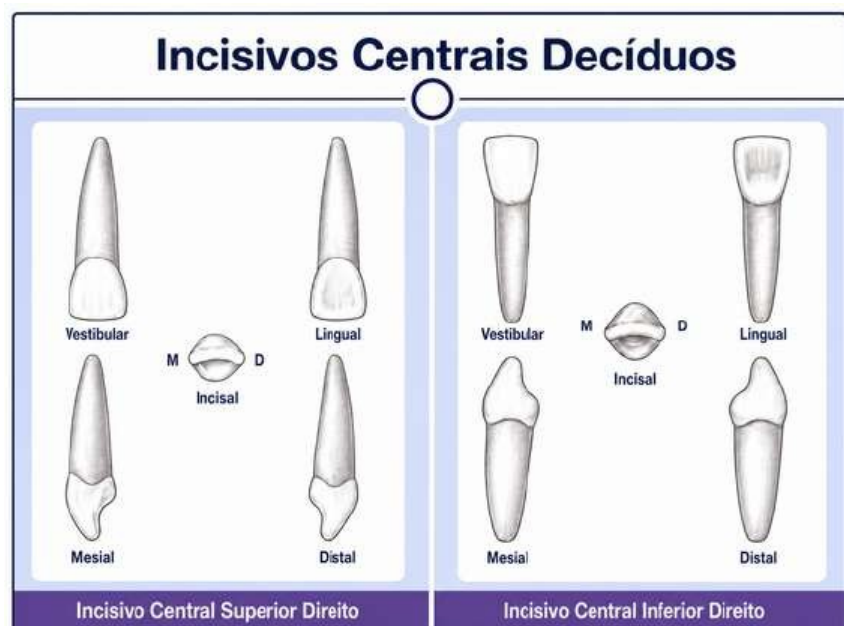
Anatomia Dos Incisivos Decíduos

Os incisivos decíduos são dentes anteriores especializados na incisão e corte dos alimentos. Possuem **coroas relativamente pequenas e largas no sentido méso-distal, com bordas incisais retas e superfícies lisas**. Os **incisivos centrais** superiores são os maiores dentes anteriores da dentição decídua e apresentam forma mais quadrangular. Sua face vestibular é convexa e pouco marcada por sulcos de desenvolvimento, enquanto a face lingual apresenta cingulo discreto e fossas rasas.

Os **incisivos laterais** superiores possuem dimensões menores e forma mais arredondada. Já os incisivos inferiores são mais estreitos e simétricos, apresentando aspecto anatômico delicado. A raiz dos incisivos decíduos é longa e afilada, proporcionando estabilidade funcional durante a mastigação e fala. Internamente, possuem canal radicular único e câmara pulpar relativamente ampla, acompanhando a anatomia externa do dente.

Além da função mastigatória, os incisivos desempenham papel fundamental na **fonética infantil e na estética facial**. Eles participam diretamente da pronúncia de sons linguodentais e labiodentais. A perda precoce desses dentes pode causar alterações emocionais, sociais e fonéticas significativas na criança. Por esse motivo, o conhecimento anatômico detalhado dos incisivos decíduos é essencial para o manejo clínico em odontopediatria.

Incisivo Central Superior



ANOTAÇÕES

07

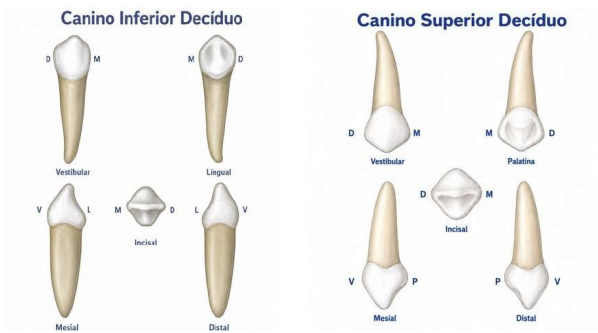
DENTES DECÍDUOS

Anatomia Dos Caninos Decíduos

Os caninos decíduos possuem função importante no **rasgamento dos alimentos e na orientação dos movimentos mandibulares**. Sua anatomia apresenta cúspide única bem definida, embora menos pontiaguda que nos dentes permanentes. Os caninos superiores possuem coroas mais largas e volumosas, enquanto os inferiores são mais estreitos e alongados. A face vestibular é convexa e apresenta discreta crista longitudinal central.

A face lingual dos caninos apresenta cingulo desenvolvido e fossas rasas delimitadas por cristas marginais. A raiz é extremamente longa, cônica e resistente, sendo uma das maiores proporcionalmente da dentição decídua. Essa característica garante estabilidade funcional e resistência às forças mastigatórias durante a infância.

Do ponto de vista oclusal, os caninos desempenham importante papel na guia de desocclusão durante os movimentos laterais da mandíbula. Eles auxiliam no equilíbrio funcional das arcadas dentárias e contribuem para manutenção da dimensão vertical da face. Sua anatomia robusta também influencia significativamente a estética do sorriso infantil.



ANOTAÇÕES

08

DENTES DECÍDUOS

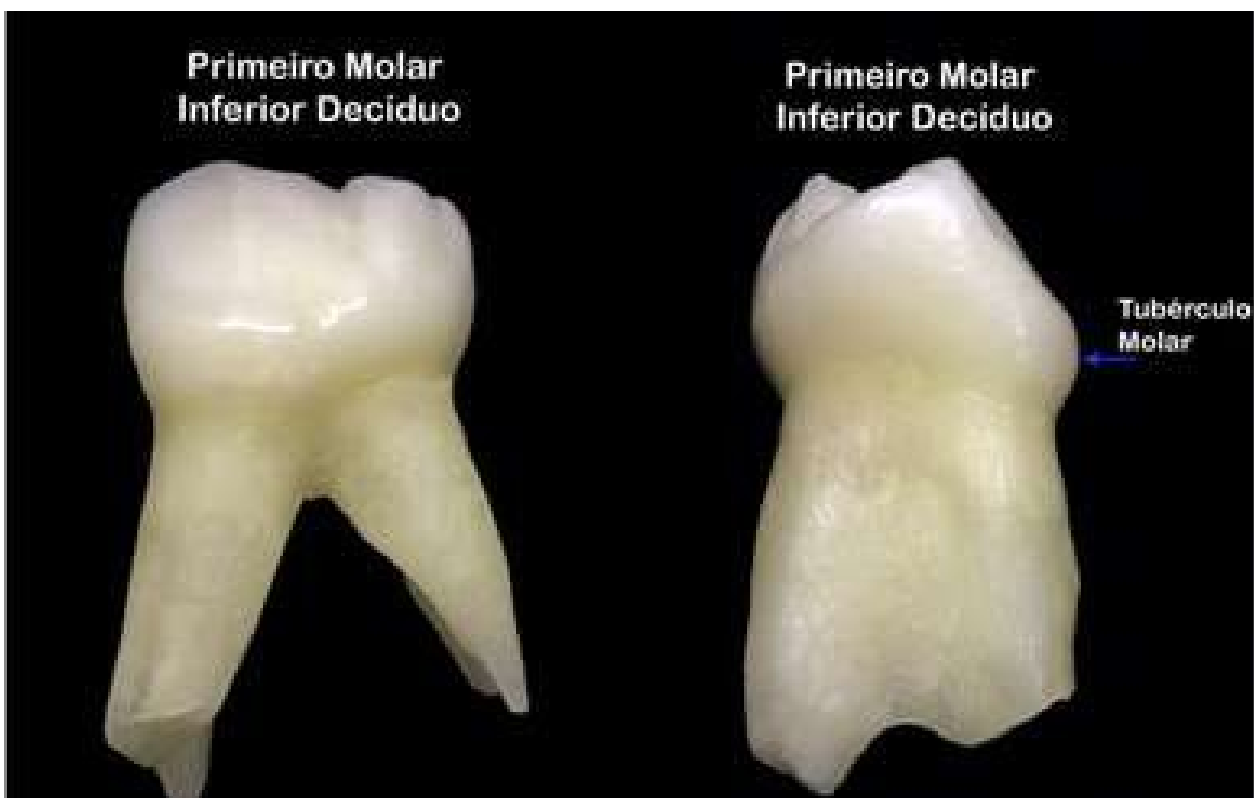
Anatomia Dos Molares Decíduos

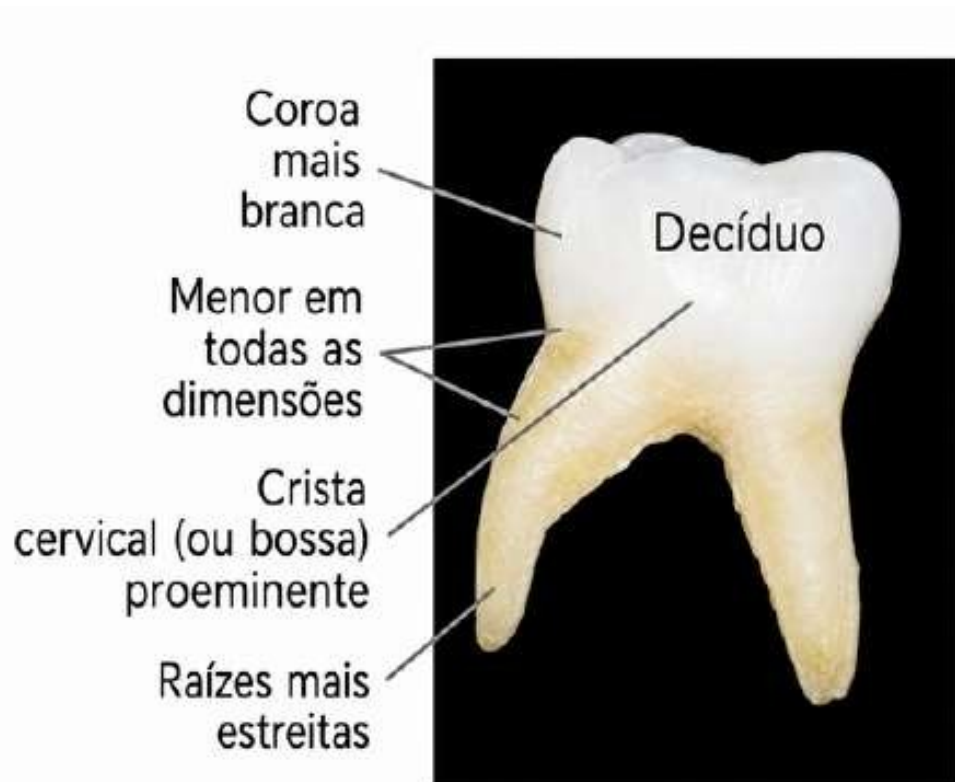
Os molares decíduos apresentam anatomia extremamente peculiar e desempenham função essencial na mastigação infantil. Suas coroas são bulbosas, com grande constrição cervical e superfícies oclusais relativamente estreitas. Os **primeiros molares** decíduos possuem morfologia bastante variável e frequentemente são considerados dentes únicos, sem equivalente direto na dentição permanente.

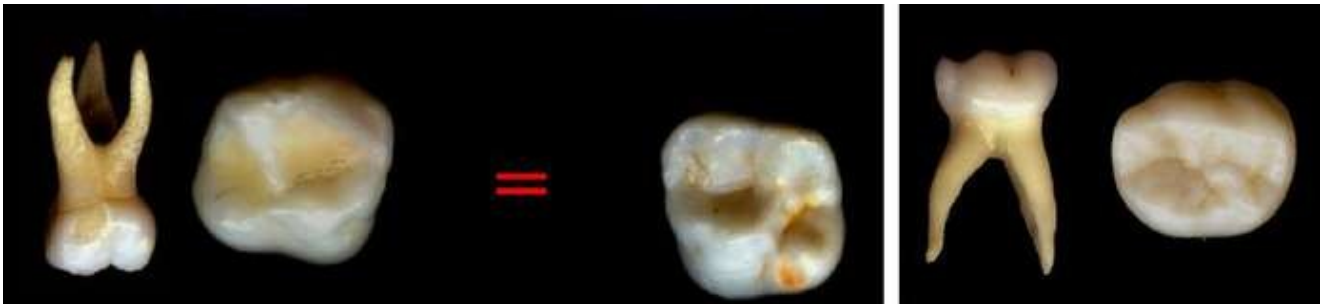
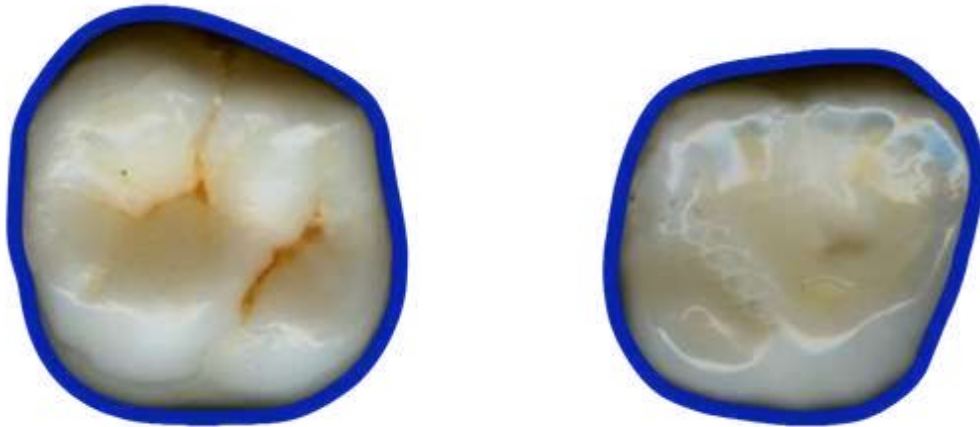
Os **segundos molares** decíduos apresentam grande semelhança anatômica com os primeiros molares permanentes. O segundo molar superior geralmente possui quatro cúspides bem definidas e ocasional presença do tubérculo de Carabelli. Já o segundo molar inferior apresenta cinco cúspides e sulcos oclusais semelhantes ao primeiro molar permanente inferior.

Decíduo

As raízes dos molares decíduos são extremamente finas e divergentes, característica essencial para acomodar os germes dos dentes permanentes localizados entre elas. Internamente, apresentam ampla câmara pulpar e canais radiculares delicados, frequentemente curvos e acessórios. Essas características tornam os tratamentos endodônticos infantis mais complexos.

2° Molar Superior Decíduo 2° Molar Inferior Decíduo





ANOTAÇÕES

09

DENTES DECÍDUOS

Tecidos Dentários dos Decíduos

O **esmalte** dos dentes decíduos é menos espesso e menos mineralizado quando comparado ao dos dentes permanentes. Essa menor espessura facilita o desgaste fisiológico e acelera a progressão de lesões cariosas. Além disso, os prismas do esmalte possuem orientação diferente na região cervical, aspecto relevante durante preparos cavitários.

A **dentina** dos dentes decíduos também apresenta características próprias. Seus túbulos dentinários são mais amplos e permeáveis, favorecendo rápida disseminação bacteriana. A menor espessura dentinária faz com que a polpa seja atingida precocemente em casos de cárie dentária.

A **polpa dentária** é volumosa, altamente vascularizada e rica em células. Os cornos pulpaes são muito proeminentes, especialmente nos molares. Essa anatomia pulpar aumenta significativamente o risco de exposição acidental durante procedimentos restauradores e exige técnicas clínicas conservadoras na odontopediatria.



ANOTAÇÕES

10

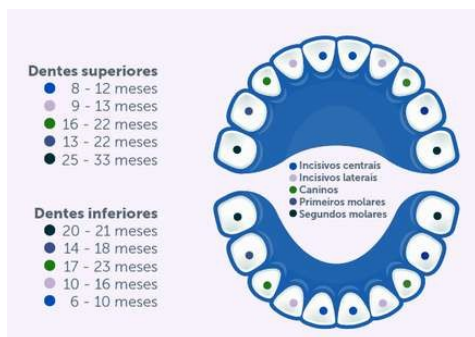
DENTES DECÍDUOS

Erupção dos Dentes Decíduos

A erupção dentária corresponde ao movimento fisiológico do dente desde sua posição intraóssea até alcançar a cavidade oral. Nos dentes decíduos, esse processo inicia-se geralmente aos seis meses de idade com os incisivos centrais inferiores. A sequência eruptiva segue padrão relativamente constante até a completa formação da dentição decídua por volta dos **30 meses**.

O processo eruptivo envolve **remodelação óssea intensa, crescimento radicular e reorganização dos tecidos periodontais**. A anatomia das raízes em desenvolvimento participa diretamente da movimentação eruptiva. Simultaneamente ocorre maturação funcional das articulações temporomandibulares e musculatura mastigatória.

As arcadas dentárias decíduas apresentam espaços fisiológicos importantes, conhecidos como espaços primatas. Esses espaços permitem acomodação futura dos dentes permanentes, que possuem maiores dimensões. A ausência desses espaços pode indicar predisposição ao apinhamento dentário.



ERUPÇÃO DOS DENTES DECÍDUOS		
	DENTES SUPERIORES	DENTES INFERIORES
Incisivos centrais	8 meses	6 meses
Incisivos laterais	10 meses	9 meses
Caninos	20 meses	18 meses
Primeiros molares	16 meses	16 meses
Segundos molares	29 meses	27 meses

Fonte: CURITIBA. Secretaria da Saúde. Protocolo Integrado de atenção à saúde bucal. Curitiba: SMS, Centro de Informações em Saúde, 2004.100p.

ANOTAÇÕES

11

DENTES DECÍDUOS

Rizólise e Esfoliação

A **rizólise** é o processo fisiológico de reabsorção das raízes dos dentes decíduos, permitindo sua substituição pelos dentes permanentes. Esse processo ocorre devido à ação de células clásticas estimuladas pela pressão eruptiva dos dentes sucessores permanentes.

A **reabsorção radicular** inicia-se geralmente na região lingual das raízes e progride gradualmente até provocar mobilidade dentária. Conforme ocorre perda radicular, os dentes tornam-se menos estáveis até sua esfoliação natural.

Alterações nesse processo podem resultar em retenção prolongada de dentes decíduos, erupção ectópica ou problemas ortodônticos. O acompanhamento clínico e radiográfico é fundamental para monitoramento adequado da troca dentária.



Figura 5 - Radiografia periapical com Esfoliação natural após 2 dias



ANOTAÇÕES

Anatomia Dental

Escultura Dental

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 9

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Introdução	3
02 Materiais Utilizados	4
03 Identificação das Faces	5
04 Medição e Demarcação	6
05 Moldes	7
06 Passo a passo geral	8
07 Escultura dos Incisivos	9
08 Escultura dos Caninos	11
09 Escultura em Pré-Molares	12
10 Escultura em Molares	13
11 Contato e relações Anatômicas	14
12 Acabamento Final	15

01

ESCULTURA DENTAL

Introdução

A escultura dental é uma prática essencial no aprendizado da Odontologia, principalmente porque ajuda o estudante a compreender a forma dos dentes de maneira tridimensional. Ao esculpir um dente em cera, o aluno não está apenas copiando uma **estrutura anatômica**, mas **treinando o olhar clínico, a coordenação motora, a noção de profundidade, proporção, inclinação, volume e simetria**. Essa habilidade será muito importante em várias áreas da Odontologia, principalmente na Dentística Restauradora, Prótese, Anatomia Dental, Oclusão e Reabilitação Oral.

Cada dente possui uma forma específica e essa forma está diretamente relacionada à sua função. Os **incisivos**, por exemplo, possuem bordas cortantes porque são responsáveis por cortar os alimentos. Os caninos têm formato mais pontiagudo e robusto, pois ajudam a perfurar e rasgar. Os **pré-molares** apresentam cúspides que iniciam a trituração dos alimentos, enquanto os **molares** possuem uma face oclusal mais ampla e complexa, responsável pela trituração mais intensa. Por isso, quando se altera a forma dental, também se pode alterar a função mastigatória, a estética, a fonética, os contatos entre os dentes e a saúde dos tecidos gengivais.

A escultura dental em cera permite que o estudante compreenda, de forma prática, detalhes como **linha cervical, bossas, cúspides, cristas marginais, sulcos, fossas, fósulas, vertentes, bordas incisais e áreas de contato**. Esses elementos anatômicos não existem por acaso. Eles orientam o escoamento dos alimentos, protegem a gengiva, estabilizam os dentes no arco e permitem que a mastigação aconteça de maneira equilibrada. Por isso, uma escultura bem feita deve ser anatômica, funcional e proporcional.



ANOTAÇÕES

02

ESCULTURA DENTAL

Materiais Utilizados

PONTOS-CHAVE

Separe o bloco de cera e observe se ele está inteiro, sem fraturas, trincas ou deformações visíveis. Um bloco danificado pode quebrar durante o corte e comprometer todo o trabalho.

Organize os instrumentos principais, como **estilete**, **espátula Lecron** e **Hollemback**. O estilete será usado para os cortes iniciais; a Lecron para desgaste, alisamento e refinamento; e o Hollemback para detalhes mais delicados.

Separe **régua**, **paquímetro ou espessímetro** para realizar as medidas iniciais. Esses instrumentos ajudam a manter o tamanho correto da coroa e evitam que o dente fique desproporcional.

Prepare também **papel**, **lápiz**, **borracha** e **tesoura**, caso seja necessário desenhar e recortar silhuetas do dente escolhido. Essa etapa facilita a transferência da anatomia para o bloco de cera.

Deixe próximos os materiais de acabamento, como **escova macia**, **meia de seda**, **pincel** e **talco**. Eles serão usados no final, mas devem estar disponíveis para evitar interrupções.

Limpe a bancada antes de começar, retirando restos de cera, papéis ou objetos que possam atrapalhar o apoio das mãos e do bloco.

Apoie o bloco em uma **superfície firme e estável**. Durante a escultura, a estabilidade do bloco é essencial para evitar cortes tortos ou acidentes.

Mantenha postura adequada, com os braços apoiados e movimentos controlados. A escultura deve ser feita com calma, sem força excessiva.

Hollemback

Lecron



ANOTAÇÕES

03

ESCULTURA DENTAL

Identificação das Faces

PONTOS-CHAVE

Escolha uma das faces maiores do bloco para representar a face vestibular. Essa face será marcada com a letra **"V"** e servirá como referência principal da escultura.

Na face oposta à vestibular, marque **"L"** se o dente for inferior ou **"P"** se o dente for superior. Essa será a face lingual ou palatina, dependendo do arco escolhido.

Escolha uma das faces laterais para representar a face mesial e marque com a letra **"M"**. Lembre-se de que a mesial é a face voltada para a linha média do arco.

Na face oposta à mesial, marque a letra **"D"**, indicando a face distal. A distal costuma ser mais arredondada e mais inclinada que a mesial em muitos dentes.

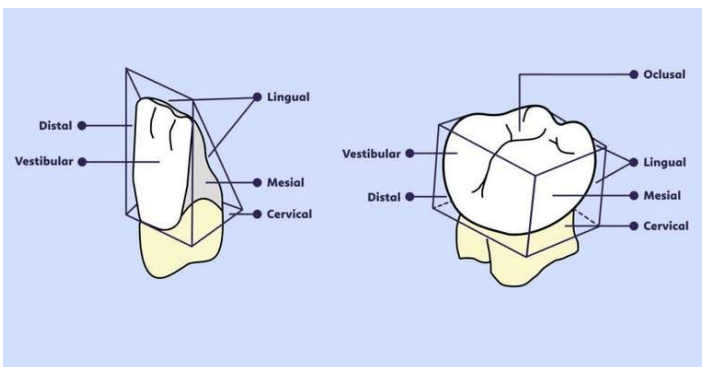
Marque a **região cervical**, que corresponde à área próxima ao colo do dente. Essa região será importante para desenhar a linha cervical e posicionar as bossas.

Marque a **região incisal**, se estiver esculpindo dentes anteriores, ou a **região oclusal**, se estiver esculpindo dentes posteriores.

Antes de cortar, confira se todas as letras estão posicionadas corretamente. Essa conferência evita que o aluno trabalhe a anatomia em faces erradas.

Durante toda a escultura, retorne às marcações das faces para não perder a orientação espacial do dente.

DVM



ANOTAÇÕES

04

ESCULTURA DENTAL

Medição e Demarcação

PONTOS-CHAVE

Posicione o bloco de cera em pé sobre uma superfície plana e observe sua altura total. Antes de marcar, certifique-se de que o bloco está estável.

Com a régua ou paquímetro, meça **aproximadamente 12 mm para delimitar a área da coroa que será esculpida**. Faça uma marca leve com o estilete ou lápis.

Continue essa **linha ao redor do bloco**, passando pelas faces vestibular, lingual ou palatina, mesial e distal. A linha precisa estar na mesma altura para não deixar a coroa torta

Marque as **faces mesial e distal com uma referência de aproximadamente 2 mm para desgaste inicial**. Essa redução ajuda a diminuir a largura do bloco e aproximá-lo da forma dental.

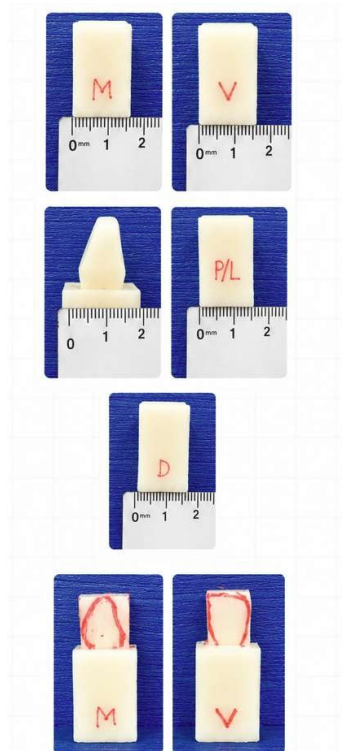
Marque as **faces vestibular e lingual ou palatina com aproximadamente 1 mm de desgaste**. Essa redução deve ser menor no início para preservar volume suficiente para bossas e convexidades.

Desenhe a **silhueta vestibular** do dente escolhido. Essa silhueta deve mostrar o contorno geral da coroa, incluindo região cervical e região incisal ou oclusal.

Desenhe também a **silhueta proximal**, indicando a inclinação da face vestibular e da face lingual ou palatina. Essa vista ajuda a controlar a espessura da coroa.

Confira se as duas silhuetas combinam entre si. A vista vestibular não pode contradizer a vista proximal, pois o dente deve ser pensado em três dimensões.

Reforce apenas as linhas principais e evite sulcos profundos. A marcação deve orientar o corte, não fragilizar o bloco.



ANOTAÇÕES

05

ESCULTURA DENTAL

Moldes

INCISIVOS

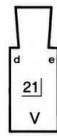


Fig. 47



Fig. 47



Fig. 58



Fig. 58

CANINOS

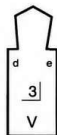


Fig. 70

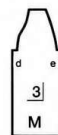


Fig. 70

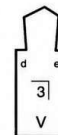


Fig. 80

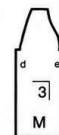


Fig. 80

PRÉ-MOLAR

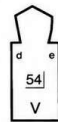


Fig. 130-A

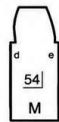


Fig. 130-A

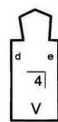


Fig. 130

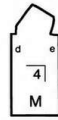


Fig. 132

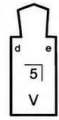


Fig. 129

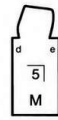


Fig. 133

MOLARES

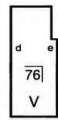


Fig. 173



Fig. 177

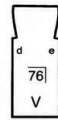


Fig. 191

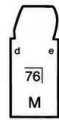


Fig. 193

ANOTAÇÕES

06

ESCULTURA DENTAL

Passo a passo geral

PONTOS-CHAVE

Escolha o dente que será esculpido e observe suas características principais. Antes de cortar, entenda se ele é anterior ou posterior, superior ou inferior, direito ou esquerdo.

Nomeie todas as faces do bloco com as letras correspondentes. Essa identificação deve permanecer visível durante boa parte do trabalho.

Meça a altura da coroa e trace a linha de referência cervical. Essa etapa define o limite entre a porção que será esculpida e a base do bloco.

Desenhe a silhueta principal na face vestibular. Essa silhueta deve representar o contorno geral do dente, incluindo largura cervical, largura incisal ou oclusal e inclinação das faces proximais.

Desenhe a silhueta proximal em uma das faces laterais. Essa marcação ajuda a definir a espessura do dente e a convexidade vestibular e lingual ou palatina.

Inicie o desgaste pelas faces mesial e distal, retirando camadas finas de cera. A mesial deve ser preservada mais plana e regular, enquanto a distal costuma apresentar maior arredondamento.

Faça o desgaste das faces vestibular e lingual ou palatina, sempre mantendo volume suficiente para formar bossas e detalhes anatômicos.

Arredonde as transições entre as faces. O dente natural não apresenta quinas rígidas como o bloco de cera; as bordas precisam ser suavizadas.

Marque e modele a linha cervical com curvatura suave. Ela não deve ser totalmente reta nem muito profunda.

Localize as bossas vestibular, lingual/palatina, mesial e distal. Essas áreas devem ser convexas, mas sem exagero.

Depois de obter a forma geral, comece os detalhes específicos do grupo dental, como borda incisal, cingulo, fossa palatina, cúspides, sulcos ou cristas marginais.

Faça acabamento progressivo com Lecron, Hollembach, escova macia e meia de seda. O acabamento deve alisar a cera sem apagar a anatomia.

Faça a conferência final observando todas as faces. Corrija pequenos excessos e verifique se o dente está proporcional e funcional.



ANOTAÇÕES

07

ESCULTURA DENTAL

Escultura dos Incisivos

Passo a passo dos incisivos superiores:

PONTOS-CHAVE

Identifique se será esculpido um incisivo central superior ou um incisivo lateral superior. O central deve ser mais largo e mais simétrico; o lateral deve ser menor e mais delicado.

Marque as faces do bloco com V para vestibular, P para palatina, M para mesial e D para distal. Essa etapa evita inversão da anatomia.

Meça a altura da coroa e marque a linha cervical. Nos incisivos superiores, a região cervical deve ser mais estreita que a região incisal.

Desenhe o contorno vestibular. No incisivo central, o contorno deve ser mais amplo; no incisivo lateral, mais estreito e arredondado.

Recorte o excesso das faces mesial e distal. Preserve a mesial mais reta e a distal mais curva, porque isso ajuda a reproduzir a anatomia natural.

Ajuste a face vestibular criando uma convexidade suave. Essa face não deve ficar plana, pois dentes naturais possuem volume gradual.

Modele a borda incisal, mantendo espessura suficiente. Uma borda muito fina pode quebrar e também fica artificial.

Marque a linha cervical de forma curva. A curvatura precisa ser suave e acompanhar a transição entre coroa e base.

Na face palatina, marque o cingulo no terço cervical. Ele deve ser uma elevação arredondada, não uma protuberância exagerada.

Desenhe as cristas marginais mesial e distal. Elas devem ir da região incisal em direção ao cingulo, delimitando a fossa palatina.

Escave a fossa palatina com movimentos leves. A escavação deve criar uma depressão anatômica, mas sem deixar a cera fina demais.

Suavize as transições entre cingulo, cristas marginais e fossa palatina. Essas estruturas devem se integrar naturalmente.

Passo a passo dos incisivos inferiores:

c

Escolha se será esculpido um incisivo central inferior ou um incisivo lateral inferior. O central é menor e mais simétrico; o

lateral é um pouco maior e menos uniforme. d

Marque as faces do bloco com V, L, M e D. Como se trata de dente inferior, utiliza-se L para lingual. d

Meça a altura da coroa e delimite a linha cervical. Nos incisivos inferiores, a coroa deve ser estreita e alongada. e

Desenhe o contorno vestibular com cuidado, evitando deixar o dente muito largo. A proporção estreita é essencial para representar esse grupo dental.

Realize o desgaste das faces mesial e distal em pequenas camadas. Como o dente é delicado, qualquer corte excessivo pode deformar o contorno.

Modele a face vestibular com convexidade suave. A superfície deve ser levemente arredondada, mas sem grande volume.

Defina a borda incisal de forma reta ou levemente inclinada, dependendo do dente escolhido. Ela deve ser fina, porém resistente.

Marque a linha cervical com curvatura discreta. Não faça uma depressão profunda, pois isso pode enfraquecer a base da coroa.

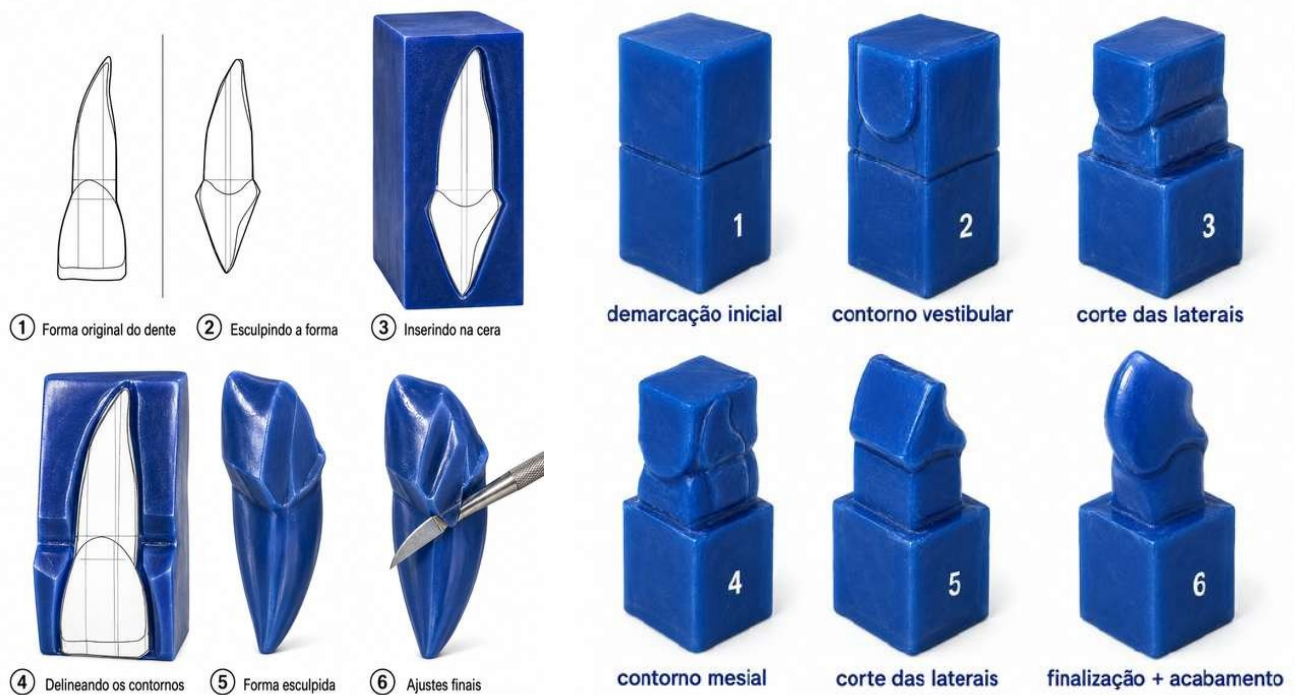
Na face lingual, marque um cingulo pequeno no terço cervical. Ele deve ser muito mais discreto que nos dentes superiores.

Modele as cristas marginais de forma leve. Elas devem aparecer como limites suaves, sem grande elevação.

Escave a fossa lingual apenas superficialmente. A face lingual os incisivos inferiores não deve ser profunda.

Arredonde os ângulos proximais com delicadeza. O dente não deve ficar quadrado nem com quinas evidentes.

Confira a escultura pela vista incisal. O dente deve parecer estreito, simétrico e proporcional.



ANOTAÇÕES

08

ESCULTURA DENTAL

Escultura dos Caninos

PONTOS-CHAVE

Defina se será esculpido um canino superior ou inferior. O superior deve ser mais volumoso e marcado; o inferior deve ser mais estreito e discreto.

Marque as faces do bloco com V, P ou L, M e D. Use P para canino superior e L para canino inferior.

Meça a altura da coroa e faça a linha cervical. O canino costuma ter coroa alongada e com região cervical bem definida.

Desenhe o contorno vestibular, deixando espaço para a ponta de cúspide. A cúspide não deve ficar centralizada de forma artificial; geralmente apresenta leve deslocamento para mesial.

Marque a vertente mesial e a vertente distal da cúspide. A vertente mesial costuma ser mais curta e a distal mais longa.

Realize o desgaste das faces mesial e distal. Preserve o volume central da coroa, pois o canino precisa parecer robusto.

Modele a face vestibular criando uma crista vestibular suave. Essa crista deve partir da ponta da cúspide e seguir em direção cervical.

Arredonde as áreas laterais da face vestibular. A transição entre crista e depressões deve ser natural, sem cortes bruscos.

Na face palatina ou lingual, marque o cingulo. No canino superior, ele deve ser mais evidente; no inferior, mais discreto.

Modele as cristas marginais mesial e distal. Elas ajudam a delimitar a anatomia interna da face palatina ou lingual.

Faça a crista mediana indo da ponta da cúspide até o cingulo. Essa estrutura é mais evidente no canino superior.

Escave levemente as depressões laterais da face palatina ou lingual. Não aprofunde demais para não fragilizar a cera.

Arredonde a ponta da cúspide. Ela deve ser visível e funcional, mas não excessivamente afiada.

Confira se o dente mantém aspecto forte, alongado e anatômico. O canino deve ter presença, mas sem exageros.



ANOTAÇÕES

09

ESCULTURA DENTAL

Escultura em Pré-Molares

Passo a passo dos pré-molares:

PONTOS-CHAVE

Escolha se será esculpido o primeiro ou o segundo pré-molar superior. O primeiro costuma ter anatomia mais marcada; o segundo tende a ser mais arredondado e equilibrado.

Marque as faces do bloco com V, P, M e D. A face palatina deve ser corretamente identificada para posicionar a cúspide palatina.

Meça a altura da coroa e delimite a linha cervical. Os pré-molares possuem coroa mais baixa que muitos dentes anteriores, mas com maior profundidade oclusal.

Desenhe a vista vestibular, marcando a cúspide vestibular e suas vertentes. A vertente mesial e a distal devem formar a ponta da cúspide.

Desenhe a vista proximal para controlar a altura da cúspide vestibular e da cúspide palatina. A vestibular geralmente é mais alta.

Faça o desgaste inicial das faces mesial e distal, respeitando o contorno proximal. Evite deixar o dente quadrado.

Ajuste a face vestibular, mantendo a bossa cervical e a inclinação em direção à cúspide.

Ajuste a face palatina, preservando volume suficiente para formar a cúspide palatina. Não desgaste demais essa região.

Na face oclusal, marque a posição da cúspide vestibular e da cúspide palatina. Elas devem estar separadas pelo sulco central.

Trace o sulco central no sentido méso-distal. Ele deve ser anatômico e controlado, sem profundidade exagerada.

Modele as vertentes internas das cúspides, direcionando-as suavemente para o sulco central.

Modele as vertentes externas, que descem em direção às faces vestibular e palatina.

Forme as cristas marginais mesial e distal. Elas devem fechar a face oclusal nas extremidades proximais.

Arredonde as pontas das cúspides. Elas não devem ficar agudas demais.



Fig. 9.1: Silhueta da face proximal.



Fig. 9.2: Projeção da face vestibular.



Fig. 9.3: Desenho da face vestibular após o recorte da projeção proximal.



Fig. 9.4: Marcação das linhas de bossa, linha de colo e as linhas longitudinais a partir das pontas de cúspides.



ANOTAÇÕES

10

ESCULTURA DENTAL

Escultura em Molares

Passo a passo dos molares superiores:

PONTOS-CHAVE

Defina se será esculpido o primeiro ou o segundo molar superior. O primeiro geralmente é maior e mais complexo; o segundo pode ser menor e mais simplificado.

Marque as faces do bloco com V, P, M e D. A face palatina é muito importante, pois nos molares superiores ela pode apresentar grande volume.

Meça a altura da coroa e faça a linha cervical. Os molares têm coroa mais baixa que dentes anteriores, porém são largos e volumosos.

Desenhe o contorno vestibular e proximal. A forma geral deve permitir espaço para a face oclusal ampla.

Faça o desgaste das faces mesial e distal, mantendo a mesial mais plana e a distal mais arredondada.

Ajuste a face vestibular criando convexidade cervical e volume adequado. Não deixe a face totalmente plana.

Ajuste a face palatina preservando volume suficiente, principalmente para a cúspide méso-palatina.

Na face oclusal, divida a área para posicionar as cúspides. Marque cúspide méso-vestibular, disto-vestibular, méso-palatina e disto-palatina.

Dê maior volume à cúspide méso-palatina, especialmente no primeiro molar superior. Ela costuma ser a cúspide mais robusta.

Trace os sulcos principais de forma suave. Eles devem separar as cúspides e conduzir a anatomia oclusal.

Modele a ponte de esmalte ou crista oblíqua, quando estiver esculpindo o primeiro molar superior. Essa estrutura une regiões importantes da face oclusal.

Esculpa as vertentes internas das cúspides voltadas para a face oclusal. Elas devem descer em direção às fossas e sulcos.

Esculpa as vertentes externas, que se direcionam para as faces vestibular e palatina.

Forme fossas e fôssulas como depressões rasas e anatômicas. Não aprofunde demais.

Arredonde as cúspides. Elas devem ser funcionais, mas não pontiagudas.

Faça acabamento sem apagar os sulcos principais, cristas marginais e cúspides.



Figura 22.6 – Desgaste das cúspides méso-vestibular e disto-lingual.

12. Fazer os planos inclinados da cúspide disto-vestibular com desgaste em direção ao sulco méso-distal, deixando a ponte de esmalte inclinada para o centro da face oclusal.
13. Marcar sulco secundário na cúspide méso-lingual, contínuo com ocluso-vestibular, sem romper a aresta longitudinal.
14. Fazer os planos inclinados da ponte de esmalte com desgaste em direção aos sulcos méso-distal e secundário.
15. Fazer os planos inclinados da cúspide méso-lingual com desgaste em direção ao sulco méso-distal.



Fig. 11.8: Vista oclusal do primeiro molar superior com as vertentes externas das cúspides concluídas, tanto as vestibulares quanto as linguais. Observar que além dos sulcos (Fig. 11.7), agora estão demarcadas as arestas. Note também a posição da ponte de esmalte que está centrada nas arestas que vão da ponta de cúspide vestibulo-distal à ponta de cúspide méso-lingual.

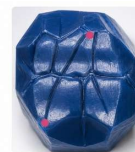


Fig. 11.9, 11.10 e 11.11: Detalhes da escultura das vertentes internas das cúspides mesiais do primeiro molar superior.

ANOTAÇÕES

11

ESCULTURA DENTAL

Contato e relações Anatômicas

PONTOS-CHAVE

Observe as faces mesial e distal da escultura. Elas não devem ser totalmente planas, pois dentes naturais apresentam convexidades proximais

Verifique a área onde estaria o ponto de contato proximal. Essa região deve estar no terço incisal ou oclusal, variando conforme o dente.

Confira se a face mesial está mais regular e se a distal apresenta maior arredondamento. Essa diferença ajuda na naturalidade da escultura.

Observe se há espaço anatômico para ameias. Mesmo em uma escultura isolada, o formato proximal deve sugerir a presença desses espaços.

Nos dentes anteriores, confira se a borda incisal está compatível com a função de corte. Ela não deve estar grossa demais nem fina a ponto de quebrar.

Nos dentes posteriores, confira se as cristas marginais estão bem posicionadas. Elas devem delimitar a face oclusal sem criar degraus artificiais.

Verifique as cúspides de suporte e de corte nos dentes posteriores. As cúspides devem ter altura e volume proporcionais ao grupo dental.

Observe a face oclusal e veja se os sulcos conduzem naturalmente para fossas e fósulas. Sulcos aleatórios prejudicam a anatomia.

Analise a escultura por todas as vistas. Um dente funcional deve ter harmonia vestibular, proximal, lingual/palatina e oclusal/incisal.

Corrija pequenos excessos antes do acabamento final.



Fig. 12.7



Fig. 12.8



Fig. 12.9



Fig. 12.10



ANOTAÇÕES

12

ESCULTURA DENTAL

Acabamento Final

PONTOS-CHAVE

Observe toda a escultura antes de iniciar o polimento. Identifique excessos, riscos profundos, áreas planas demais ou detalhes mal definidos.

Use a Lecron para suavizar transições entre as faces. O objetivo é remover irregularidades sem alterar a anatomia principal.

Use o Hollenback para limpar sulcos, fossas e fósulas. O instrumento deve ser usado com delicadeza para não aprofundar demais essas regiões.

Passe a escova dental macia sobre a cera com movimentos leves. Ela ajuda a uniformizar a superfície e remover pequenas rebarbas.

Utilize a meia de seda para dar brilho final. O movimento deve ser suave, sem pressão exagerada.

Se necessário, aplique uma pequena quantidade de talco para visualizar melhor sulcos e linhas anatômicas. Depois, remova o excesso.

Confira a vista vestibular. Veja se o contorno está correto, se a bossa vestibular está no local adequado e se a linha cervical está natural.

Confira a vista mesial e distal. Avalie se as faces proximais têm convexidade e se não ficaram retas demais.

Confira a vista lingual ou palatina. Nos anteriores, observe cingulo, cristas e fossa; nos posteriores, observe cúspides e sulcos.

Confira a vista incisal ou oclusal. Nos anteriores, veja a espessura da borda incisal; nos posteriores, observe cúspides, sulcos, cristas marginais e fossas.

Corrija apenas pequenos detalhes após o polimento inicial. Evite grandes cortes nessa fase, pois eles podem deixar marcas difíceis de remover.

Faça uma avaliação final comparando a escultura com a anatomia esperada do grupo dental escolhido.



ANOTAÇÕES